# KYUSHO

## ĐIỂM TẤN CÔNG TRONG TỰ VỆ VÀ VÕ THUẬT

*Stefan Reinisch · Juergen Hoeller · Axel Maluschka*

*Meyer & Meyer Sport, 2012*

*Bản dịch Việt ngữ song ngữ, dùng cho mục đích học tập cá nhân, phi thương mại. Sách trình bày các điểm tấn công (kyusho) trên cơ thể người theo từng vùng — đầu, cổ, thân mình, tay và chân — kèm mô tả giải phẫu, hiệu quả sinh lý và bình luận về cách sử dụng. Toàn bộ 703 hình minh họa của nguyên bản đã được trích xuất từ bản scan và tái bản tại đúng vị trí trong sách, nên các dòng như "1 Điểm mục tiêu. 2 Cách dùng." đi kèm hình tương ứng.*

CẢNH BÁO: Những kỹ thuật trong sách này có thể gây nguy hiểm và chỉ được luyện tập dưới sự giám sát của huấn luyện viên có chuyên môn, với các biện pháp an toàn phù hợp. Nhiều mục tiêu được mô tả (mắt, thanh quản, động mạch cảnh, tinh hoàn, các cơ quan nội tạng) có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

# Trang tựa & Thông tin xuất bản

*Title Page & Imprint*

# Kyusho

## Điểm tấn công trong tự vệ và võ thuật

Meyer & Meyer Sport

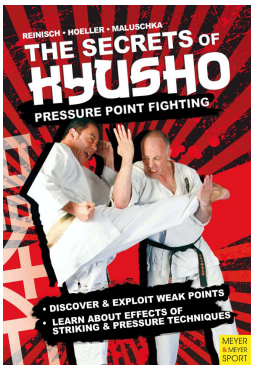
Tựa gốc: Kyusho – Angriffspunkte in Selbstverteidigung und Kampfsport. Aachen: Meyer & Meyer, tái bản lần thứ ba, 2012. Dữ liệu biên mục của Thư viện Anh (British Library Cataloguing in Publication Data). Bản ghi biên mục cho cuốn sách này có tại Thư viện Anh. Kyusho – Điểm tấn công trong tự vệ và võ thuật. Stefan

Reinisch, Juergen Hoeller & Axel Maluschka. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd., 2012. ISBN: 978-1-84126-361-8. Bảo lưu mọi quyền. Trừ trường hợp dùng cho mục đích phê bình, không phần nào của ấn phẩm này được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất, hay truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào đã biết hay về sau này phát minh ra, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản. Không được cho mượn, bán lại, cho thuê hay định đoạt cuốn sách này theo bất kỳ hình thức buôn bán nào, với hình thức, bìa hay gáy khác với bản đã xuất bản, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhà xuất bản.

© 2012 Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd. Auckland, Beirut, Budapest, Cairo, Cape Town, Dubai, Indianapolis, Kindberg, Maidenhead, Sydney, Olten, Singapore, Tehran, Toronto. Thành viên của Hiệp hội Nhà xuất bản Thể thao Thế giới (WSPA) www.w-s-p-a.org. In bởi: B.O.S.S Druck und Medien GmbH. ISBN: 978-1-84126-361-8. E-Mail: info@m-m-sports.com www.m-m-sports.com

# Các tác giả

*The Authors*



CÁC TÁC GIẢ

Stefan Reinisch (1970) là Dan 4 đẳng jiu jitsu. Ông dạy jiu-jitsu tại viện thể thao của Đại học Vienna, làm cố vấn cho các khóa huấn luyện hành vi và an toàn cho doanh nghiệp, đồng thời là giáo viên dạy tự vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Juergen Hoeller (1953) là huấn luyện viên thể lực và nhà trị liệu. Ông là Dan 3 đẳng taekwondo, Ashihira karate và jiu-jitsu; ngoài ra ông còn giữ nhiều đai đen ở judo và Combat Hapkido. Ông giảng dạy trong và ngoài nước, đồng thời là giảng viên đào tạo huấn luyện viên cho nhiều tổ chức thể thao khác nhau (taekwondo, judo, đấu kiếm). Ông là huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên karate và là tác giả sách.

Axel Maluschka (1972) là huấn luyện viên doanh nghiệp và là tác giả. Ông tập luyện nhiều môn võ khác nhau (Ashihira karate, taekwondo, jiu-jitsu, kickboxing) từ năm 1996 và là học trò của Juergen Hoeller. Ông là đồng tác giả của nhiều cuốn sách về võ thuật.

Kyusho — Điểm tấn công trong tự vệ và võ thuật

# Lời cảm ơn

*Acknowledgements*

Là những tác giả của một dự án chung, chúng tôi mang ơn những người sau đây:

- Harald Marek M.A. (Dan 4 jujitsu) vì công việc chụp ảnh công phu của ông.
- Cố vấn cấp cao, Tiến sĩ Mehdi Mousavi (Dan 5 jujitsu) vì đã viết lời tựa và dành cho cuốn sách một cái nhìn phản biện.
- Tiến sĩ Thomas Hausner (Dan 6 karate-đạo), chuyên gia phẫu thuật chấn thương và phẫu thuật viên tại UKH (Bệnh viện Tai nạn) Lorenz Böhler Vienna, vì những đóng góp về đám rối dương và đám rối tạng.
- Tiến sĩ Moritz Hawliczek (Dan 1 jujitsu) vì những tư vấn y khoa của ông.
- Peter Rötter (Dan 5 Shotokan karate), huấn luyện viên quản trị, luật sư, hai lần Á quân karate thế giới, vì đã hỗ trợ cho ảnh bìa.
- Sebastian Rudigier (Dan 1 jujitsu) vì đã làm người mẫu cho các ảnh bổ sung trong lần tái bản thứ hai.
- Alexandra Runge vì ảnh bìa.
- Benjamin Schmid vì đã làm “nạn nhân” cho các ảnh bổ sung trong ấn bản này.

Xin cảm ơn từng vị!

Stefan + Juergen + Axel

# Cảnh báo

*Warning*

Cuốn sách này có một số kỹ thuật có thể nguy hiểm và chỉ được tập luyện dưới sự giám sát của một huấn luyện viên hay giảng viên có trình độ. Tác giả và nhà xuất bản không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ chấn thương nào có thể xảy ra.

Cuốn sách này được viết chỉ với đại từ nhân xưng ở dạng nam giới. Để đơn giản, xin hiểu rằng cách dùng đó bao hàm cả nữ giới. Stefan Reinisch, Juergen Hoeller & Axel Maluschka

# Mục lục

*Contents*

**Lời tựa — Tiến sĩ Mehdi Mousavi** 8

**Lời tựa — Tiến sĩ Franz Knafl** 9

**Dẫn nhập** 11

**Kết quả của việc sử dụng Kyusho** 13

**1 Các điểm tấn công trên đầu** 18

1.1 Mắt 18

1.2 Cằm / Protuberancia mentalis 21

1.3 Khóe miệng 22

1.4 Xương mũi / Gốc mũi / Os nasale 23

1.5 Điểm dưới mũi 29

1.6 Dây thần kinh tai lớn / Nervus auricularis magnus 32

1.7 Dây thần kinh má / Nervus buccalis 34

1.8 Dây thần kinh trán / Nervus frontalis 39

1.9 Dây thần kinh dưới ổ mắt / Nervus infraorbitalis 43

1.10 Dây thần kinh cằm / Nervus mentalis 44

1.11 Môi trên 49

1.12 Tai 51

1.13 Tuyến mang tai / Parotis 55

1.14 Hộp sọ 59

1.15 Xương thái dương 63

1.16 Mấu trán / Tubera frontalia 67

1.17 Hàm dưới 70

1.18 Tuyến dưới hàm / Glandula submandibularis 73

1.19 Môi dưới 78
1.20 Tuyến dưới lưỡi / Glandula sublingualis 79
1.21 Má 80
1.22 Ổ răng 81
**2 Các điểm tấn công trên cổ** 83
2.1 Carotis / Động mạch cảnh chung 83
2.2 Gáy / Cột sống cổ 89
2.3 Hõm cảnh / Fossa jugularis 96
2.4 Cơ bên cổ / Musculus sternocleidomastoideus 101
2.5 Cơ bên cổ – điểm bám tận 105
2.6 Cơ bên cổ – hõm điểm bám tận 107
2.7 Thanh quản 111
2.8 Hõm xương đòn 113
2.9 Cơ thang / Musculus trapezius 114
**3 Các điểm tấn công trên thân mình** 118
3.1 Nách / Axilla 118
3.2 Xương ức / Sternum 120
3.3 Cơ ngực 124
3.4 Núm vú / Tuyến vú / Glandula mammaria 125
3.5 Tinh hoàn 126
3.6 Gan 131
3.7 Bẹn 134
3.8 Dạ dày 137
3.9 Lách 139
3.10 Cơ delta 141
3.11 Thận 144

3.12 Vùng thận / Các nếp da 147
3.13 Xương sườn 147
3.14 Xương đòn / Xương quai xanh 150
3.15 Đám rối dương / Plexus coeliacus 153
3.16 Xương cụt 156
3.17 Bụng dưới (Bàng quang, Ruột, Xương mu) 158
**4 Các điểm tấn công trên cánh tay** 160
4.1 Da của cánh tay 160
4.2 Cơ nhị đầu / Musculus biceps brachii 162
4.3 Cùi chỏ 164
4.4 Bàn tay 167
4.5 Cổ tay 169
4.6 Móng tay 172
4.7 Dây thần kinh giữa / Nervus medianus 174
4.8 Dây thần kinh quay / Nervus radialis 176
4.9 Dây thần kinh trụ / Nervus ulnaris 180
4.10 Mặt trong cánh tay trên 182
4.11 Cơ tam đầu – Hợp âm kết 184
**5 Các điểm tấn công trên chân** 186
5.1 Gân Achilles 186
5.2 Mu bàn chân 189
5.3 Da ở mặt trong đùi 191
5.4 Đầu gối 192
5.5 Hõm đầu gối 195
5.6 Dây thần kinh hông to / Nervus ischiadicus 198
5.7 Mặt ngoài đùi 200

5.8 Mặt trong đùi 204
5.9 Xương chày / Tibia 209
5.10 Bắp chân 214
5.11 Xương mác 216
**6 Các kỹ thuật đặc biệt** 220
**Phụ lục: Tài liệu tham khảo được đề xuất** 224
**Tài liệu tham khảo chú thích** 225
**Liên kết web** 226
**Lời cảm ơn về hình ảnh** 227
**Thông báo pháp lý** 228

# Lời tựa — Tiến sĩ Mehdi Mousavi

*Foreword — Dr. Mehdi Mousavi*

Những năm gần đây, võ thuật Viễn Đông ngày càng được ưa chuộng. Điều đó thể hiện ở vô số sách, tạp chí và tài liệu khác về bushido đang tràn ngập thị trường. Thế nhưng, nếu gạt phần kỹ thuật sang một bên mà tìm những công trình bàn về nguyên lý vật lý, về mô tả giải phẫu – sinh lý, hay thậm chí những khuyến nghị y học thể thao, người đọc sẽ nhanh chóng thất vọng. Chính những điểm này – những cái gọi là huyệt đạo – là thứ không thể học được nếu thiếu hiểu biết cần thiết về các dữ kiện giải phẫu và các cơ chế điều hòa sinh lý của cơ thể. Nhiều điểm trong số đó được dùng làm huyệt châm cứu để chữa bệnh, nhưng cũng có những điểm có

thể đe dọa tính mạng đối thủ. Chỉ khi người sử dụng hiểu rõ những dữ kiện ấy mới nảy sinh được tinh thần trách nhiệm cần thiết để đánh giá đúng tình huống và phản ứng thỏa đáng trước một cuộc tấn công.

Trong cuốn sách này, các tác giả đã cố gắng minh họa và giải thích những nền tảng giải phẫu của các huyệt đạo bằng chữ và hình. Cách dùng những điểm này trong tự vệ bằng cách ấn vào các vùng nhạy cảm, cùng những hiệu ứng kéo theo, đều được trình bày chi tiết. Sự nguy hiểm khi dùng các huyệt đạo này bắt nguồn từ những yếu tố y học. Lần đầu tiên, các tác giả đã làm được một công trình dựa trên cơ sở y học/khoa học, đáp ứng yêu cầu của người đọc không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật. Hơn nữa, cuốn sách còn là một tài liệu tra cứu cho người tập luyện, trình bày cách thức và vị trí mà những điểm ấn ấy đạt hiệu quả tốt nhất. Vì thế, cuốn sách này nên có mặt trong thư viện của mọi budoka.

Với bề dày tập luyện võ thuật của mình, tôi khuyên người đọc đừng coi nhẹ các điểm ấn và hãy thường xuyên luyện tập với chúng, bởi chỉ sự chính xác đúng mực khi thực hiện kyusho mới bảo đảm được một năng lực tự vệ tuyệt đối và hoàn hảo. “Kẻ cho rằng mình đã giỏi là kẻ đã ngừng cố gắng trở nên giỏi hơn.”

Tiến sĩ Mehdi Mousavi, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương và Chấn thương Thể thao, Trung tâm Y tế Xã hội Bệnh viện East-Donau ở Vienna. (Dan 5 jujitsu; Kawaishi Ryu)

# Lời tựa — Tiến sĩ Franz Knafl

*Foreword — Dr. Franz Knafl*

Với tư cách Tổng thư ký Liên đoàn Jujitsu Châu Âu (E.J.J.U.) và Chủ tịch Shobukai Áo, tôi lấy làm vinh hạnh được viết lời tựa cho lần tái bản thứ ba của cuốn Kyusho, cuốn sách bàn về những điểm nhạy cảm trên cơ thể người. Cuốn sách mang đến cho người đọc quan tâm một sự hiểu biết cùng cái nhìn tổng quan có tính giáo học, được cấu trúc tốt, về những điểm ấn và huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, đồng thời giải thích hiệu quả và những tác động khả dĩ của chúng.

Cuốn sách chuyên khảo này trình bày nhiều chuỗi tự vệ khả dĩ và mang đến cho mỗi người tập luyện những xung lực mới cho việc

luyện tập hằng ngày. Đồng thời, nó phá tan nhiều huyền thoại và cũng là một lời kêu gọi hãy nhìn chủ đề này bằng con mắt phản biện.

Dù phần mục lục và phần giải thích từng kỹ thuật có đề cập tới các điểm tấn công trên đầu, cổ, thân, tay và chân, mục tiêu vẫn rất rõ ràng: việc dùng kyusho chống lại kẻ tấn công trước hết là để phòng vệ.

Các tác giả và những cố vấn của họ đã có nhiều năm kinh nghiệm với các môn budo khác nhau. Là những người tập luyện nhiều môn võ Viễn Đông, họ nắm rõ nền tảng lý thuyết lẫn thực hành để ứng dụng kyusho một cách chính xác và đúng mục đích (tùy theo tình huống), nhờ chính sự tập luyện và trải nghiệm của bản thân về các hiệu ứng.

Cuốn giáo trình này rất thích hợp để mở rộng hiểu biết cho cả thầy lẫn trò. Tuy nhiên, nó không thể thay thế việc tập luyện cần thiết và có trách nhiệm cùng những giảng viên chuyên môn và những bạn tập đã được huấn luyện. Jujitsu, karate, taekwondo và các môn võ khác, muốn đúng đắn, đòi hỏi sự tập luyện không ngừng và suốt đời.

Tiến sĩ Franz Knafl, Dan 8 jujitsu Kawaishi Ryu, Tổng thư ký Liên đoàn Jujitsu Châu Âu, Chủ tịch Shobukai Áo, Trưởng khóa Jujitsu Nhật Bản tại Viện Thể thao Đại học Vienna (Universitäts-Sportinstitut Wien)

# Dẫn nhập

*Introduction*

“Tuyệt kỹ chưởng ngũ điểm xuyên tim” trong phim Kill Bill, Tập 2 (2004) của Quentin Tarantino, Enter the Dragon (1973) với Lý Tiểu Long, v.v.

Mỗi khi nói đến võ thuật châu Á, sớm hay muộn người ta cũng nhắc tới những kỹ thuật bí truyền chỉ được truyền lại cho những học trò giỏi nhất của các bậc tông sư. Huyền thoại về “cái chạm tử thần” chỉ có thể ra đời trên nền tảng sự thiếu hiểu biết của người thường về giải phẫu cơ thể người – một điều rõ ràng chưa hề thay đổi là bao theo thời gian.

Dù hiểu biết của chúng ta về cấu tạo cơ thể người đã tăng lên, trong nhiều cuốn sách về võ thuật, phần giải thích về tác động của các kỹ thuật đánh và ấn khác nhau vẫn chỉ thu gọn trong mấy chữ “gây đau, gây liệt, gây chết”. Thiếu hẳn phần giải thích. Chỉ xét từ góc độ trách nhiệm cá nhân với bạn tập (và từ góc độ pháp lý), sẽ rất đáng mong mỏi nếu những người theo học võ thuật tìm hiểu sâu hơn về hậu quả y học có thể có của hành động mình làm.

Độ trễ của hiệu ứng sau một số hành động tất nhiên là một phần lý do tạo nên vầng hào quang bí ẩn cho khía cạnh này của võ thuật. Nhưng một mặt, như mọi bác sĩ phẫu thuật chấn thương đều biết, hiện tượng triệu chứng xuất hiện muộn hơn thời điểm sự việc xảy ra một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn tổn thương nội tạng sau một cú đá). Mặt khác, một kỹ thuật chỉ phát huy hiệu ứng sau một độ trễ thì trong tình huống tự vệ thực sự cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Dẫu vậy, những huyền thoại như thế sẽ không bao giờ chết, đơn giản vì hiệu ứng lôi cuốn mà chúng tạo ra.

Mọi hành động phòng vệ (bất kể môn võ cụ thể nào) đều nhắm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể (trong tiếng Nhật gọi là “kyusho” – trong võ thuật Trung Quốc gọi là “dim-mak”) nhằm làm

đối thủ mất khả năng hành động càng nhanh càng tốt. Trước mắt, các hành động ấy chủ yếu nhằm đưa kẻ tấn công vào một thế mà hắn sẽ dễ bị tổn thương trước các đòn tiếp theo. Trong khi các kỹ thuật đòn bẩy tác động lên khớp và có thể được dùng với mức độ (gây đau hay gây thương tích) tương ứng và có kiểm soát, thì việc dùng các kỹ thuật đánh, đá, ấn khác nhau lại thường không dễ kiểm soát đến vậy. Hiệu ứng phụ thuộc vào: thể trạng của đối thủ (có thể xảy ra chuyện những cô gái mảnh mai lại không nhạy cảm với cơn đau do kỹ thuật ấn lên thần kinh gây ra, trong khi những người đàn ông lực lưỡng lại gục xuống sàn như bị sét đánh); những chấn thương có sẵn từ trước; loại quần áo đang mặc (chẳng hạn một chiếc áo khoác mùa đông dày); độ chính xác khi thực hiện kỹ thuật; góc tấn công; lực của cú đánh/cú đá/cú ấn; việc hành động ấy có gây bất ngờ cho đối thủ hay không. Ví dụ, các đòn đánh vào những dây thần kinh nằm trong vùng cơ đang căng thì đương nhiên là khó.

Trên cơ thể người có nhiều điểm dễ bị tổn thương. Một số được gọi là điểm thần kinh, một số khác tác động lên các cơ quan không được mô cơ hay xương che chở, trong khi ở những trường hợp khác lại là những điểm yếu mang tính cơ học. Có điểm mở đường cho một đòn tiếp theo, có điểm lại kết thúc cuộc tấn công.

Các hiệu ứng trải rộng, từ đau đớn hay thương tích ngoài da cho tới tử vong. Hiệu ứng trên mỗi điểm hoàn toàn khác nhau (còn chịu ảnh hưởng của việc điểm ấy có dễ tiếp cận hay không), và đó là lý do vì sao một số vùng mục tiêu được liệt kê ở đây lại đáng quan tâm theo quan niệm “toàn thể” của budo – còn trong thi đấu/giao đấu thì chúng chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Nếu dẫu vậy bạn vẫn còn hoài nghi về sự liên quan của kyusho trong võ thuật thể thao, hãy nghĩ đến việc một võ sĩ quyền Anh cũng nhắm đánh vào những điểm yếu của đối phương (cằm, gan và đám rối dương). Trong khi đó, những cú đấm vào thận, vào gáy hay vào hạ bộ lại bị cấm, vì trong khuôn khổ một cuộc thi đấu thể thao chúng bị coi là quá

nguy hiểm. Như một nguyên tắc chung, những kỹ thuật hữu hiệu có trước (chẳng hạn đòn bẩy) có thể được bổ sung bằng kyusho, khiến hiệu quả của chúng tăng thêm. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để sự hào hứng đi quá xa tới mức làm hại độ tin cậy của kỹ thuật (theo kiểu "Với một cái búa thì vấn đề nào cũng trông như cái đinh"). Những đối thủ nguy hiểm nhất là những kẻ có thể biến cơn đau thành hung hãn hay thành sức mạnh. Kyusho chỉ có ý nghĩa khi được dùng kết hợp với các kỹ thuật võ thuật khác. MẸO: Nếu việc tìm điểm có phần khó khăn, sẽ có lợi nếu tìm nó trên chính cơ thể mình và cảm nhận cấu trúc của nó. Tìm điểm trên cơ thể bạn tập thì dễ hơn một chút. Ngoài ra, người ta cũng rất nhanh học được cách phân biệt những cảm giác đau khác nhau (ví dụ đau ở dây thần kinh nào hay cơ nào). Để đánh dấu các vùng mục tiêu, những miếng dán gọi là "target plaster" tỏ ra hữu ích trong tập luyện.

# Kết quả của việc sử dụng Kyusho

*The Results of Using Kyusho*

## Đau

Trong phần lớn trường hợp, cần khiến đối thủ dừng một hành động cụ thể bằng cách gây đau (chẳng hạn làm hắn nới lỏng tay nắm). Sau hành động đó là cơ hội tạo ra những "lỗ hổng" cho các đòn tiếp theo. Đôi khi cơn đau chỉ là hệ quả phụ (chẳng hạn khi trật khớp).

Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Đau[1] định nghĩa đau như sau:

> "Đau là một trải nghiệm cảm giác và cảm xúc khó chịu gắn với tổn thương mô thực tế hoặc tiềm tàng, hay được mô tả bằng những thuật ngữ chỉ tổn thương như vậy."

Cảm nhận giác quan được các thụ thể đau (thụ thể nhận cảm đau) truyền đi theo những đường thần kinh chuyên biệt và qua đồi thị tới hệ thần kinh trung ương, từ đó sinh ra cảm giác đau.

Sự phân bố các thụ thể này trên bề mặt cơ thể thay đổi tùy theo vùng (tới 200 thụ thể trên mỗi xăng-ti-mét vuông da). Hơn nữa, người ta cũng tìm thấy thụ thể đau trong cơ và trong lớp lót của ruột; còn bản thân ruột, cũng như não, không có thụ thể đau.

Một số kỹ thuật kyusho tác động lên dây thần kinh và có thể gây ra những tín hiệu không kiểm soát được (chẳng hạn cảm giác châm chích ở bên ngón út của bàn tay khi dây thần kinh trụ bị kích thích). Ngoài ra, tác động cơ học lên dây thần kinh còn có thể gây tổn thương mô của chính dây thần kinh cũng như bao dây thần kinh. Bên cạnh đó, áp lực lên những dây thần kinh này có thể gây rối loạn tuần hoàn cục bộ và có giới hạn, kéo theo rối loạn chuyển hóa dẫn tới cơn đau dữ dội. Điển hình là cảm giác dễ chịu nhanh chóng khi nguyên nhân cơ học được loại bỏ. Một biến chứng khả dĩ là viêm dây thần kinh (viêm thần kinh).

Cơn đau do một tác động gây ra được gọi là đau thần kinh và lan ra khắp vùng do mỗi dây thần kinh chi phối (vùng phân bố thần kinh).

Dây thần kinh tương ứng càng bị kích thích thường xuyên thì nó càng phản ứng nhạy hơn với kích thích, và do đó cảm giác đau nhắm đúng chỗ cũng tăng lên. Không phải mọi tổn thương thể chất đều dẫn tới đau. Đó là nhờ các quá trình lọc trong hệ thần kinh trung ương (những tổn thương do tai nạn giao thông, thi đấu, chiến tranh hay trong lúc giao hợp thường không được nhận ra)[2], trong khi ngược lại, vẫn có thể có đau mà không hề có tổn thương thể chất (chẳng hạn đau ma).

## Đau dẫn tới bất tỉnh

Đau không chỉ là kết quả của tổn thương thể chất, mà còn có thể dẫn tới bất tỉnh. Hiện tượng này gọi là ngất do phản xạ mạch – phế vị (nguyên nhân khác có thể là lo lắng, vui sướng hay những loại hưng phấn khác; còn gọi là "hội chứng boygroup").

Nguyên nhân là sự phản ứng thái quá của hệ thần kinh thực vật. Các mạch máu giãn ra khiến máu (trước hết) "thoát" vào ruột, gây tình trạng thiếu khối lượng tương đối kèm nhịp tim chậm lại, do lượng máu hồi lưu về tim qua tĩnh mạch giảm. Mặt khác, nó dẫn tới giảm nhịp tim, thậm chí ngừng tim. Kết quả là nguồn cung máu và/hoặc oxy cho não giảm nói chung, kéo theo ngất. Ngất do phản xạ mạch – phế vị dẫn tới tử vong được gọi là ngừng tim do phản xạ. Những nguyên nhân khác của kiểu trụy tuần hoàn gây chết người này (đặc biệt liên quan tới võ thuật) có thể là: hội chứng xoang cảnh sau một cú đánh vào động mạch cảnh ở cổ, phản xạ tim – mắt sau một cú đánh vào mắt, một cú đánh hay cú đá vào đám rối dương, hoặc một cú đá vào tinh hoàn. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: bất tỉnh do chấn thương sọ não hoàn toàn khác với ngất do phản xạ mạch – phế vị!

## Hiệu quả của châm cứu

Hãy xét những hiệu quả khả dĩ gắn với châm cứu và các huyệt trên kinh lạc. Chính ở lĩnh vực này, giữa các chuyên gia võ thuật lại tồn tại nhiều tranh cãi. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn những góc nhìn khác nhau. Một ví dụ: ở Đức, công ty bảo hiểm y tế chấp nhận chi trả chi phí châm cứu cho bệnh nhân đau đầu gối và đau lưng. Quyết định của cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia dựa trên các nghiên cứu do Charité-Universitätsmedizin Berlin thực hiện trên một mô hình gồm 250.000 người thử và 10.000 bác sĩ (tới nay là nghiên cứu lớn nhất về châm cứu ở Đức). Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ thành công của châm cứu Trung Quốc cổ truyền (hay TCM, y học cổ truyền Trung Quốc – châm cứu "chính thống") trong điều trị đau lưng mạn tính không cao hơn bao nhiêu so với châm cứu "giả" (châm cứu placebo), tức là khi các điểm "sai" được "châm". Tuy nhiên, cả hai hình thức châm cứu đều cho thấy thành công rõ rệt hơn hẳn so với liệu pháp tiêu chuẩn.

Nói ngắn gọn, châm cứu thực sự có tác dụng. Việc châm kim vào đâu dường như không đóng vai trò đáng kể.

Vậy nên chúng ta đi tới câu hỏi: hiệu quả ấy dựa trên cơ sở nào? Đây chính là lúc hiệu ứng placebo[3] phát huy vai trò. Tiến sĩ Michael Freissmuth, giáo sư đại học trong ban lãnh đạo Viện Dược lý thuộc Đại học Y Vienna, coi đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của "cách ứng xử bên giường bệnh" của thầy thuốc. Điều này cũng tương tự với những phát biểu của Tiến sĩ Fabricio Benedetti, một nhà thần kinh học ở Turin, khi ông cho rằng bối cảnh mà bệnh nhân được điều trị mới là điều then chốt. Cách ứng xử của thầy thuốc có thể tác động lên hóa học của não, đến mức gây ảnh hưởng tích cực lên toàn bộ cơ thể.[4] Hiệu ứng placebo không chỉ đơn thuần là một hiện tượng tâm lý ("ảo giác"). Trái lại, người ta có thể đo được những biến đổi sinh học cụ thể trong cơ thể do nó gây ra.

Tất nhiên, có thể gợi ra nhiều sự tương đồng giữa vị "giáo sư" trong chiếc áo blouse trắng và vị "đại sư phụ" với chiếc đai đen.

Nhiều võ sư thậm chí còn cho rằng họ có thể tạo ra một cú knock-out từ "khoảng cách" mà không cần chạm vào đối thủ.[5] Có lẽ người ta có thể hình dung một nhà truyền đạo trên truyền hình Mỹ nhảy nhót giữa đám đông tín đồ rồi đặt tay lên người kế bên, kẻ ấy gục xuống đất như bị Chúa Thánh Thần giáng xuống (xem hội chứng "boygroup" ở trang trước). Nghi lễ, biểu tượng và uy quyền đều đóng vai trò lớn trong lĩnh vực này. Nếu không thì vì sao bác sĩ lại vội vã đi lại với ống nghe lủng lẳng trên cổ? Điều đó có tác dụng y như tiếng lục lạc của ông thầy pháp hay chiếc đai đỏ/trắng của vị võ sư cao cấp: "Người này là một uy quyền – tôi đã cảm nhận được hiệu ứng rồi!"

Mức độ mà niềm tin vào uy quyền cảm nhận được ấy có thể đi xa tới đâu đã được thể hiện ấn tượng qua thí nghiệm Milgram kinh điển năm 1961 (đáng buồn thay, từ đó tới nay nó đã được lặp lại nhiều lần và vẫn cho kết quả như cũ). Tuy nhiên, hành vi của nhóm khác hay của các bạn tập cũng có ảnh hưởng mạnh lên hành vi của chính mình ("củng cố xã hội").

Mặt khác, có những người theo cách làm việc với "ki" (hay "chi"), với các trường năng lượng âm dương. Tuy nhiên, những khái niệm Viễn Đông ấy luôn phải được nhìn trong bối cảnh văn hóa của chúng. Người chưa có kinh nghiệm về giải phẫu sẽ mô tả cơn đau khi đập vào "khủy tay thần kinh" – chính xác hơn là "dây thần kinh trụ" – như một dòng chảy năng lượng. Âm và dương cũng có nét tương đồng trong thần kinh học qua hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm.[6] Lý do khiến người ta chuyên dùng các điểm thần kinh trong võ thuật, thường đánh vào nhiều điểm cùng lúc hoặc lần lượt (ví dụ xin xem sách của George Dillman và Michael Kelly), nằm ở chỗ việc kích thích tạo ra hiệu ứng cộng gộp và do đó làm tăng hiệu quả.[7] Hậu quả nảy sinh từ đó hoàn toàn ấn tượng vì tác động lên các cơ quan nội tạng. (Về nền tảng thần kinh của vấn đề này, chúng tôi khuyên đọc cuốn Death Touch: The Science Behind the Legend of Dim-Mak của Tiến sĩ Michael Kelly.)

Tuy nhiên, đây chính là chỗ người tập luyện gặp bất lợi: làm sao tập luyện một cách thực chất được với một môn võ mà mục tiêu chính là làm đối thủ bất tỉnh, suy tim hay lên cơn đau tim? Khả năng thử nghiệm hiệu quả của những kỹ thuật ấy trên tù nhân – như người ta kể rằng các "bậc thầy" nhiều năm về trước đã làm – nay may thay không còn nữa. Ngay cả một cú "knock-out đơn giản", như thường thấy trong nhiều khóa học về kyusho/dim-mak, cũng có thể để lại hậu quả chết người nếu người bị đánh có sẵn khuyết tật về sức khỏe.[8] Nếu muốn đứng về phía đúng của các quy tắc pháp lý và đạo đức, kiểu tập luyện này phải mãi chỉ là lý thuyết.[9] Cũng không được coi nhẹ những khó khăn thực tế: hiệu quả phải cao hơn nhiều khi nhiều điểm thần kinh được kích thích. Điều đó có thể lên tới một tổ hợp năm kỹ thuật (nghe có quen không?) mà tất cả đều phải được thực hiện đúng trình tự và định vị chính xác. Những khả năng và lý lẽ ấy tất nhiên rất hấp dẫn, nhưng tính khả dụng thực tế thì đáng ngờ.

*Một mặt, có ý kiến cho rằng các hiệu ứng là tâm lý · và mặt khác là sinh lý:*

## Phản xạ căng cơ

Thoi cơ là những thụ thể cảm giác (gọi là "thụ thể bản thể") nằm trong cơ, chủ yếu phát hiện những thay đổi về độ dài của cơ ấy. Chúng cũng bảo vệ cơ khỏi bị kéo căng quá mức. Khi cơ bị kéo căng đột ngột, cái gọi là "phản xạ căng cơ" được kích hoạt và cơ co lại. Tác động kéo căng càng đột ngột thì càng nhiều sợi cơ trong thoi cơ được huy động, và lực chống lại sự kéo căng của cơ càng lớn. Cái gọi là cơ quan gân Golgi cũng góp phần vào đó bằng cách truyền đi những thay đổi về lực căng trong gân.

Ví dụ: Một người ngủ gật và đầu gục về phía trước. Cùng lúc đó, đầu giật ngược lên trên do các cơ cổ bị kéo căng đột ngột. Một ví dụ khác là phản xạ đầu gối khi gõ bằng chiếc búa nhỏ của thầy thuốc.

Đặc biệt trong trường hợp của chúng ta, các kỹ thuật đánh của mình được khuếch đại bởi kiểu phản xạ này, và chúng có thể đi kèm cơn đau thần kinh tùy hoàn cảnh.

### Ví dụ:

Một cú đánh vào mặt ngoài cẳng tay dưới (xem chi tiết ở phần tương ứng) tác động lên dây thần kinh quay, dây chịu trách nhiệm cho động tác duỗi các ngón tay. Phản xạ căng cơ kích hoạt những cơ cũng chịu trách nhiệm cho động tác của các ngón tay, nên bàn tay mở ra hoặc ít nhất là bị yếu đi. Một cú đánh vào cơ nhị đầu (xem chi tiết ở phần tương ứng) khiến cánh tay gập lại cùng với quán tính. Một cú đánh vào điểm bám của cơ ức đòn chũm (xem chi tiết ở phần tương ứng) và vào xương thái dương làm đầu lắc mạnh ít nhất cũng ngang với khi bị đánh vào xương (mỏm chũm).

Để có cái nhìn tổng quan tốt hơn, cách tốt nhất đã được chứng minh là chia các vùng tấn công thành năm khu vực, gồm đầu, cổ, thân, tay và chân. Những mục tiêu dễ tiếp cận nhất nằm ở đầu và quanh cổ – đó là lý do chúng tôi bắt đầu với các vùng này.

Một lưu ý trước: việc đánh giá tính khả dụng thường được thực hiện mà không tính đến các khía cạnh pháp lý hay đạo đức.

# Chương 1 — Các điểm tấn công trên đầu

*Chapter 1 — Attack Points on the Head*

## 1.1 Mắt

Đây là những mục tiêu được bản năng của chúng ta che chắn (như tinh hoàn), đến mức chỉ một động tác giả hướng về phía chúng (phản xạ che bằng tay) cũng đủ khiến đối phương phản ứng và thường mở ra cơ hội cho các đòn tiếp theo. Điều này gần như không cần minh họa.

Tấn công: Hiệu quả được tạo ra bằng cách ấn hoặc chọc bằng các ngón tay, nhưng cũng có thể thực hiện bằng một cú đấm.

2 Khống chế cùi chỏ. Cùi chỏ được ép vào trong và xuống dưới về phía thân đối phương.

Hiệu quả: Những vết dập nặng ở nhãn cầu dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho cấu trúc bên trong mắt: xuất huyết nội nhãn do tổn thương mạch máu; tăng nhãn áp (có thể gây ra vấn đề glôcôm); rách mống mắt (đồng tử không còn tròn); mờ hoặc lệch thủy tinh thể; rách võng mạc với nguy cơ bong võng mạc; phù võng mạc gây giảm thị lực và tổn thương dây thần kinh thị giác.

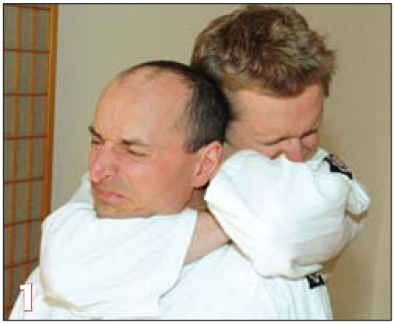
Tác động của một cú đánh hoặc sức ép lên dây thần kinh thị giác (nervus opticus) có thể gây ảnh hưởng dây chuyền lên hệ thần kinh, dẫn đến giảm nhịp tim, bất tỉnh và/hoặc ngừng tim. Hiện tượng này còn được gọi là phản xạ mắt–tim (oculocardiac reflex) hay hiện tượng Aschner. Khi bị đánh, cũng có thể xảy ra gãy các cấu trúc xương ổ mắt bao quanh nhãn cầu, kèm tổn thương thần kinh và mạch máu (cũng có thể dẫn đến giảm thị lực nếu nhãn cầu

bị lệch).

Tuy nhiên, việc móc hốc mắt (tiếng Latinh: orbita) bằng các ngón tay gần như là không thể. Các tác động khác có thể kể đến: chảy nước mắt không kiểm soát (dù điều này có thể làm giảm thị lực), đau đớn và cuối cùng là bất tỉnh (do đau).

Tác động gián tiếp: khi nhãn cầu (tiếng Latinh: bulbus) bị chèn ép, có thể xảy ra bong võng mạc. Hệ quả là người bị đánh tạm thời nhìn thấy những đốm trắng nhấp nháy trong thị trường, rồi sau một thời gian chúng biến mất. Trong cách nói dân dã, người ta gọi đó là "đom đóm trước mắt", hay nhìn thấy "sao" hoặc những đốm "nhảy múa" trước mắt.

Bình luận về cách dùng: Xét về hiệu quả đạt được với mức dùng lực tối thiểu và tính hiệu quả, đây là những mục tiêu hạng nhất. Thể trạng của đối phương không quan trọng. Đòn này có thể dùng trong phạm vi tay với tới.




## Các biến thể:

- 1 Tấn công bằng Ushiro jime (khóa siết bằng hõm khuỷu tay).
- 2 Phòng thủ bằng cách dùng hai ngón cái ấn vào mắt.

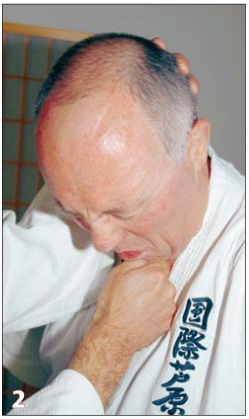
### Các biến thể:

- 1 Tiếp xúc với cánh tay đang tấn công.
- 2 Cánh tay đối phương đóng vai trò thanh dẫn hướng cho cánh tay phòng thủ trượt lên trên, để chọc ngón tay như ngọn giáo vào mắt đối phương.

## 1.2 Cằm / Protuberancia mentalis

Protuberancia mentalis là phần lồi hình tam giác của xương cằm.

Tấn công: Ấn bằng khớp ngón cái (đầu ngón cái phải tựa chặt vào ngón trỏ).



- 1 Điểm mục tiêu.
- 2 Cách dùng. Đầu ngón cái ấn vào điểm trên cằm. Bàn tay còn lại giữ phía sau đầu.
- 3 Cận cảnh.

Hiệu quả: Đau (màng xương, tức màng da, rất nhạy cảm với đau)

Bình luận về cách dùng: Chỉ dùng như một đòn giải thoát – cần có các đòn tiếp theo sau đó.

## 1.3 Khóe miệng

Tấn công: Móc ngón tay vào một hoặc cả hai bên khóe miệng rồi kéo ra ngoài.

- 1 Giải thoát khỏi thế khóa quàng (Kesa Gatame).

Hiệu quả: Đau, rách môi.

Bình luận về cách dùng: Giải thoát khỏi thế khóa nêu trên một cách đáng tin cậy; có nguy cơ gây hại cho chính mình (răng!).

### Biến thể:

- 1 Tấn công đồng thời vào mắt và khóe miệng.

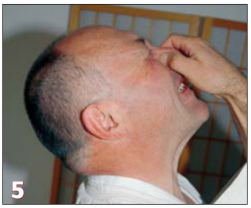
## 1.4 Xương mũi / Gốc mũi / Os nasale

Minh họa – xem phần “Hộp sọ”.

Xương mũi nằm ở phía trước hộp sọ, đại khái ngay tại vị trí gọng kính nằm. Xương mũi đặc biệt mỏng và nhô ra khỏi mặt hộp sọ gần như không được che chắn.

Tấn công: Đánh (bằng nắm đấm, đấm búa, gò bàn tay, cạnh bàn tay, cùi chỏ). Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp như kéo để ấn, nhưng tập trung nhiều hơn vào vùng đầu sụn nằm dưới xương mũi.

1 Điểm mục tiêu. 2 Tấn công bằng gò bàn tay. 3 Tấn công bằng đấm búa. 4 Thế kẹp kéo dùng khớp đốt ngón tay. 5 Cách dùng. 6 Từ một góc nhìn khác. 7/8 Thế kẹp kéo dùng khớp đốt ngón tay. 9 Cách dùng.



Hiệu quả: Ngay cả những cú đánh nhẹ cũng có thể gây gãy xương mũi và sụn mũi. Hậu quả là đau dữ dội (các dây nervi ethmoidales posterior và anterior truyền cảm giác cho niêm mạc mũi và đầu mũi), mắt bắt đầu chảy nước (hạn chế tầm nhìn). Nếu mũi chảy máu, máu có thể chảy vào họng và trong trường hợp cực đoan sẽ chặn đường thở.

Hơn nữa, khi mũi bị đánh, phần sụn của vách ngăn mũi có thể trượt ra khỏi rãnh xương định vị (bán trật khớp). Người ta vẫn truyền nhau rằng một cú đánh vào mũi có thể "đẩy" xương mũi vào trong não.

Cũng có thể xảy ra tổn thương các xoang kèm nhiễm trùng về sau. Xem thêm phần "Hộp sọ". Đây là những thương tích điển hình của một trận "ẩu đả", không nhất thiết phải chấm dứt đòn tấn công, tùy theo khả năng chịu đòn của đối phương. Trong một đòn tấn công có dùng sức ép, cần phản đòn bằng tay kia (gáy, ngực và phần thắt lưng của cột sống).

## Bình luận về cách dùng:

## Ví dụ:

- 1 Kẹp kéo mũi kết hợp với việc ngả lưng ra sau.
- 2 Phòng thủ trước một đòn đấm.
- 3 Cánh tay phòng thủ đưa lên để kẹp kéo mũi đối phương.
- 4 Kẹp kéo trong khi khống chế cổ.

- 9 Dùng một cú đá vào mặt trong khớp gối của đối phương, cánh tay tấn công bị duỗi thẳng và nhờ đó có thể áp dụng đòn bẩy tay.

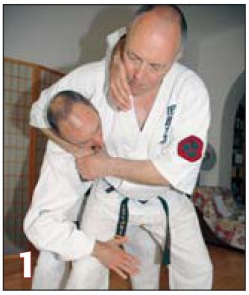
- 1 Phòng thủ trước đòn đấm.
- 2 Ấn bằng ngón cái vào một bên cạnh xương mũi.
- 3 Cận cảnh.
- 4 Khống chế và quật ngã.

## 1.5 Điểm dưới mũi

Minh họa – xem phần “Hộp sọ”.

Thuật ngữ giải phẫu để chỉ rãnh dọc giữa môi trên và mũi là philtrum (nhân trung). Ở đầu trên, rãnh này kéo dài tới gặp sống mũi (columella – tiếng Latinh: “cột nhỏ”) tạo thành góc mũi–môi. Cơn đau phát sinh từ các thụ thể đau tại chỗ.

Tấn công: Đánh hoặc ấn bằng cạnh bàn tay/ngón cái.



- 3 Bắt đầu giai đoạn duỗi người.
- 5 Khóa đối kháng và ấn vào đùi. Ghì chặt thân người để ngăn đối phương thoát.

- 8 Tư thế khống chế, kéo duỗi đối phương.

Hiệu quả: Khi dùng đòn đánh, hậu quả nhẹ hơn là rách môi và gãy rụng răng. Cũng có thể gãy xương hàm trên (maxilla) cũng như làm bật vách ngăn sụn mũi ra khỏi rãnh xương của nó. Với những cú đánh mạnh, các hậu quả thương tích thường gặp ở hộp sọ (xem phần “Hộp sọ” tiếp theo) đều có thể xảy ra, như với bất kỳ cú đánh nào vào đầu. Máu và răng gãy có thể lọt vào đường thở và cản trở hô hấp.

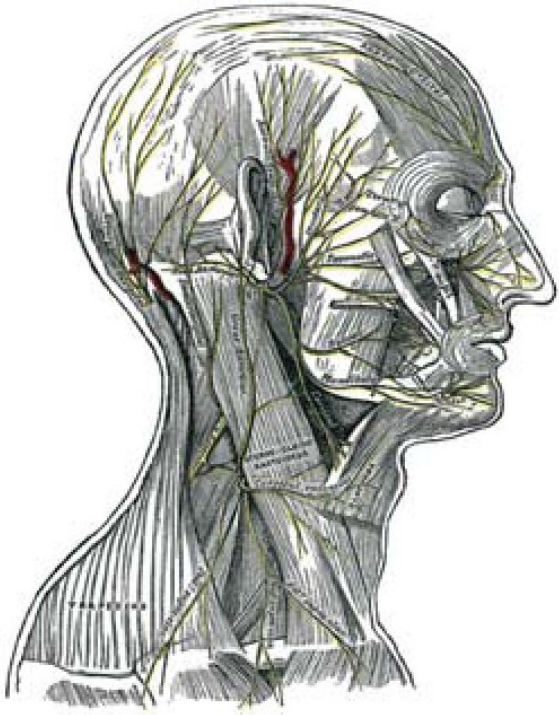
Khi có sức ép tác động, có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Có nguy cơ gây thương tích cho chính mình (răng). Trong một đòn tấn công dùng sức ép, cần khóa đối kháng bằng tay kia (trên cổ, ngực hoặc cột sống thắt lưng).

### Các trình tự bổ sung:

- 1 Kéo duỗi người đồng thời ghì chặt cánh tay của người phòng thủ vào thân.
- 3 Tiếp diễn của đòn quật gạt ngoài lớn (O-soto-gari).
- 6 Kết thúc.

## 1.6 Dây thần kinh tai lớn / Nervus auricularis magnus

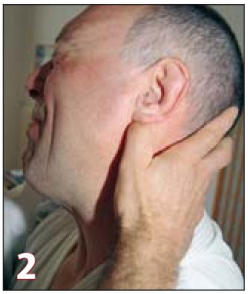


Sơ đồ 1 Vị trí: Phía sau dái tai, ở phần sau xương hàm.

Tấn công: Dùng ngón tay ấn hướng lên trên, theo hướng tới tâm hộp sọ (kiểm soát tốt hơn khi ấn ở một bên trong khi lòng bàn tay kia giữ đầu.) Quật ngã. Mẹo: Ấn theo kiểu xoay, khoan và miết theo hướng tới tâm đầu thì tốt hơn là ấn liên tục, vì cơ thể thích nghi kém hơn với cơn đau không liên tục.

Điểm mục tiêu. Hiệu quả: Khi có sức ép tác động, có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người.



4 Đối phương bị quật xuống đất. 7 7 Đòn kết thúc dùng gò bàn tay.

## 1.7 Dây thần kinh má / Nervus buccalis

Sơ đồ 2 So sánh với sơ đồ trong phần “Nervus frontalis”.

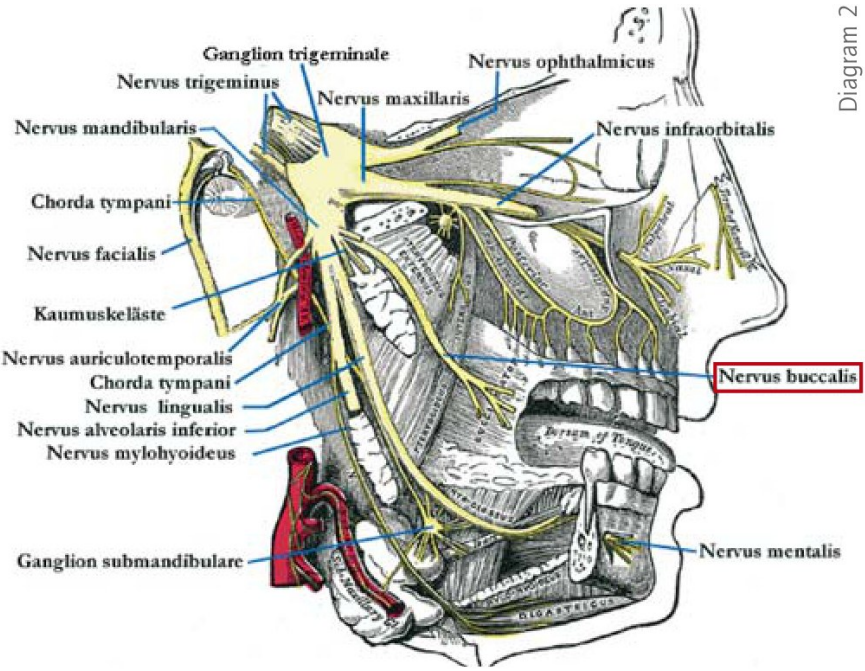
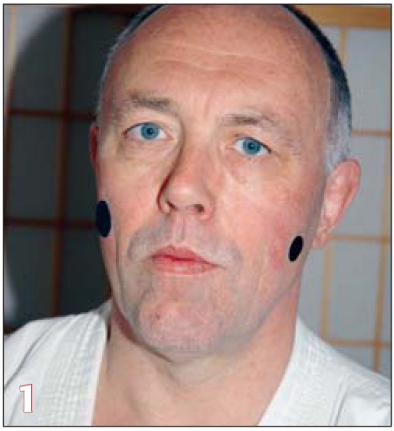



Diagram 2

Nervus buccalis (dây thần kinh má) rất nhạy và chi phối niêm mạc má cũng như lợi.

Tấn công: Kẹp kéo bên dưới xương gò má.

Hiệu quả: Khi có sức ép tác động, có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).




■ 1 Điểm mục tiêu.

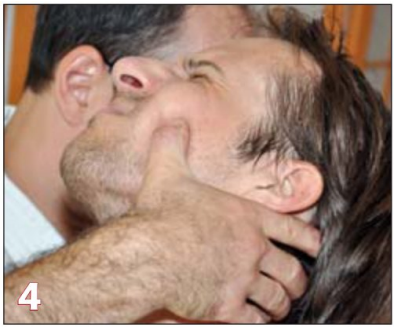
Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm khác nhau tùy từng người.

- 3 Đối phương duỗi người ra vì đau.

- 4 Người phòng thủ né bằng hông và xoay người xuống dưới đối phương; kẻ này ngã sấp xuống đất và giờ có thể bị khống chế.
- 5 Ghì chặt đối phương xuống đất.

- 7 Đòn kết thúc. Các khả năng sử dụng khi đứng 1 Cú đánh bị gạt chệch hướng.

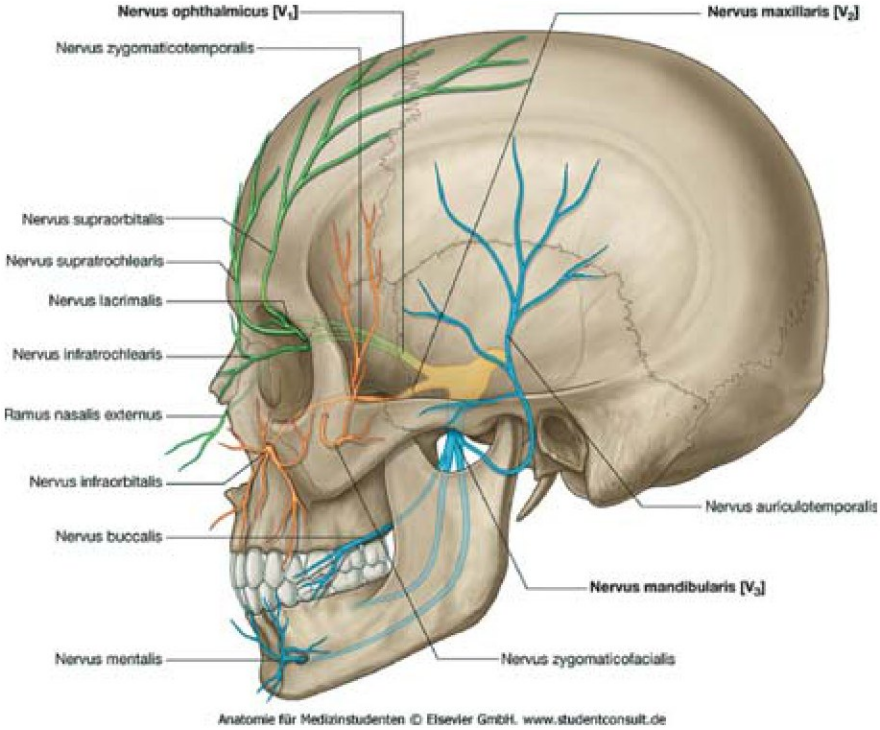
- 2 Dùng thế kẹp kéo vào nervus buccalis và giữ phía sau cổ, đối phương bị quật xuống đất bằng một đòn móc gối chặn.




- 3 Ở tư thế phòng thủ được mô tả, một phương án thay thế cho thế kẹp kéo là ấn một bên bằng khớp đốt ngón trỏ° 4 °hoặc ngón cái. Cũng có thể dùng một cú đấm với các khớp đốt của ngón út và ngón áp út đánh vào nervus buccalis. Ngoài cơn đau gây ra

cho dây thần kinh, còn có cơn đau ở da vùng xương gò má cũng như những hậu quả thông thường của bất kỳ cú đánh nào vào đầu.

## 1.8 Dây thần kinh trán / Nervus frontalis

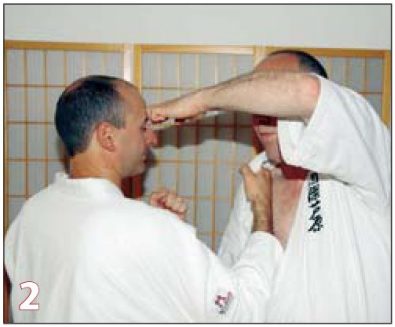



Sơ đồ 3 Nervus frontalis (cùng hai nhánh tận là nervus supraorbitalis và nervus supratrochlearis) chạy dọc theo các cơ mắt bên ngoài tới bờ trên của ổ mắt và nổi lên bề mặt (ở chỗ bắt đầu của lông mày hoặc ở điểm cao nhất của ổ mắt – lỗ trên ổ mắt / supraorbital foramen), nơi chúng dễ bị tổn thương.

Tấn công: Ấn bằng ngón tay (tác động vào vùng ổ mắt) và đánh (vào lông mày). Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (hoặc sau một cú đấm) (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Cẩn thận với các tổn thương mắt. Khi ấn, cần đặt tay kia ở phía sau cổ, trên ngực hoặc cột sống thắt lưng để đối trọng.




- 1 Đối phương túm cổ áo và đe dọa bằng nắm đấm.
- 2 Người phòng thủ đấm vòng qua cánh tay tấn công để đánh vào dây thần kinh ở thái dương bằng các khớp đốt ngón tay (Hiraken). 3 Cận cảnh. 4 Cùi chỏ đối phương đồng thời bị ghì chặt. 5 Cận cảnh. 6 Đầu đối phương bị xoay ra xa người phòng thủ. 7 Đối phương bị bẻ cong° 8 °và quật xuống đất. 10 Đá bằng đầu gối và ghì đầu xuống đất.

### Các biến thể:

- 1 Phòng thủ bằng bàn tay đối trọng đặt trên cổ. Cổ đối phương bị ghì xuống.

- 1 Cú đấm vung bị gạt chệch.
- 2 Cánh tay đánh bị ghì chặt, và ngón cái ấn vào phía trong khóe mắt. Quật ngã.

## 1.9 Dây thần kinh dưới ổ mắt / Nervus infraorbitalis

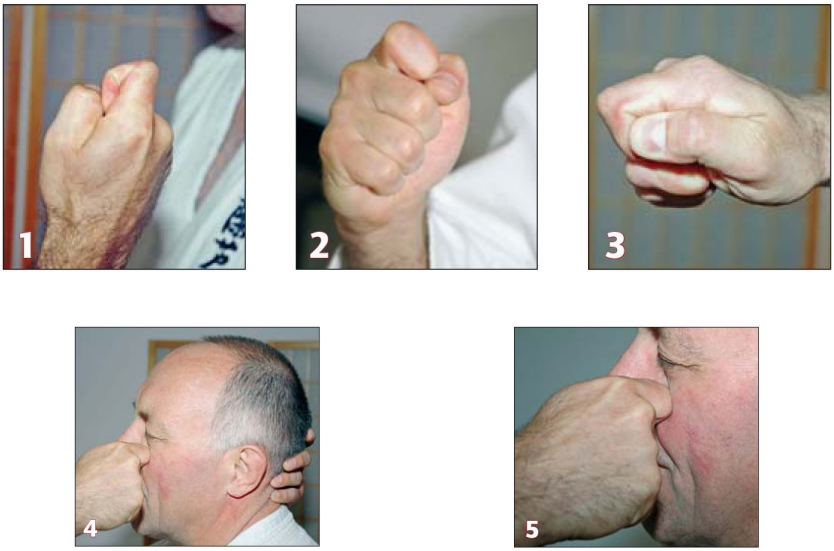
Xem các minh họa “Nervus auricularis magnus”, “Nervus frontalis” và “Nervus buccalis”. Đây là phần tiếp nối trực tiếp của nervus maxillaris (nhánh hàm trên), chịu trách nhiệm chi phối cảm giác cho phần trước hộp sọ. Nervus infraorbitalis thoát ra từ xương hàm trên, cách mắt khoảng một bề rộng ngón tay, tại lỗ dưới ổ mắt (foramen infraorbitale). Có thể sờ thấy nó ở vùng này. Sau khi thoát ra khỏi lỗ, nó phân nhánh trong các màng da khắp mặt trước và phần trên của mặt, truyền cảm giác cho môi trên, răng và lợi của hàm trên (xem phần “Điểm dưới mũi”).

Tấn công: Ấn bằng ngón tay / đấm bằng khớp đốt ngón vào vùng dây thần kinh thoát ra.

Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Khi đấm, cần nhắm mục tiêu chính xác (thực hiện tốt nhất bằng khớp đốt ngón trỏ).




- 1 Vị trí bàn tay ở thế Ipponken.
- 4 Hiệu quả của đòn tấn công tăng lên khi dùng bàn tay còn lại ghì chặt phía sau đầu.
- 5 Cận cảnh.

## 1.10 Dây thần kinh cằm / Nervus mentalis

Xem các phần “Nervus frontalis” và “Nervus buccalis” để có minh họa.

Đây là nhánh tận của nervus alveolaris inferior. Nó thoát ra khỏi xương hàm dưới tại vùng cằm (foramen mentale) và chi phối cảm giác cho da và màng của môi dưới cùng vùng cằm.

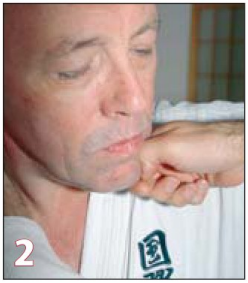
Tấn công: Ấn bằng các khớp đốt ngón tay (ngón cái), đấm.

## Đấm:

- 1 Cú đấm dùng các khớp đốt ngón tay được thực hiện như roi quất xuống dưới, đóng vai trò một đòn gây choáng và là khởi đầu cho các hành động tiếp theo. Đòn này làm há hàm, khiến khớp trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các đòn đấm tiếp theo (xem phần “Hàm dưới”).

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Việc sử dụng chỉ giới hạn trong từng trường hợp cụ thể.



## Ấn bằng các khớp đốt ngón tay:

- 1 Điểm mục tiêu.
- 2 Cách giữ bàn tay cho các đòn tiếp theo; bàn tay kia neo chặt ở phía sau cổ.

## Trình tự tiếp theo:

- 1 Đòn đánh của đối phương bị chặn bằng một thế đỡ kép.
- 2 Bàn tay phải của người phòng thủ trượt dọc theo đường cánh tay đang đỡ, hướng về phía cằm đối phương. 3 Đánh.

6 Do sức ép lên dây thần kinh, đầu đối phương bị xoay và thân người đi theo.

7 Đối phương bị quật xuống đất. 11 Đòn kết thúc là một cú đánh bằng cùi chỏ.

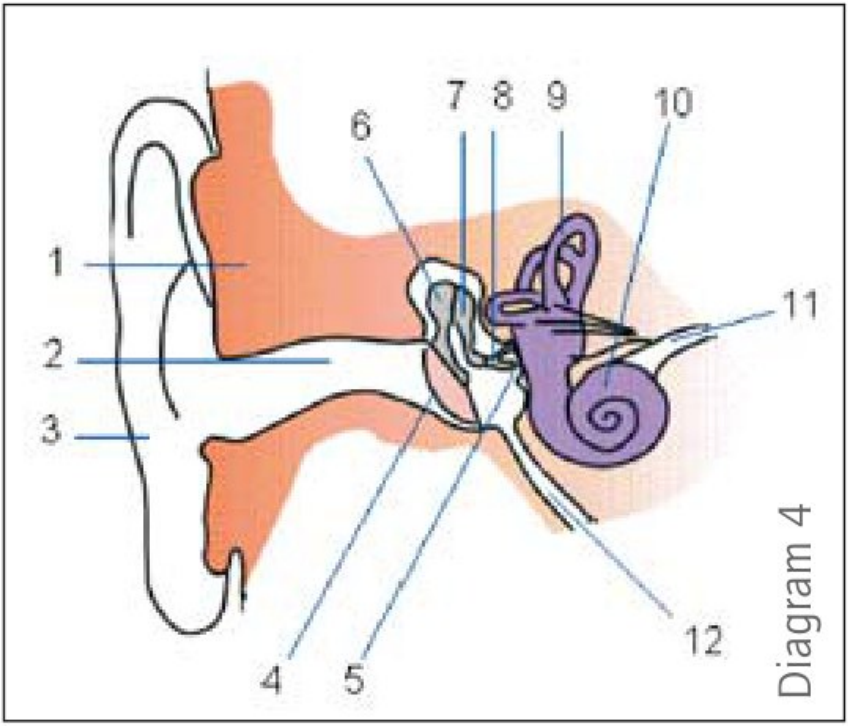
## 1.11 Môi trên

Tấn công: Kẹp kéo môi trên.

Hiệu quả: Đau do tác động lên musculus orbicularis oris (các đoạn cơ vòng quanh miệng), cụ thể là lên các thụ thể đau và dây thần kinh dưới ổ mắt (xem minh họa trong các phần “Nervus auricularis magnus” và “Nervus frontalis”), những dây trải qua hàm trên và chi phối cảm giác cho răng hàm trên, lợi và môi trên. Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Cần dùng bàn tay kia làm điểm ấn đối kháng (cổ, ngực/cột sống thắt lưng).

## 1.12 Tai




(1) Xương đá (2) Ống tai ngoài (3) Vành tai (4) Màng nhĩ – đây là một màng mỏng ở đầu trong của ống tai, ngăn cách ống tai với tai giữa (6) Xương búa (7) Xương đe (8) Xương bàn đạp (9) Mê cung (các ống bán khuyên) – đây là một phần của tai trong và đóng vai trò Sơ đồ 4 hệ cơ quan giữ thăng bằng (10) Ốc tai (11) Dây thần kinh ốc tai (12) Vòi Eustache. Tấn công: Vỗ bằng bàn tay khum vào tai (có thể dùng cả hai tay) (hãy luyện tập bằng cách vỗ vào cánh tay trên của bạn tập). Thọc một ngón tay vào ống tai.

Tạo bàn tay khum cho động tác vỗ.

Hiệu quả: Màng nhĩ rung động do sóng âm – chính xác hơn là do sự thay đổi áp suất mà âm thanh gây ra – và rung động này được truyền từ các xương nhỏ tai giữa tới tai trong. Cú vỗ bằng bàn tay khum gây nén không khí trong ống tai khiến xuất hiện áp suất dư (chấn thương áp lực / barotrauma). Ngoài tiếng động, cùng với áp lực nhanh, mạnh và đau đớn, màng nhĩ có thể bị thủng. Màng nhĩ thủng thường tự lành, tuy nhiên cũng có thể cần phẫu thuật để sửa chữa.

Tuy nhiên, tác động vừa mô tả đi kèm với đau: nhiều nhánh thần kinh tham gia chi phối màng nhĩ, đặc biệt là ramus auricularis, dây thần kinh phế vị (vagus) và nervus auriculotemporalis, một nhánh của nervus trigeminus. Phía trong màng nhĩ được chi phối bởi các nhánh của mạng thần kinh trong các màng (plexus tympanicus) của tai giữa. Chỉ cần chạm vào màng nhĩ cũng đã gây đau và trong

một số trường hợp có thể gây cảm giác buồn nôn, thậm chí bất tỉnh. Đau nhói, đột ngột là đặc trưng của tình trạng thủng màng nhĩ do chấn thương. Cũng có thể xảy ra tình trạng giảm thính lực đột ngột (tùy mức độ thủng). Vi khuẩn có thể xâm nhập vào tai giữa qua lỗ thủng (chủ yếu từ nước) và cũng có thể xảy ra chảy máu nhẹ. Vì tai trong cũng tham gia vào một cú đánh như vậy, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác thăng bằng và là nguyên nhân gây chóng mặt (chóng mặt tiền đình). Chóng mặt thường đi kèm phản ứng thực vật của cơ thể như buồn nôn, nôn, vã mồ hôi, tim đập nhanh và/hoặc ngất.

Ngoài các tác động y học, việc thọc ngón tay vào tai gây ra một phản xạ mạnh (được chi phối bởi nhiều dây thần kinh não).

Bình luận về cách dùng: Không cần nhiều sức để tạo ra hiệu quả đáng kể.

- 4 Ngay sau khi vỗ vào tai, hai ngón cái được ấn mạnh vào mắt.
- 5 Đầu bị xoay sang một bên trong khi vẫn giữ sức ép liên tục lên nhãn cầu.
- 9 Đòn kết thúc: Đánh bằng cùi chỏ.

## 1.13 Tuyến mang tai / Parotis

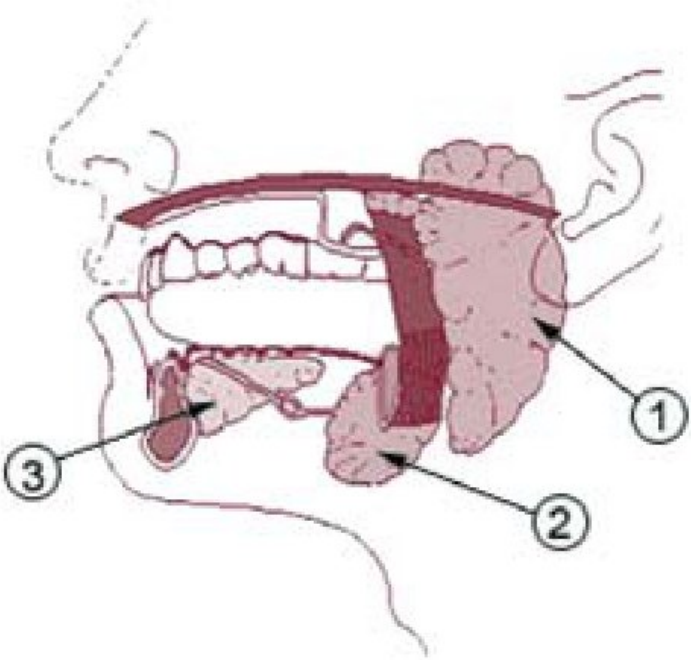



Diagram 5

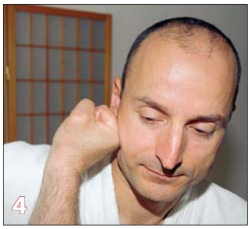
Sơ đồ 5 Tuyến mang tai là tuyến nước bọt lớn nhất vùng miệng và vùng hàm. Ở người, nó nằm ở hai bên mặt, phía trước và dưới tai, trải dài từ cung gò má xuống góc hàm và che phủ nửa sau của cơ nhai (musculus masseter). Trong tuyến mang tai có cái gọi là plexus parotideus, được tạo thành từ các sợi của nervus facialis. Cảm giác của tuyến mang tai được chi phối bởi nervus auriculotemporalis (xem minh họa trong phần “Nervus frontalis”).

Tấn công: Ấn bằng các ngón tay, đấm bằng các khớp đốt ngón tay.

Điểm mục tiêu. Đây là cách giữ bàn tay cho cú đấm bằng khớp đốt ngón. Đánh bằng mặt trên các khớp đốt của nắm đấm (Kento – “nắm đấm gươm”). Hiệu quả tăng lên nhờ động tác bật nhanh ra ngoài từ cổ tay.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau cơ và đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập). Ngoài ra, mô tuyến có thể bị tổn thương. Khi đấm, cũng có thể tổn thương xương hàm dưới (xem phần về nội dung này để biết hậu quả).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người.



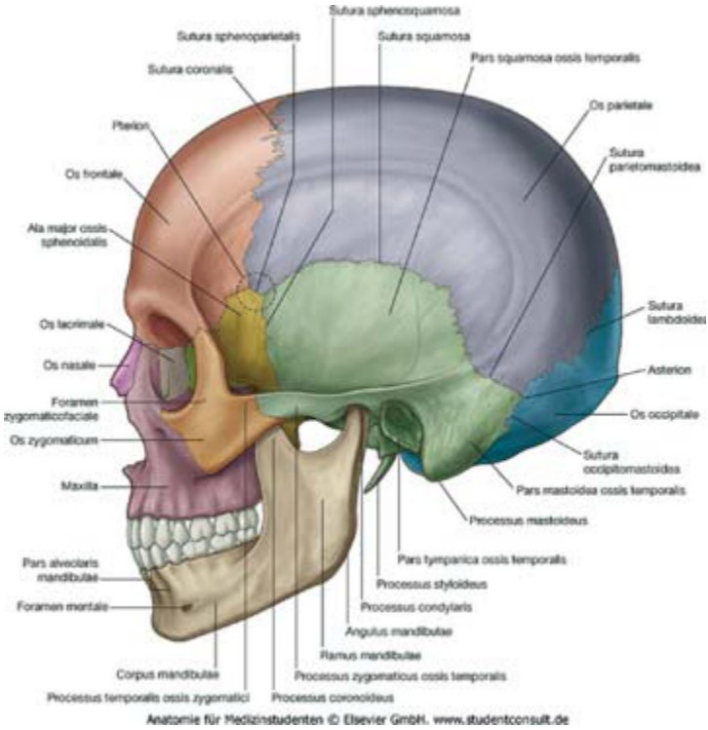
- 8 Ở cuối trình tự, đối thủ bị ấn mạnh xuống đất. Một tổ hợp bổ sung trong đó dùng các khớp đốt ngón tay để đánh (Ryuto Ken Tsuki). 1 Phòng thủ.

- 2 Động tác phản đòn theo vòng tròn bằng các ngón tay ở khớp đốt.
- 3 Với một cú đánh như roi quất, tuyến mang tai có thể bị tổn thương, hoặc ít nhất cú đánh cũng gây đau.

Trong trình tự này, khớp đốt ngón cái được dùng để đánh.

*1. Glandula parotidea · 2. Glandula submandibularis · 3. Glandula sublingualis*

## 1.14 Hộp sọ




Sơ đồ 6 Tấn công: Các đòn đánh (cẩn thận đừng làm tổn thương tay mình), các cú đá (dùng đầu gối).

- 1 Đỡ đòn tấn công của đối phương.
- 2 Khống chế cùi chỏ và cổ.
- 3 Đối phương bị quật xuống lên đầu gối.
- 5 Người phòng thủ tiếp tục khống chế đầu và dùng thân mình chặn cánh tay trái của đối phương.
- 6 Đánh bằng cùi chỏ vào phía sau đầu.

Hiệu quả: Gãy xương sọ và chấn thương não do chấn thương.

Các kiểu gãy xương sọ: Gãy nền sọ: Ở phần nền, hộp sọ nối với cột sống cổ. Gãy ở vùng này thường gây tổn thương các dây thần kinh não tại điểm chúng thoát ra khỏi hộp sọ ở vùng nền. Đôi khi dịch não tủy chảy ra từ tai hoặc mũi và thường đi kèm mất định hướng

hoặc bất tỉnh. Một triệu chứng điển hình là hai mắt thâm đen (tụ máu ổ mắt hai bên).

Gãy các xương của hộp sọ mặt: Bao gồm vùng ổ mắt, xương mũi và hàm trên, hàm dưới. Gãy ở những vùng này thường gây xô lệch các xương nhỏ ở vùng mặt và sưng nề đáng kể. Gãy ổ mắt có thể dẫn đến rối loạn thị giác nếu nhãn cầu bị lệch. Cũng có thể gãy vòm sọ (cranium), chẳng hạn sau một cú va đập mạnh xuống đất.

Khi các xương gãy bị xô lệch, hoặc xương trong vòm sọ bị vỡ thành mảnh, các mảnh này có thể cắm sâu vào não.

Chấn thương sọ não (chấn thương não do chấn thương, hay TBI) chỉ tất cả các tổn thương ở hộp sọ mà não cũng bị ảnh hưởng, nhưng không bao gồm những tổn thương không có gãy xương sọ thật sự hoặc vết thương ở đầu. Vì nguy cơ xuất huyết trong não, bất kỳ bệnh nhân nào bị chấn thương sọ não (kể cả chấn động) đều phải được đưa đến bệnh viện để theo dõi.

Có nhiều phương pháp phân loại mức độ nặng của chấn thương sọ não (TBI). Trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi – các tác giả – chọn liệt kê các cấp độ và mô tả chúng theo hệ thống được dùng ở Đức. Những mô tả dưới đây không khác biệt nhiều giữa các hệ thống và đủ để người đọc có một cái nhìn tổng quan: Các tổn thương được mô tả theo ba cấp độ nặng, tùy thuộc vào thời gian bất tỉnh, mức độ thuyên giảm triệu chứng và các biến chứng về sau:

Cấp 1: TBI (Commotio cerebri – chấn động não): Được định nghĩa là tổn thương não nhẹ (tức là màng não vẫn còn nguyên vẹn) không mất ý thức, hoặc bất tỉnh tối đa một giờ. Tình trạng hồi phục hoàn toàn sau khoảng năm ngày. Nói chung, bệnh nhân than phiền về những khoảng quên ngược (mất trí nhớ) và buồn nôn.

Cấp 2: TBI (Contusio cerebri – dập não): Mất ý thức tối đa 24 giờ. Các biến chứng phụ thuộc vào vùng não bị tổn thương. Cấp 3: TBI (Compressio cerebri – chèn ép não): Bất tỉnh lâu hơn 24 giờ do sức

ép lên não gây xuất huyết (tăng áp lực, phù não). Có thể có những khoảng từ vài phút đến vài giờ không có triệu chứng. Hậu quả thường là hôn mê kéo dài (đôi khi được gây hôn mê nhân tạo), trạng thái giống hôn mê, liệt hô hấp hoặc thậm chí tử vong. Trong những trường hợp như vậy, liệu pháp bao gồm việc tạm thời lấy đi một phần vòm sọ (trong vài tháng). Có thể dự đoán các tổn thương lâu dài, nhưng điều này không phải là tất yếu.

Những triệu chứng sau đây chỉ điểm cho một chấn thương sọ não. Cần lưu ý rằng một số triệu chứng được liệt kê có thể xuất hiện khá lâu sau chấn thương thực sự.

Rối loạn ý thức, có thể diễn tiến xấu đi. Đau đầu. Chóng mặt và mất thăng bằng. Trạng thái nhìn lác. Chênh lệch kích thước đồng tử (hai đồng tử khác kích thước). Buồn nôn và nôn. Bất tỉnh. Những khoảng quên, mất trí nhớ. Liệt. Rối loạn nhịp thở và mạch. Sốc. Rối loạn vận động và cảm giác (ví dụ cảm giác châm chích).

Ở đây, sự chênh lệch kích thước đồng tử và tình trạng rối loạn ý thức ngày càng nhiều phải được coi là dấu hiệu cảnh báo, vì chúng có thể chỉ điểm xuất huyết bên trong hộp sọ. Tuy nhiên, bất tỉnh không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của một tổn thương do chấn thương ở thùy trán. Dù vậy, những tổn thương như vậy có thể dẫn đến các hậu quả lâu dài (ví dụ rối loạn thùy trán, rối loạn nhận thức, rối loạn hành vi).

Bình luận về cách dùng: Cần khá nhiều kỹ năng hoặc sức mạnh để thực hiện những đòn này. Tuy nhiên, vùng đầu theo bản năng vẫn là mục tiêu ưa thích của những người đánh nhau thiếu kỹ năng.

## 1.15 Xương thái dương

Xương thái dương tạo thành phần xương của vùng thái dương (xem minh họa trong phần “Hộp sọ”). Thái dương (tiếng Latinh: regio temporalis) là vùng ở bên đầu, giữa mắt và tai. Những vùng này rất nhạy cảm với đòn đánh vì tai giữa, tai trong và não nằm ngay dưới

xương. Những vùng này cũng nhạy cảm với sức ép do có nervus auriculotemporalis, nervus zygomaticus cũng như musculus temporalis (xem minh họa trong phần “Nervus frontalis”). Ngoài các hậu quả đã mô tả ở phần trước, cùng với nguy cơ chấn thương ở bên đầu, còn có khả năng làm tổn thương arteria meningea media (động mạch màng não giữa), nơi có thể xảy ra xuất huyết động mạch và nếu không được điều trị có thể dẫn đến tử vong — vì vậy chúng tôi tập trung bảo vệ vùng này. Nó nằm ở khoảng giữa bờ trên của tai và bờ trên của ổ mắt, nơi os frontale, os parietale và os sphenoidale gặp nhau (vùng này gọi là pterion – xem minh họa trong phần “Hộp sọ”). Vì các xương ở điểm này đặc biệt mỏng và hộp sọ có cấu trúc phẳng tại đây (khiến nó yếu về mặt cơ học), gãy xương là hoàn toàn có thể.

Tấn công: Các cú đấm (cẩn thận đừng làm tổn thương tay mình; tốt nhất nên dùng gò bàn tay, một cú đánh búa, hoặc cùi chỏ), các cú đá.

Điểm mục tiêu. Hiệu quả: Gãy xương sọ và chấn thương sọ não (bất tỉnh, hôn mê, tổn thương não lâu dài, tử vong) (xem chi tiết thêm trong phần “Hộp sọ”).

Bình luận về cách dùng: Xem phần trước.

- 1 Cú đấm vung của đối phương bị vô hiệu hóa bằng cách rút ngắn khoảng cách tầm với và che chắn.
- 2 Cánh tay che chắn được dùng như một nắm đấm búa đánh thẳng vào thái dương.
- 4 Khống chế cổ và thu cùi chỏ về để đánh.
- 6 Bàn tay của cánh tay tấn công túm lấy phía sau cổ. Một cú xoay 90° đưa người phòng thủ vào tư thế xuất phát cho một cú đá bằng đầu gối và làm đối phương mất thăng bằng.

- GHI CHÚ: Tổ hợp phải được thực hiện với sức ép liên tục hướng tới trước thì mới thành công. 2 Gò bàn tay đánh vào thái dương.

- 5 “Kẹp bánh mì” – đầu đối phương nằm giữa gò bàn tay và cùi chỏ.

## 1.16 Mấu trán / Tubera frontalia

Phần xương trung tâm của trán (os frontale), ở bên trái và bên phải phía trên lông mày; xem phần “Hộp sọ”).

Tấn công: Đánh bằng các khớp đốt ngón tay (lặp lại nhiều lần).

Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Đau (màng da, hay màng xương), có thể từ nervus supraorbitalis hoặc nervus supratrochlearis). Sau một cú đánh mạnh, có thể xảy ra gãy xương xoang (nhưng không xảy ra sau một cú đánh bằng khớp đốt ngón tay). Sau một cú đánh mạnh, rung chấn có thể gây chấn thương sọ não. Xem phần “Hộp sọ” để biết thêm chi tiết. Một cú đánh bằng gò bàn tay, kết hợp đồng thời với một cú đánh bằng cạnh bàn tay vào cơ ở bên cạnh gáy, có thể tạo hiệu quả mạnh, kể cả bất tỉnh do rung chấn trong não.

Bình luận về cách dùng: Các đòn giải thoát (kèm theo các đòn tiếp theo hoặc bỏ chạy).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- 1 Tình huống bị túm quanh eo từ phía dưới hai cánh tay.
- 2 Dùng một đòn gây choáng bằng cú đánh khớp đốt ngón vào các mấu trên trán.
- 4 Bắt đầu đòn bẩy cổ.
- 6 Đầu đối phương bị ghì chặt lên vai người phòng thủ.
- 10 Người phòng thủ thực hiện động tác xoay Tai-Sabaki đồng thời vặn đầu đối thủ.

## 1.17 Hàm dưới

Để xem minh họa, hãy xem các phần “Hộp sọ” và “Nervus frontalis”.

Tấn công: Đấm. Để giảm nguy hiểm, hãy dùng gò bàn tay (hoặc phần đáy nắm đấm) hoặc cùi chỏ.

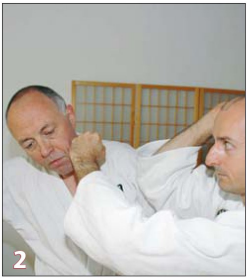
- 1 Khởi đầu của đòn tấn công bị chệch hướng nhờ động tác bước vào. Nghĩa là bàn tay phải tiếp xúc với cánh tay tấn công và đổi hướng đòn tấn công. Bàn tay trái túm lấy cánh tay tấn công.
- 3 Bằng một động tác phản đòn ngay dưới cánh tay tấn công, một cú móc ngược (uppercut) được tung vào cằm.
- 5 Từ một góc nhìn khác.

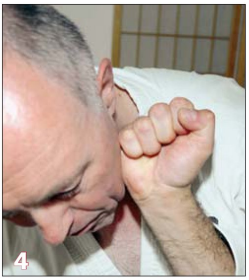
Hậu quả: Tổn thương môi và lưỡi là những hậu quả tương đối nhẹ. Các tổn thương khác phụ thuộc vào góc tung đòn (và tất nhiên cả sức mạnh của nó). Góc nằm ngang dễ gây trật hoặc gãy khớp hàm hơn (đặc biệt nếu lúc đó hàm đang mở) và có thể gây tổn thương răng. Ngoài ra, có thể xảy ra tổn thương nervus auriculotemporalis (xem minh họa trong phần “Nervus frontalis”), dẫn đến liệt hoặc suy yếu cơ nhai musculus temporalis. Một cú móc ngược có thể gây vẹo cổ do cột sống cổ bị căng quá mức khi đầu bị đẩy ngửa ra sau (xem thêm Chương 2 về Gáy). Điều này cũng có thể gây tổn thương các phần mềm ở gáy, ví dụ cơ, dây chằng, đĩa đệm, các cấu trúc mạch máu và tủy sống. Hậu quả có thể gồm chóng mặt, cứng cổ, cảm giác choáng váng, khó nghe và khó nhìn, cũng như giảm thị trường ngoại vi. Chấn thương sọ não cũng có thể xảy ra (xem phần “Hộp sọ”).

Trong những trường hợp gãy hàm dưới nghiêm trọng, sàn miệng trở nên không vững, với nguy cơ đường thở bị chặn do vị trí của gốc lưỡi.

Cũng có thể xảy ra liệt mặt một phần, vì nervus facialis nằm phía trước, bên dưới tuyến mang tai, nổi lên bề mặt ở bờ sau xương hàm dưới. Tại đây nó nằm ngay dưới da, nơi nó ít được bảo vệ và do đó dễ bị tổn thương bởi các tác động từ bên ngoài.

Bình luận về cách dùng: Đây là mục tiêu kinh điển của các võ sĩ chuyên nghiệp cũng như những người “không chuyên lắm”; răng là mối nguy đáng kể cho bàn tay tung đòn nếu không được bảo vệ.





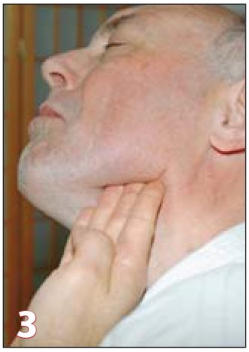

- 1 Người phòng thủ đoán trước đòn tấn công và đánh vào hàm dưới đối phương bằng một cú đấm búa.
- 2 Cú đánh buộc đầu phải xoay theo° 3 °..tiếp nối bằng một cú đấm búa nữa.
- 4 Cận cảnh.

## 1.18 Tuyến dưới hàm / Glandula submandibularis

Xem minh họa trong phần “Tuyến mang tai”.

Có thể sờ thấy tuyến dưới hàm – bên phải và bên trái – ở góc hàm dưới, giữa xương hàm và musculus digastricus, trong cái gọi là tam giác dưới hàm. Tuyến dưới hàm được chi phối bởi nervus facialis và nervus lingualis.

Tấn công: Đấm/ấn bằng các đầu ngón tay/ngón cái.




1-2 Điểm mục tiêu.

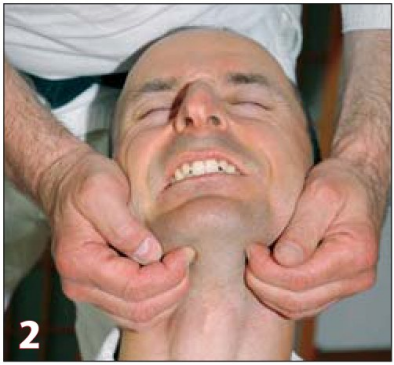
- 3 Dùng các ngón tay như ngọn giáo.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập). Có thể xảy ra tổn thương tuyến. Cũng có khả năng bị vẹo cổ do cú đấm, với những hậu quả tương tự như đã mô tả ở trên. Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người.

## Các cách dùng:

- 1 Người phòng thủ đoán trước đòn tấn công dự kiến bằng cách ghì chặt cánh tay tấn công và dùng các ngón tay chọc vào tuyến.
- 2 Đối phương nghiêng người về phía trước.
- 3 Cận cảnh.
- 4 Nhờ điều hướng đầu, cú đấm của đối phương đánh vào khoảng không.
- 5 Bắt đầu đòn bẩy tay.
- 6 Thực hiện đòn bẩy tay.
- 8 Cánh tay bị ghì chặt và nằm trong tầm khống chế.

Sử dụng đồng thời động tác kéo cổ và chọc bằng các ngón tay.

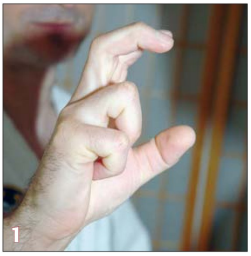



- 1 Đòn khống chế khi đối thủ ở dưới đất.
- 2 Cận cảnh.

- 1 2 Tự vệ chống lại việc bị túm quanh eo bằng cách khống chế đầu.
- 2 Sau đó người phòng thủ móc các ngón tay xuống dưới hàm dưới đối phương và quật kẻ này xuống đất.

## 1.19 Môi dưới

Tấn công: Dùng thế kẹp (với ngón cái ở dưới cằm), môi dưới bị ép vào răng cửa; không thể bị cắn ngón tay. Nervus mentalis chi phối môi dưới.



- 1 Cách tạo thế kẹp.
- 2 Khi dùng thế kẹp, môi dưới bị đẩy lên trên răng cửa, do đó không thể bị cắn.
- 3 Từ một góc nhìn khác.
- 4 Chuẩn bị cho một đòn O-Soto-Gari.

Hiệu quả: Đau (từ các thụ thể đau của cơ và niêm mạc).

Bình luận về cách dùng: Công dụng thực tế rõ ràng là có giới hạn (điều khó nhất là đạt được tư thế để bắt đầu đòn).

## 1.20 Tuyến dưới lưỡi / Glandula sublingualis

Để xem minh họa, hãy xem phần “Tuyến mang tai”.

Như tên gọi cho thấy, tuyến nằm bên dưới lưỡi – đây là tuyến nhỏ nhất trong 3 cặp tuyến nước bọt chính.

Tấn công: Dùng thế kẹp (với ngón cái ở dưới cằm), ngón trỏ và ngón giữa ấn xuống sàn miệng. Công dụng thực tế rõ ràng là có giới hạn. Hiệu quả: Đau.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người. Công dụng thực tế rõ ràng là có giới hạn (điều khó nhất là đạt được tư thế để bắt đầu động tác).

## 1.21 Má

Tấn công: Dùng thế kẹp, thịt má bị ép vào hàng răng trên và dưới. Nervus buccalis (xem phần về nó) chi phối má.

Hiệu quả: Đau, hàm mở ra (những người nuôi chó biết kỹ thuật này).

Bình luận về cách dùng: Cần khóa đối kháng bằng tay kia (trên cổ, ngực/vùng cột sống thắt lưng).

## 1.22 Ổ răng

Những hốc hay ổ trong xương hàm được gọi là ổ răng (alveoli) và răng (cùng chân răng) được giữ cố định trong đó. Ổ răng có ở cả xương hàm trên và xương hàm dưới. Ổ răng ở xương hàm dưới được chi phối bởi nervus alveolaris, còn nervus infraorbitalis chi phối ổ răng ở xương hàm trên.

Tấn công: Chọc bằng các đầu ngón tay, đấm bằng khớp đốt ngón.

Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Đau.

Bình luận về cách dùng: Các đòn giải thoát (sau đó dùng các đòn tiếp theo hoặc bỏ chạy).

- 1 Các đầu ngón tay ấn vào ổ răng. Đối kháng bằng sức ép ở phía sau cổ.
- 2 Một kỹ thuật khác: Dùng khớp đốt ngón giữa trong một cú đấm.

- 1 Hiraken đánh vào ổ răng kèm khóa đối kháng ở phía sau cổ.
- 2 Mở rộng kỹ thuật trước bằng cách ấn ngón giữa vào mắt đối phương.

# Chương 2 — Các điểm tấn công trên cổ

*Chapter 2 — Attack Points on the Neck*

## 2.1 Carotis / Động mạch cảnh chung

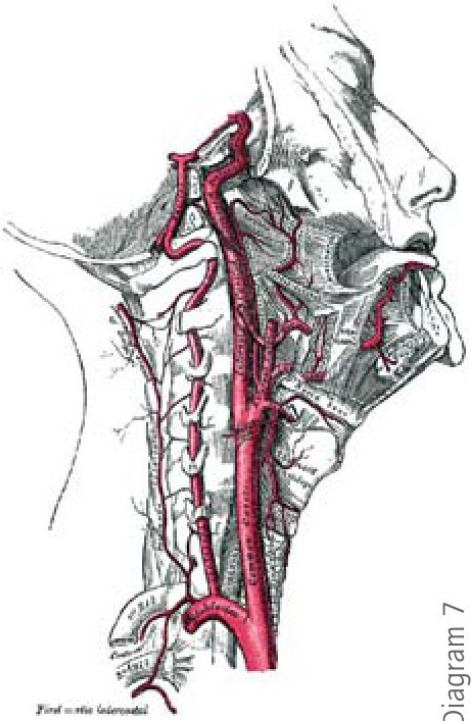


Diagram 7

Sơ đồ 7 Động mạch cảnh nằm ở bên trái và bên phải khí quản và thực quản, chỉ được che phủ bởi cơ bên cổ và da. Ở vùng cổ, có thể dễ dàng đo mạch. Ở vùng thanh quản, nó chia thành arteria carotis interna và arteria carotis externa. Một trong những điểm quan trọng nhất để đo huyết áp (glomus caroticum) nằm tại chỗ phân nhánh này của các động mạch. Chỗ phân nhánh này cần thiết để khi huyết áp tăng đột ngột, mạch máu không bị vỡ và gây xuất

huyết. Khi huyết áp tăng, thành trong của xoang cảnh (carotid sinus) căng ra, điều này được glomus caroticum ghi nhận và truyền lên não qua hệ thần kinh.

Tấn công: Đánh bằng mặt trong hoặc mặt ngoài của bàn tay (cũng dùng trong các đòn siết cổ). 1-2 Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Huyết áp tăng cao kích thích não khiến các mạch máu giãn ra ngay lập tức, đặc biệt là các tĩnh mạch ở vùng dạ dày – có thể bất tỉnh do não thiếu máu nuôi. Nếu nằm ngang, máu chảy ngược trở lại não và người đó sẽ tỉnh lại.

Ngoài ra, tim có thể đập chậm lại và yếu đi. Nhịp thở cũng giảm, cuối cùng thậm chí có thể ngừng hoàn toàn. Có nguy cơ lên cơn đau tim.10 Các tổn thương thêm có thể do bất kỳ cú ngã nào.

Cũng có nguy cơ các mảng xơ vữa bong ra ở mặt trong động mạch cảnh, di chuyển theo hệ tuần hoàn và gây đột quỵ trong não. Những mảng như vậy đặc biệt thường gặp ở chỗ phân nhánh của động mạch cảnh chung. Nguy cơ này tăng lên theo tuổi tác.

Như đã chỉ ra trong phần Dẫn nhập, về tác động lên Uke, người ta có thể vô trách nhiệm và cũng đáng ngờ về mặt pháp lý như nhau khi thấy điểm này trong các video huấn luyện khác nhau bị lạm dụng làm “bằng chứng” rằng Kyusho có hiệu quả. Đây có thể là

một chủ đề đặc biệt tế nhị nếu có những thương tích với hậu quả nghiêm trọng hơn dự kiến.

Bình luận về cách dùng: Thích hợp để dùng như Atemi, cũng như trong các kỹ thuật siết cổ. Trong một số trường hợp, có nguy hiểm do gần thanh quản.

- 1 Đối thủ cố túm lấy.
- 2 Người phòng thủ tiến lên, giữ hai cánh tay theo hình chêm chữ “V”.
- 3 Đòn tấn công bị gạt ra ngoài.
- 4 Đối phương trượt qua phía ngoài người phòng thủ.
- 5 Đòn kẹp dùng cạnh bàn tay đánh vào hai động mạch cảnh.
- 6 Cận cảnh.
- 7 Để gia tăng hiệu lực cho kỹ thuật, bàn chân đối phương bị ghì xuống bằng cách giẫm lên.
- 8 Cận cảnh.
- 9 Tiếp tục tấn công bằng cách gõ liên tiếp cạnh bàn tay vào mục tiêu.

## Các trình tự bổ sung:

- 2 Tấn công bằng một cú đá thẳng bằng bàn chân.
- 3 Cú đá bị gạt đi bằng cánh tay trái.
- 4 Động tác phòng thủ khiến cú đá của đối phương bị duỗi dài thêm.
- 5 Động tác gạt theo vòng tròn trong đòn phản công chuyển sang việc dùng cạnh trong của bàn tay.
- 7 Phản công bằng cạnh trong của bàn tay đồng thời khống chế khớp cùi chỏ.

Cú đánh cũng có thể được thực hiện bằng cạnh ngoài của bàn tay (Shuto).

## 2.2 Gáy / Cột sống cổ

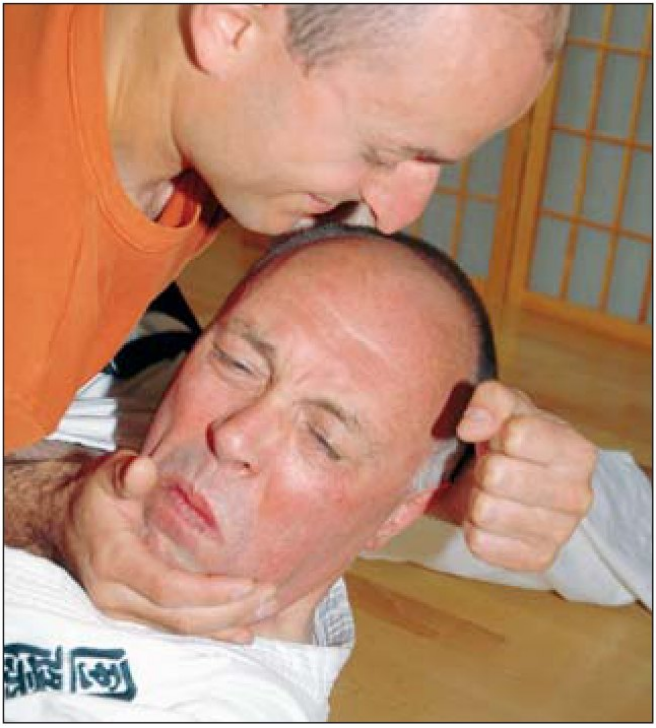
Gồm bảy đốt sống (C1–C7) nằm giữa đầu và cột sống ngực, được nâng đỡ bởi các cơ cổ và cơ lưng cùng nhiều đốt sống khác. Sơ đồ 8 Tấn công: Đòn bẩy cổ, đấm.

Trong một đòn bẩy cổ có xoay, điều then chốt là phải kết hợp việc kéo duỗi cổ với việc xoay đầu để đạt hiệu quả tối ưu.

■ 1 Minh họa việc kéo duỗi cổ.

- 2 Kéo duỗi cổ kết hợp xoay đầu.
- Cách dùng ở tư thế đứng 1 Bắt đầu đòn bẩy cổ ở tư thế đứng. Chú ý việc bắt đầu vặn và ghì đầu.

- 2 Không có khả năng thoát. Stefan hài lòng với đòn bẩy cổ thành công của mình.



## Khi dùng ở thế nằm sàn:

## Trình tự ở thế nằm sàn:

- 1 Phía sau đầu đối thủ được nắm trong lòng bàn tay áp phẳng. Ở thế áp sát (clinch), hai bàn tay xếp chồng lên nhau. (Cẩn thận! Không bao giờ đan hai bàn tay vào nhau, nếu không sẽ có nguy cơ gãy ngón tay).
- 2 Kéo duỗi cổ.
- 3 Bắt đầu động tác xoay.

Tấn công: Đánh (cạnh bàn tay, cẳng tay).

- 1 Tư thế xuất phát.
- 2 Cú đấm bằng tay phải bị đỡ. Bàn tay phải đã sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo bằng cạnh bàn tay.

- 3 Đánh bằng cạnh bàn tay°.
- 4 °.. và túm ngay quanh cổ.
- 5 Cú đá thấp phía trong (Uchimomo-Geri). Chân đá bên phải nhanh chóng được thu về phía sau, và đối phương bị mất thăng bằng bằng cách kéo mạnh kẻ đó lướt qua người phòng thủ.
- 6 Tư thế xuất phát cho một đòn tấn công tiếp theo vào cổ.
- 7 Động tác kéo về đồng thời khống chế cùi chỏ.
- 8 Tấn công bằng phần xương trụ (ulna) của cẳng tay (có thể gây tử vong). Hiệu quả: Tám nhánh thần kinh khởi phát ở mỗi bên cột sống cổ. Bốn nhánh trên tạo thành đám rối cổ (plexus cervicalis), chi phối cổ và các cơ của cổ cũng như cơ hoành. Bốn nhánh dưới, cùng với các dây thần kinh của đốt sống ngực thứ nhất, tạo thành đám rối cánh tay (plexus brachialis) và chi phối các cơ ngực, lưng, cánh tay cũng như lớp da phủ trên chúng.

Các động mạch đốt sống nằm dọc xuống cột sống cổ và cùng với động mạch cảnh bảo đảm việc cung cấp máu cho não. Tổn thương tủy sống (do gãy xương ở cột sống cổ) dẫn đến cảm giác tê và liệt chân, tay, thân mình và, trong trường hợp tổn thương ở phần cao hơn (tổn thương tủy sống quanh vùng đốt sống thứ tư hoặc cao

hơn), liệt cơ hoành và do đó liệt hô hấp. Hơn nữa, nó dẫn đến mất kiểm soát bàng quang và ruột, cũng như làm mất chức năng sinh dục. Vẹo cổ (whiplash) là một dạng tổn thương tủy ở mức độ vừa ở cột sống cổ và không làm tổn thương các đốt sống. Nó có các triệu chứng điển hình là đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn. Những dạng vẹo cổ nghiêm trọng đi kèm với tình trạng không vững ở đoạn chuyển tiếp từ đầu sang cổ. Những tổn thương này là tổn thương dây chằng hoặc tổn thương bao khớp ở khớp đầu. Các triệu chứng của tình trạng không vững ở đoạn chuyển tiếp từ đầu sang cổ là:

Chóng mặt. Buồn ngủ. Đau rát hoặc đau nhói ở phía sau đầu. Vấn đề về nghe và nhìn, thị trường ngoại vi hạn chế. Rối loạn tri giác, rối loạn chú ý, mất định hướng. Kiệt sức nhanh. Mất ngủ. Cảm giác yếu. Đau và/hoặc cảm giác tê hay châm chích trên da mặt hoặc da tay (dị cảm). Dáng đi không vững. Rối loạn cơ, như co thắt (co cứng).

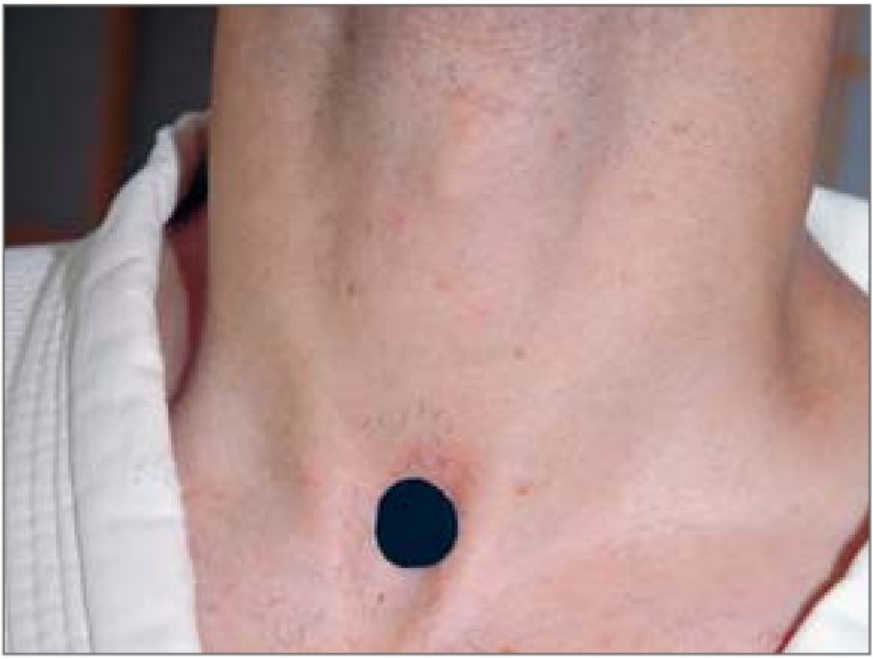
Bình luận về cách dùng: Các mục tiêu dễ tiếp cận, tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc vào thể trạng của đối phương.

Cùng trình tự như trên, nhưng để rõ ràng hơn, từ một góc nhìn khác.

- 7 Khống chế bằng tay phải. Thu tay trái về để chuẩn bị một cú đánh mới.

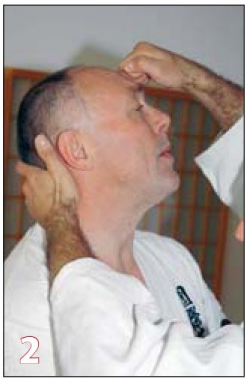
## 2.3 Hõm cảnh / Fossa jugularis

Vị trí: Nằm trong một hõm giữa hai xương đòn và được giới hạn phía dưới bởi bờ trên của xương ức. Tấn công: Ấn hoặc, bằng một động tác chọc, dùng ngón trỏ và ngón giữa để gây kích thích khí quản (trachea).



Điểm mục tiêu.

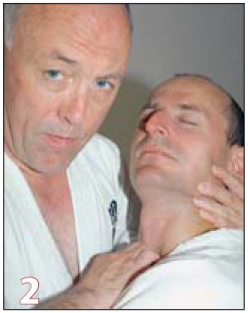
- 1 Đây là cách giữ bàn tay để tấn công hõm cảnh.
- 2 Cách giữ bàn tay khác để ấn sâu vào và ra phía sau xương ức.
- 3 Sức ép của các ngón tay được tác động theo hướng chéo lên trên (để có hiệu quả tốt nhất).

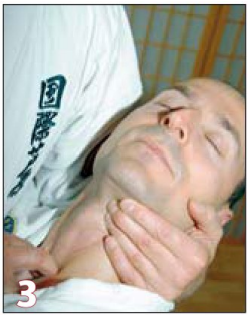


## Ví dụ về cách dùng:

- 1 Đối thủ túm quanh phía dưới hai cánh tay.
- 2 Đòn gây choáng bằng các khớp đốt ngón tay vào nervus frontalis (xem phần trước). Đầu bị đẩy ngửa ra sau bởi đòn này° 3 °. và cho phép người phòng thủ tấn công hõm cảnh bằng các ngón tay chọc. Hiệu quả: Đau và kích thích cổ họng do kích thích các sợi lông nhỏ (cilia) ở mặt trong khí quản. Gãy khí quản xảy ra chủ yếu do một cú va đập trực tiếp (điều này đặc biệt ảnh hưởng tới người lớn tuổi) làm gãy các vòng sụn trên của khí quản đã bị vôi hóa (các vòng hình móng ngựa, hay sụn, bao quanh khí quản, hở ra phía sau – xem minh họa trong phần "Thanh quản") (ví dụ do một cú đánh tù); trong trường hợp gãy hoàn toàn, hãy đẩy các đoạn gãy trở lại vị trí.

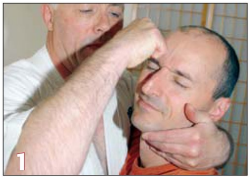
Bình luận về cách dùng: Ở khoảng cách ngắn, có thể quật đối phương xuống đất (để làm điều này, bàn tay kia phải giữ phía sau đầu/cổ). Dùng như một đòn chọc từ khoảng cách xa hơn (cần độ chính xác; trong một số trường hợp, có nguy hiểm do gần thanh quản). Hoặc dùng nó như một đòn giải thoát (sau đó thực hiện một đòn tiếp theo hoặc bỏ chạy).

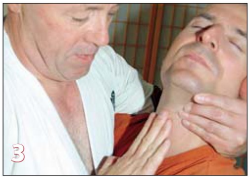


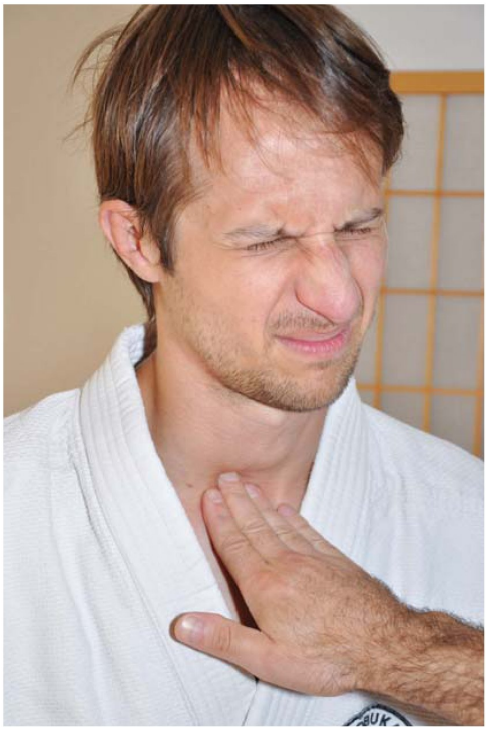
## Các trình tự bổ sung:

- 1 Đòn gây choáng (như đã mô tả ở trên).
- 2 Túm lấy xương ức.
- 4 Đối phương bị quật xuống quỳ trên đầu gối.
- 6 Đòn kết thúc bằng cùi chỏ (có thể gây tử vong).





Các phần của trình tự để rõ ràng hơn: 1 Lặp lại việc dùng đòn gây choáng. 2 Duy trì tiếp xúc với mặt đối phương. Bàn tay trượt về phía cổ họng. 4 Túm vào trong hõm. 5 Đòn phòng thủ bằng các đầu ngón tay theo hướng chéo lên trên (cẩn thận thanh quản!). Cú đánh đáng tin cậy nhất – hướng lên và chéo – là cú dùng cả bàn tay, vì một trong các ngón tay luôn tìm được mục tiêu.



## 2.4 Cơ bên cổ / Musculus sternocleidomastoideus

Nguyên ủy: Mặt trước của xương ức Sơ đồ 9 và phần trong của xương đòn.

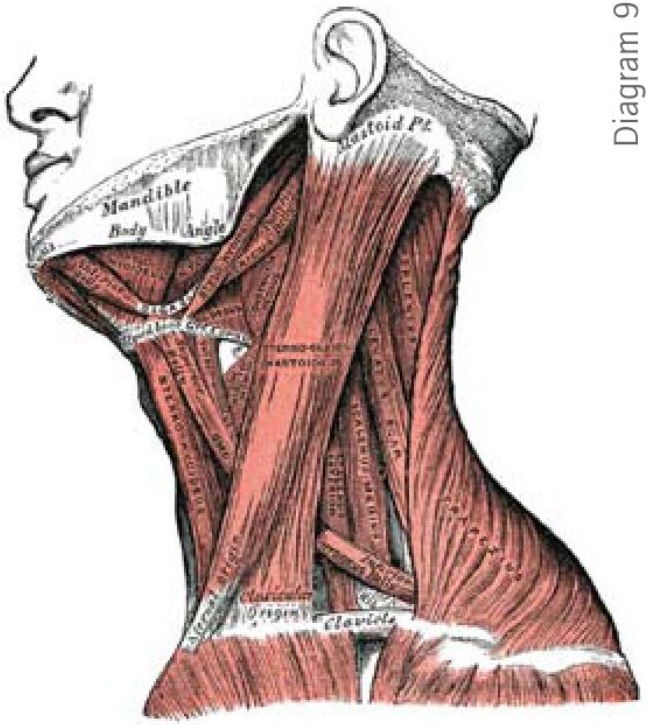
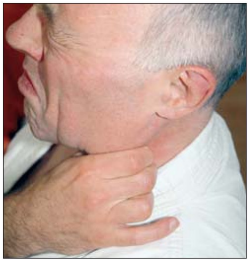



Diagram 9

Bám tận: Processus mastoideus (mỏm chũm) của xương thái dương (phía sau tai). Chức năng của cơ này là xoay đầu sang bên đối diện hoặc xoay đầu theo hướng chéo. Nó cũng gập cổ. Cơ ức–đòn–chũm được chi phối bởi dây thần kinh phụ cùng bên.

Tấn công: Kẹp bằng các ngón tay vào giữa bụng cơ hoặc móc các ngón tay vào đó.

Minh họa bó cơ. Hiệu quả: Đau cơ; cẩn thận khi ấn vào động mạch cảnh (xem phần về nó).



Bình luận về cách dùng: Ở khoảng cách ngắn, có thể dễ dàng điều hướng đối phương.

- 1 Cú đấm vào tai bị gạt chệch.
- 2 Bắt đầu đòn quật.
- 3 O-Soto-Gari.
- 6 Đòn kết thúc: chọc vào mắt.

Biến thể: Khống chế từ phía sau.

- 1 Túm lấy cơ đồng thời khống chế bằng cánh tay kia.

## 2.5 Cơ bên cổ – điểm bám tận

Điểm bám tận của musculus sternocleidomastoideus nằm ở mỏm chũm (processus mastoideus) của xương thái dương (phía sau tai).

Tấn công: Đánh bằng cạnh ngoài của bàn tay, cạnh trong của bàn tay, xương trụ hoặc đáy nắm đấm.

- 1 Tấn công bằng cẳng tay (phần xương: xương quay = radius).
- 2 Cận cảnh.

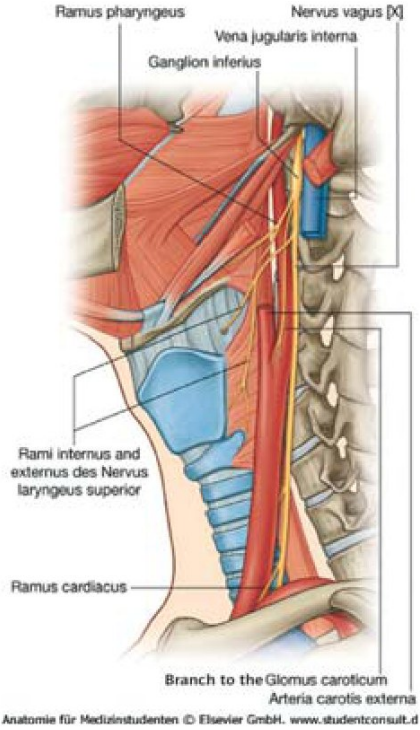
Hiệu quả: Khi co lại ở một bên, cơ bên cổ đưa đầu về phía vai. Cùng với phản xạ duỗi (xem phần Dẫn nhập), đầu hoặc não bị chấn động và có thể dẫn đến những khoảng mất định hướng ngắn. Khi

bị một cú đánh mạnh, có khả năng tổn thương cột sống cổ (xem phần về nó).

Bình luận về cách dùng: Có một phổ ứng dụng rộng, ví dụ để hỗ trợ một đòn quật như O-Soto-Gari hoặc cũng dùng như một đòn gây choáng. Sau khi chặn, hãy túm quanh thân bằng cách đẩy đầu đối phương. Sau đó đánh bằng cạnh bàn tay vào điểm bám tận của cơ bên cổ.

Hãy tự giải thoát khỏi thế áp sát bằng cách ấn vào nervus auricularis magnus, rồi dùng chính bàn tay đó tung một cú đánh bằng đáy nắm đấm vào điểm bám tận của cơ bên cổ.

## 2.6 Cơ bên cổ – hõm điểm bám tận



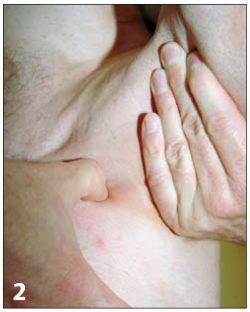

Sơ đồ 10 Hõm được tạo thành bởi các cơ bên cổ trái và phải (musculus sternocleidomastoideus) giữa xương đòn và điểm khởi đầu của xương ức; ngay phía trên xương đòn (xem minh họa trong phần “Cơ bên cổ”). “Bám tận” nghĩa là vị trí cơ gắn vào xương mà nó vận động.

Nervus vagus chạy qua cổ xuống thân trong cùng một bao với arteria carotis communis. Tại đây nó chi phối tim, phế quản, đường tiêu hóa và niệu quản (để tác động tới được đó, sức ép phải rất mạnh). Dù sao, hiệu quả vẫn được cảm nhận qua cơn đau do ấn vào nguyên ủy của cơ. Tấn công: Ngón cái ấn theo hướng chéo xuống dưới về phía giữa.

- 1 Điểm mục tiêu.
- 2 Cách giữ ngón cái.

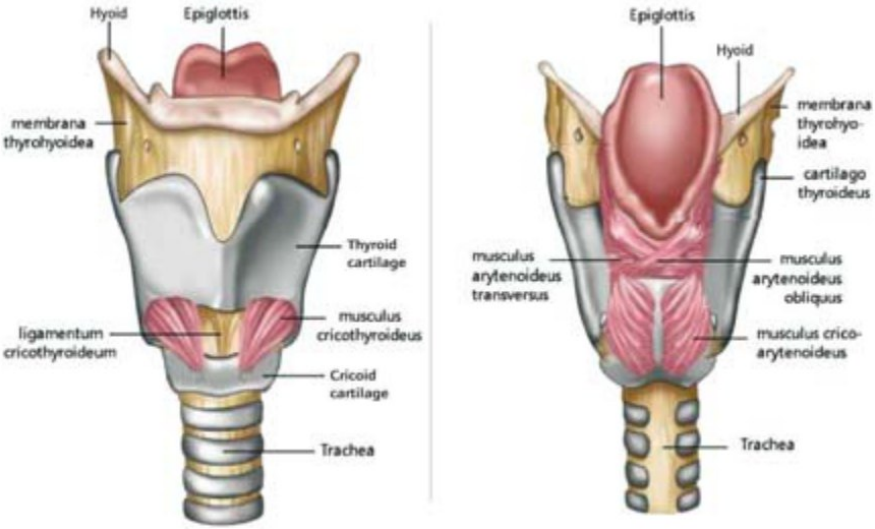
Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (so sánh các trình bày trong phần Dẫn nhập). Khi ấn vào arteria carotis communis, có sự giảm tạm thời lượng máu cung cấp cho não, dẫn đến chóng mặt. Khí quản cũng có thể bị kích thích.

Bình luận về cách dùng: Kỹ thuật tốt cho tác chiến ở khoảng cách ngắn: việc tìm đúng điểm đòi hỏi phải luyện tập trước khi có thể mong đợi mức độ thành công cao.



- 1 Khống chế đầu bằng cách tấn công bằng ngón cái.
- 2 Cận cảnh.
- 3 Cùi chỏ vào xương ức.
- 4 Đầu bị ghì chặt cho đòn kết thúc.

## 2.7 Thanh quản

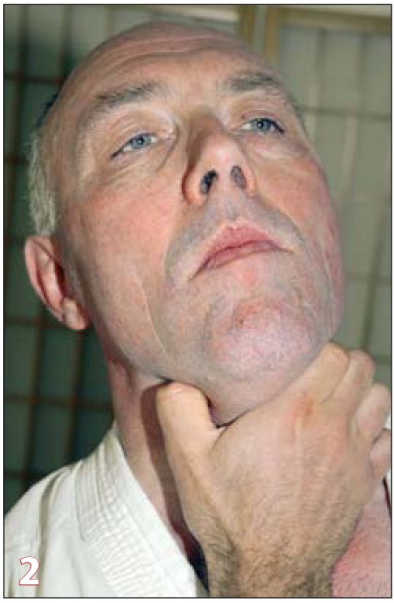



Sơ đồ 11 Vùng mục tiêu này rất dễ bị tổn thương vì vùng này không có sự bảo vệ tự nhiên. Thanh quản gồm lưỡi, cùng ba sụn – sụn giáp, sụn nhẫn và sụn nắp thanh môn. Ngoài ra còn có hai sụn phễu. Các sụn được giữ với nhau bằng các màng.

Tấn công: Các đòn đánh bằng cạnh trong hoặc cạnh ngoài của bàn tay, mặt phẳng bàn tay, nắm đấm, các khớp đốt ngón tay hoặc bị túm.

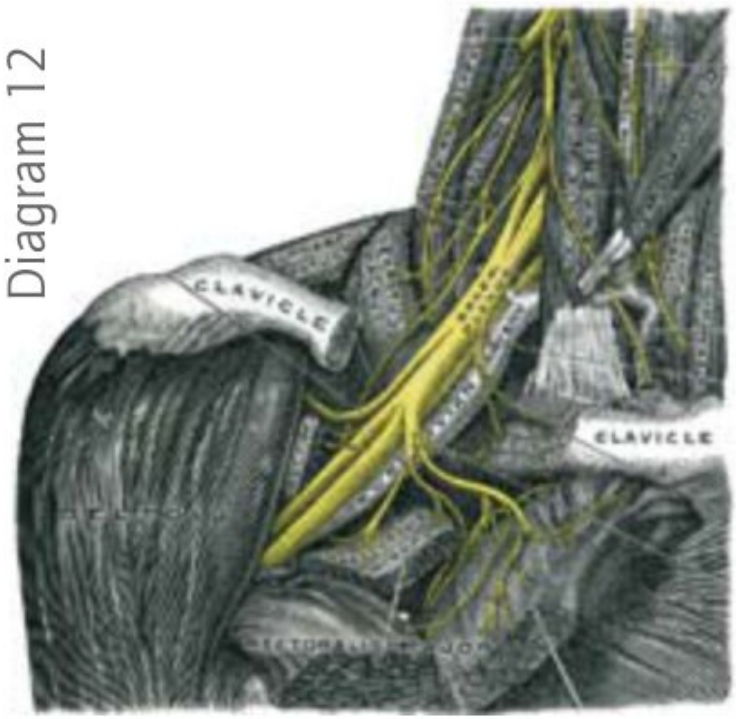
Điểm mục tiêu. Hiệu quả: Nếu thanh quản bị sụp, có nguy cơ ngạt thở cấp tính vì đường thở bị tắc nghẽn. Biện pháp đối phó: Mở khí quản (hoặc mở sụn nhẫn tùy vị trí). Còn có khả năng xảy ra co thắt dây thanh với việc đóng thanh môn và có thể phù nắp thanh môn. Nếu xương móng bị gãy, sẽ có vấn đề về hô hấp và phát âm do các cơ quanh nó bị vặn xoắn.

Bình luận về cách dùng: Xét về hiệu quả và khả năng tiếp cận, mục tiêu này gần như ngang hàng với mắt.

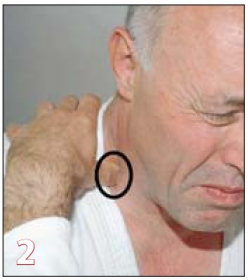


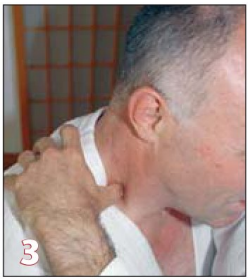

- 1 Một vũ khí hiệu quả là dùng chữ V tạo bởi ngón cái và ngón trỏ mở ra để đánh hoặc túm lấy cổ họng (tiếng Nhật: “Toho”). Sau một cú đánh thành công, đòn tấn công có thể tiếp nối bằng việc túm hoặc siết thanh quản.

## 2.8 Hõm xương đòn




Sơ đồ 12 Tấn công: Ấn bằng ngón cái – hướng vào đám rối cổ (plexus cervicalis) và các cơ bậc thang (musculi scaleni) (xem minh họa trong phần “Cơ bên cổ”).



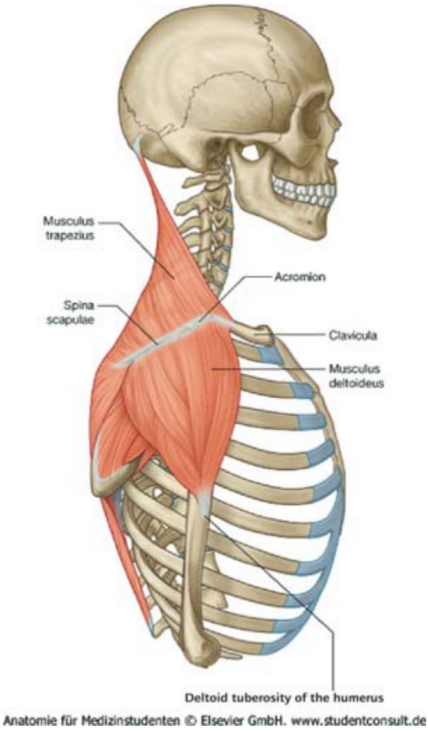



1 Cách giữ ngón cái để tấn công. 2 Điểm mục tiêu. 3 Từ một góc nhìn khác. 4 Sức ép của ngón cái lên đám rối cổ có thể được hỗ trợ bằng một đòn bẩy cổ.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Kỹ thuật tốt cho tác chiến ở khoảng cách ngắn; việc tìm đúng điểm đòi hỏi phải luyện tập trước khi có thể mong đợi mức độ thành công cao.

## 2.9 Cơ thang / Musculus trapezius




Sơ đồ 13 Tấn công: Đánh (bằng cạnh bàn tay, đấm búa, đánh bằng cẳng tay [xương trụ]) vào musculus trapezius tại chỗ nó nối với cổ; kẹp bằng các ngón tay vào bụng cơ của nó. Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Đau cơ; cùng với phản xạ duỗi (xem phần Dẫn nhập), đầu hoặc não bị chấn động (điều này có nghĩa là cú đánh nhắm vào phần nền dưới của hộp sọ).

Về các tác động có thể có lên cơ thang, xem phần “Cơ nhị đầu”.

- Bình luận về cách dùng: Có thể xảy ra vẹo cổ với những hậu quả đã được giải thích nhiều lần ở trên. Đây có thể là một mục tiêu khó tiếp cận trong những điều kiện bất lợi; cú đánh phải được tung ra với lực mạnh. 1 Đỡ cú đấm vung.

- 2 Túm lấy quần áo đối phương đồng thời tung một cú đá vào mặt trong đầu gối. 3 Thu cánh tay về để tung cú đánh vào cơ thang.

- 4 Thực hiện cú đánh bằng cách đập bằng xương trụ.
- 5 Túm lấy và khống chế cổ.
- 6 Đòn kết thúc bằng một cú đá đầu gối.

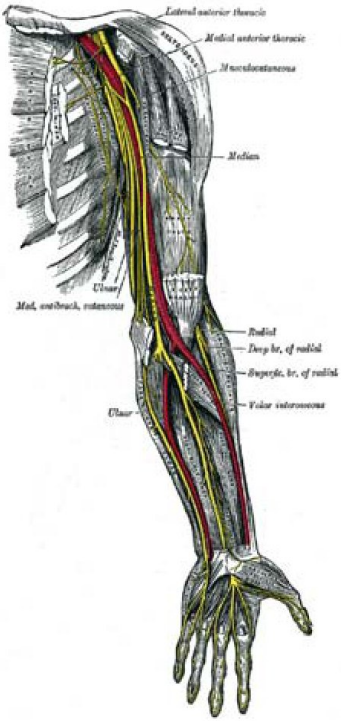
- 1 Thu cánh tay về.
- 2 Đánh theo hướng chéo xuống dưới bằng xương quay.
- 3 Cận cảnh.

- 4 Cú đánh chuyển thành một đòn quật bằng hông (Koshi Guruma).
- 5 Động tác tạo trục xoay.
- 7 Để tăng hiệu quả của đòn quật, chân phải của đối thủ bị gạt đi.

# Chương 3 — Các điểm tấn công trên thân mình

*Chapter 3 — Attack Points on the Torso*

## 3.1 Nách / Axilla




Sơ đồ 14 Nách là vùng trên cơ thể người nằm ngay dưới khớp nối cánh tay với vai, được giới hạn phía trước bởi cơ ngực, phía sau bởi cơ lưng và phía trong bởi lồng ngực. Nó nằm dưới da. Các nhánh nối tiếp của đám rối cánh tay, cụ thể là nervus medianus, nervus ulnaris và nervus radialis, có thể tìm thấy ở nách. Những dây thần kinh này chạy khắp toàn bộ chi trên. Tấn công: Đá, chọc bằng các ngón tay.

Điểm mục tiêu.

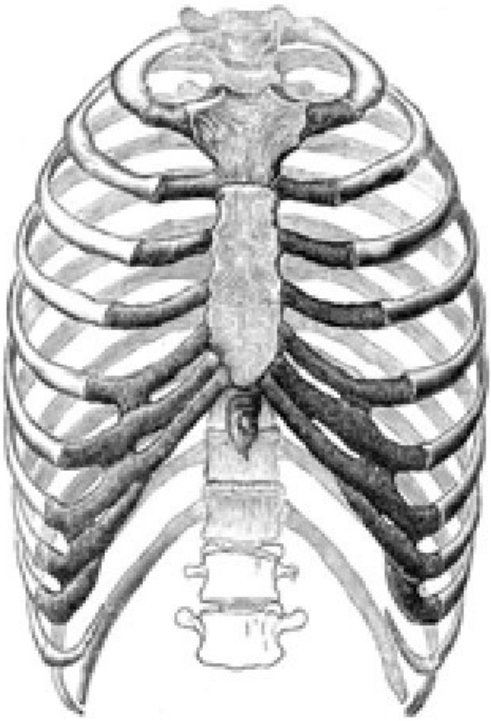
- 1 Đối phương bị buộc phải tự che chắn bằng cách áp dụng một đòn bẩy lên cánh tay của kẻ đó. Điều này khiến nách trở nên dễ bị tổn thương°.
- 2 °..để có thể tung một cú đá.
- 3 Cận cảnh.

Hiệu quả: Đau thần kinh/đau dây thần kinh (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người; nách tương đối ít khi lộ ra, và hơn nữa, như mọi mục tiêu trên thân mình, thường được quần áo che chắn tốt.

## 3.2 Xương ức / Sternum

Xem thêm minh họa trong phần “Các xương sườn”.



Một phần của lồng ngực (tiếng Latinh: thorax).

Sơ đồ 15 Tấn công: Đánh bằng các khớp đốt ngón tay, húc đầu, đá bằng đầu gối, đáy nắm đấm.

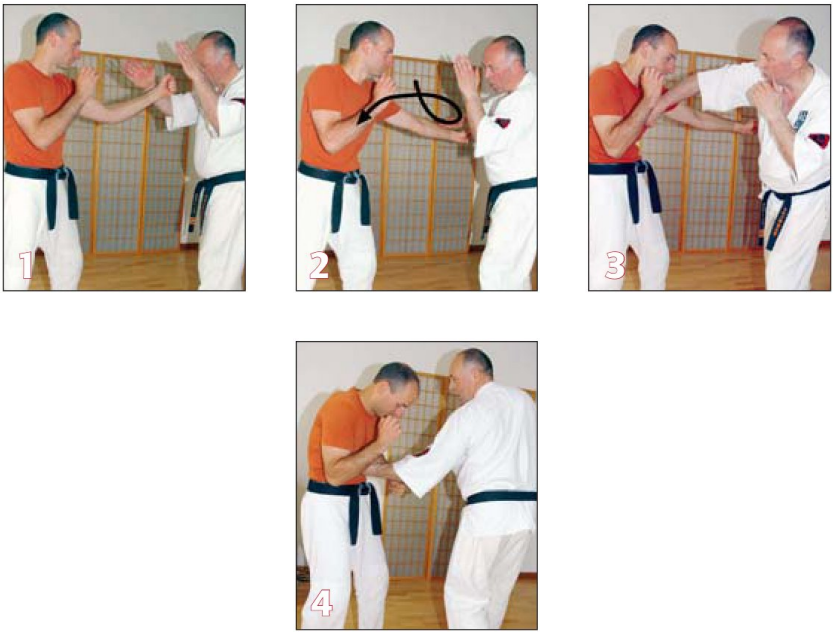
Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Đau, ho do ngứa ở cổ họng, gãy xương, ngất/ngất xỉu, khó thở, tác động gây sốc lên tim dẫn đến nguy cơ ngừng tim, tử vong.

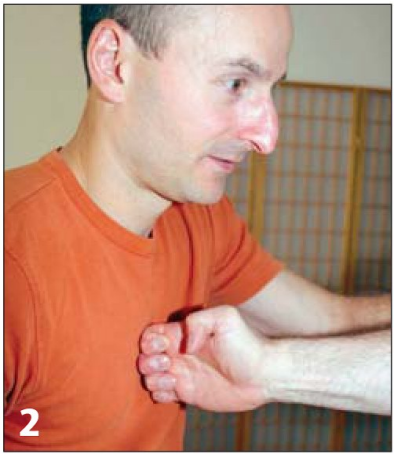
Có thể nó sẽ tác động lên tim. Tuy nhiên, quy trình này được dùng trong xoa bóp tim, khi sức ép được tác động lên lồng ngực. Đôi khi, trong tình huống cấp cứu, người ta đập một cái bằng đáy nắm đấm vào ngực (ngay bên trái đường giữa) để khôi phục nhịp tim đúng trong trường hợp rung thất. Tình trạng “commotio cordis” (rung tim) có thể được gây ra ngay cả với lực nhỏ. Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ về vấn đề này11, xem xét 128 trường hợp, báo cáo rằng trong phần lớn các trường hợp liên quan đến bóng chày, bóng bầu dục hoặc các loại bóng khác. Theo nghiên cứu, có một khoảng thời gian

15 mili giây khi nguy cơ ở mức cao nhất – cú đánh phải nhắm trực tiếp vào phía trên tim.

Dường như không có khuynh hướng đặc biệt nào đối với tình trạng "commotio cordis" – nó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong những điều kiện bất lợi như đã mô tả. Tuy nhiên, người trẻ có nguy cơ cao hơn vì lồng ngực của họ đàn hồi hơn người lớn tuổi. Chỉ 16% trong số 128 trường hợp được xem xét trong nghiên cứu sống sót.12 Mục tiêu này dễ tiếp cận; tuy nhiên, như mọi mục tiêu trên thân mình, lồng ngực được quần áo bảo vệ (đặc biệt với các đòn đánh bằng khớp đốt ngón tay).



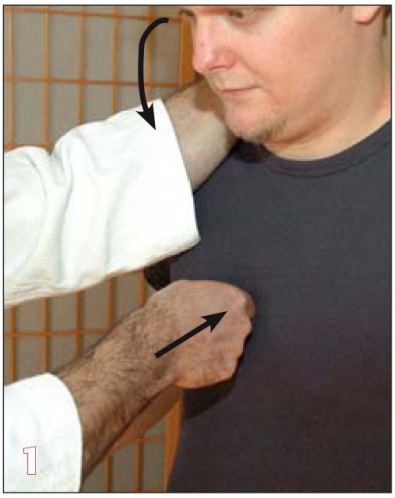

Bình luận về cách dùng: 1 Đấm bằng nắm đấm. 2 Cú đấm bị đỡ bằng cách gạt từ ngoài vào trong. 3 Động tác chuyển thành một cú đấm đi vào theo hướng chéo xuống dưới. 4 Kết thúc bằng một cú móc vào gan.




- 1 Tấn công bằng một cú đấm (Hiraken).
- 2 Cận cảnh.

- 1 Dùng đầu ở thế nằm sàn.
- 2 Nhìn từ bên.

- 1 Đòn tấn công vung vào của đối phương bị vô hiệu hóa bằng cách chủ động tiến lên trong khi che đầu. 2 Đối phương tấn công càng mạnh thì sức ép càng được truyền nhiều vào xương ức của kẻ đó.



- 1 Bằng cách ấn bằng các khớp đốt ngón tay (cũng có thể dùng động tác miết) và kéo phía sau đầu kẻ đó về phía trước, đối phương bị buộc phải nghiêng người tới trước – trong trường hợp này là vào một đòn bẩy cổ.

## 3.3 Cơ ngực

“Musculus pectoralis major” (cơ ngực lớn) che phủ toàn bộ vùng sườn phía trước. Các sợi cơ chồng lên nhau ở cánh tay: Những sợi đi lên trên gắn vào cánh tay trên ở vị trí cao hơn những sợi xuất phát từ xương đòn. Chúng tạo thành một vòm, trong đó giới hạn phía trước tạo nên nách. Cơ ngực lớn được chi phối bởi nervus pectoralis lateralis và nervus pectoralis medialis. Tấn công: Kẹp nách giữa các ngón tay của bàn tay.

- 1 Túm lấy để phòng thủ trước ý đồ túm vai.
- 2 Việc phòng thủ thành công nhờ dùng thế kẹp bằng bàn tay để tìm cơ ngực.
- 3 Cận cảnh.

Hiệu quả: Đau.

Bình luận về cách dùng: Cần đẩy đối phương lùi về phía sau; đây là một kỹ thuật ít nguy hiểm.

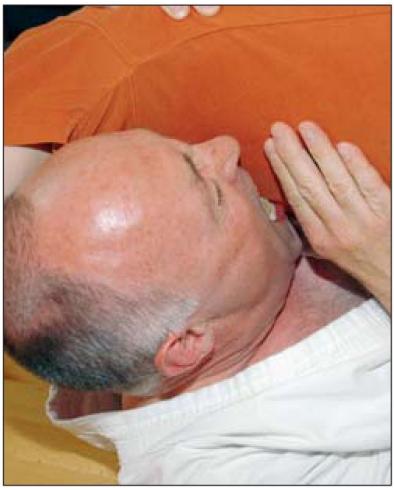
Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

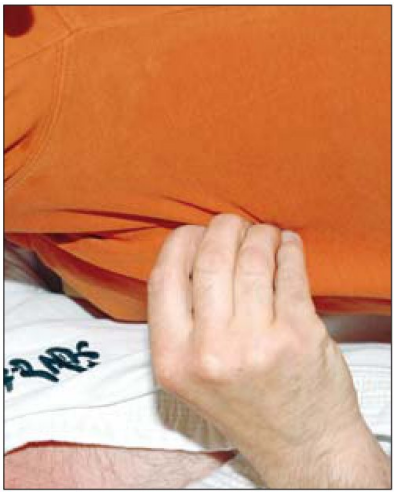
## 3.4 Núm vú / Tuyến vú / Glandula mammaria

Nguồn cấp mạch và sự chi phối thần kinh của núm vú nam giới, ở mức độ nhỏ hơn, tương tự như của các tuyến ở nữ giới.

Cảm giác của các tuyến vú được chi phối bởi các nhánh của thần kinh liên sườn (nervi intercostales), chạy như các nhánh vú trong và ngoài tới vùng chi phối của chúng.

Tấn công: Cắn hoặc véo (thế kẹp).





Hiệu quả: Đau.

Bình luận về cách dùng: Thường được quần áo che chắn hoặc bảo vệ tốt.

## 3.5 Tinh hoàn

Tấn công: Đá (bằng bàn chân hoặc đầu gối), đấm, túm.

Ví dụ về phòng thủ. Hiệu quả: Độ nhạy cảm chính của tinh hoàn với đau đến từ các sợi thần kinh cảm giác (các nhánh của nervus genitofemoralis) của bìu.

Vì cơ quan sinh dục cũng được chi phối bởi hệ thần kinh đối giao cảm, nó có thể – như mọi khi hệ thần kinh này tham gia – dẫn đến hạ huyết áp hoặc làm chậm nhịp tim và nhịp thở. Những hậu quả có thể xảy ra của các tác động này nhiều khả năng gồm nôn, bất tỉnh và ngừng tim.13 Trong các trường hợp chấn thương tù, có nguy cơ làm tổn thương các động mạch cấp máu và chảy máu bên trong bìu. Chọc thủng bìu có thể dẫn đến viêm tinh hoàn hoặc thậm chí áp-xe. Do ống âm đạo (processus vaginalis) thông với khoang bụng, có thể xảy ra viêm phúc mạc.

Do đó, dùng lực đáng kể ở vùng này có thể gây vô sinh vĩnh viễn.

Một cú đá vào vùng này có thể khiến tinh hoàn bị đẩy vào khoang bụng, kèm theo đau dữ dội. Cũng có thể xương mu bị tổn thương (xem mục 3.17).

Đau âm ỉ và một vết bầm nhỏ có thể là dấu hiệu của một vết dập tinh hoàn ít nguy hiểm. Bầm tím rõ rệt và đau nhiều, có thể kèm buồn nôn, là dấu hiệu của một tổn thương nghiêm trọng hơn. Trên hết, sau một tổn thương mà không thể sờ thấy riêng từng tinh hoàn, cần phải đi khám bác sĩ niệu khoa.

Bình luận về cách dùng: Vùng này luôn được bản năng bảo vệ, trong khi các hành động tiếp theo vẫn có thể thực hiện, kể cả khi mục tiêu không bị đánh trúng.

- 1 Tình huống bị dùng đòn bẩy cổ.
- 2 Phòng thủ bằng cách tung một cú đánh bằng cẳng tay vào tinh hoàn.

CHÚ Ý!! Hãy chắc chắn rằng cánh tay đối phương đang quàng quanh cổ đã lỏng và được khống chế. Điều này giúp người tấn công tránh được tình huống cẳng tay đánh vào tinh hoàn. Phản xạ của đối phương thường có xu hướng làm chặt thêm thế siết quanh cổ.

- 3 Cận cảnh cú đánh.
- 4 Cách phòng thủ khác: cú đấm móc vào tinh hoàn.

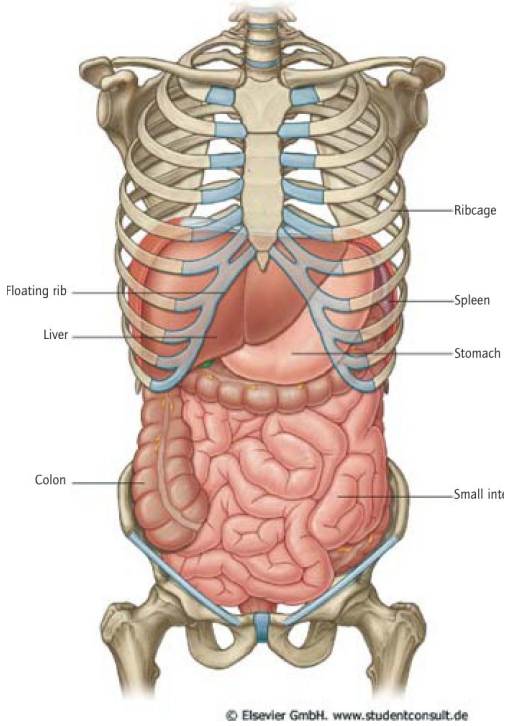
- 1 Việc siết, vặn và giật tinh hoàn tốt nhất nên luyện tập bằng một vật như một nắm tất cuộn lại.

- 1 Kỹ thuật khởi đầu: Đá vào hõm phía sau đầu gối.
- 2 Cú đá vào tinh hoàn được thực hiện từ phía sau.
- 3 Biến thể: Đá bằng các ngón chân.

- 1 Một cú đá quét mở ra tư thế đứng của đối phương.
- 2 Bắt đầu cú đá quét. Chân trụ của người quét nằm hẳn ra ngoài tư thế đứng của đối phương để tạo thêm lực. 3 Khoảng cách (giữa hai bàn chân) được nới dài.
- 4 Dùng bàn chân quét, cú đá được tung trực tiếp.
- 5 Phương án khác: Đá bằng chân kia.

- 1 Cú đá thấp phía trong – qua đó làm dài khoảng cách.
- 2 Cứng đánh vào mềm.

## 3.6 Gan




Lồng ngực · Xương sườn cụt · Lách · Gan · Dạ dày · Đại tràng · Ruột non Sơ đồ 16 Gan nằm ở phía bên phải của bụng trên và chạy xuống tới tận xương sườn cụt dưới cùng bên phải. Đây là cơ quan trung tâm của toàn bộ quá trình chuyển hóa trong cơ thể và là tuyến lớn nhất. Gan được giữ trong một bao màng. Chỉ có màng này mới có mạng lưới dày đặc các dây thần kinh mảnh có khả năng báo tín hiệu lên não. Tấn công: Đá, đấm. Móc vào gan. Hiệu quả: Nhiều cơ quan nội tạng, cũng như gan, được cung cấp một lượng máu lớn. Nếu bị đánh mạnh, có nguy cơ vỡ gan và chảy máu nội tạng kín đáo. Do tính chất "kín đáo" của nó, kiểu chảy máu nội tạng này rất âm thầm. Một chấn thương tù vùng bụng như vậy, trên hết, có thể dẫn đến tử vong do sốc vì mất máu nhiều từ chảy

máu nội tạng. Các triệu chứng khác gồm đau khi ấn, buồn nôn, vẻ mặt nhợt nhạt và xanh xao (do sốc), chóng mặt và nôn. Nói chung, với những tổn thương như vậy, có nguy cơ chảy máu nội tạng. Điều này có thể phát triển trong khoảng vài ngày. Cũng có thể các tĩnh mạch tuy không vỡ nhưng bị tổn thương nặng đến mức khi bị vận động lại (ví dụ khi chơi thể thao) có thể vỡ tự phát, và điều đó lại dẫn đến chảy máu nhiều. Điều này cũng có thể gây biến chứng và cuối cùng dẫn đến tử vong trong những trường hợp xấu nhất.

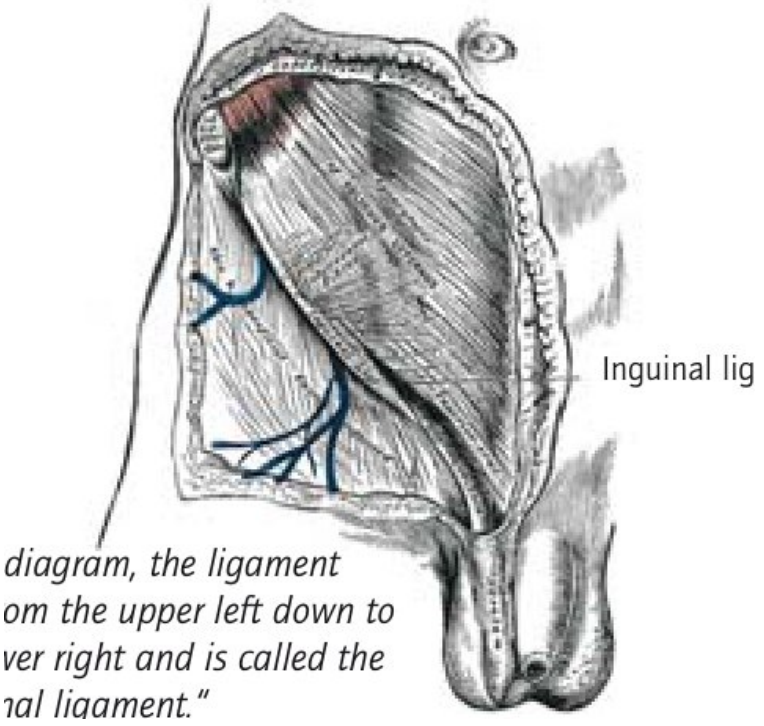
Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

1 Đòn tấn công bằng nắm đấm bị đỡ bằng cả hai tay.

- 3 Móc vào gan. 4 Cận cảnh. 5 Túm lấy cánh tay°.
- 6 °và khống chế vai°.

- 7 °và chuyển kỹ thuật sang việc tung một cú đá đầu gối vào gan, đồng thời kéo bằng cả hai tay.

## 3.7 Bẹn




Dây chằng bẹn Sơ đồ 17 Tấn công: Đấm, đá, chọc bằng ngón tay.

*Trong sơ đồ, dây chằng · chạy từ trên bên trái xuống · dưới bên phải và được gọi là · "dây chằng bẹn."*

- 1 Một cú đá định tung ra bị phản đòn bằng cách đá vào bẹn.

- 3 Bẹn bị đánh trúng. Cú đá vào bẹn phải được thực hiện theo hướng chéo (chân trái đá vào bẹn trái của đối phương và ngược lại). Nếu bạn không đá theo hướng chéo, đối phương có thể phản đòn bằng cách tung một cú đá vào phía hở, vì trọng tâm của đối phương sẽ không bị cú đá tác động. Hiệu quả: Đau, vỡ thoát vị.

Vùng bẹn, đặc biệt là ống bẹn (canalis inguinalis), là một điểm yếu nổi tiếng. Nó chạy phía trên dây chằng bẹn. Tại điểm này, có thể xảy ra thoát vị, điều này cũng có thể xảy ra sau khi thân thể gắng sức nhiều. Nội dung của khoang bụng (màng bụng) có thể lồi ra qua thành bụng. Cơn đau do đó có thể nhẹ đến nặng và co thắt từng cơn. Có thể sờ thấy một khối cứng ở phía trên bẹn. Thoát vị rất nguy hiểm, trên hết khi các cơ quan trong khoang bụng (như ruột) bị kẹt trong chỗ vỡ. Do đó, đoạn ruột bị kẹt càng sưng thêm, và vì vậy bị cắt khỏi nguồn cấp máu. Hiện tượng này gọi là nghẽn kẹt (strangulation) và có thể dẫn đến hoại tử phần cơ quan bị kẹt. Ngoài ra, có thể xảy ra tình trạng tắc ruột (ileus). Cả hai tình huống đều đe dọa tính mạng và cần được phẫu thuật can thiệp ngay. Trong một số trường hợp, cần phải cắt bỏ một phần (resection).

Bình luận về cách dùng: Điều này khiến đối phương có khả năng gập người ở hông, mở ra khả năng cho các hành động tiếp theo.

Bẹn là một mục tiêu tốt để làm đối phương mất thăng bằng, đặc biệt khi kẻ đó có phần thân mình được đệm dày. Một cú đá vào bẹn từ thế áp sát. QUAN TRỌNG! Cánh tay phải của đối phương phải bị ghì chặt, nếu không kẻ đó có thể túm lấy chân đang tấn công và khiến người phòng thủ ngã.

- 1 Cách giữ hai bàn tay khi chọc ngón tay vào bẹn.
- 3 Từ một góc nhìn khác.

## 3.8 Dạ dày

Để xem minh họa, hãy xem phần “Gan”.

Tấn công: Đấm, đá.

- 1 Tình huống áp sát. 2-6 Chuỗi các cú đá đầu gối vào vùng dạ dày.

Hiệu quả: Đau, thủng dạ dày.

Thành dạ dày có thể vỡ sau một cú đánh tù, nghĩa là các chất chứa trong đó sẽ tràn vào khoang bụng. Bắt đầu những cơn đau dữ dội đột ngột kèm theo nôn, căng thành bụng và các triệu chứng sốc.

Vỡ thành dạ dày luôn phải được coi là một trường hợp cấp cứu, vì nếu không được điều trị có thể gây tử vong. Nguy hiểm chính của thủng dạ dày là viêm phúc mạc kèm nhiễm trùng máu (nhiễm khuẩn huyết) về sau, do các chất chứa trong dạ dày thoát vào khoang bụng. Nguy hiểm lớn hơn nếu dạ dày đầy.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

## 3.9 Lách

Xem minh họa trong phần “Gan”.

Ở người, lách là một cơ quan cỡ bằng nắm tay nằm dưới xương sườn thứ tám và thứ chín ở phía bên trái của bụng trên, bên dưới cơ hoành và phía trên thận trái. Cơ quan này chứa một lượng máu lớn.

Tấn công: Đấm, đá, đá đầu gối.

- 1 Cú đấm móc vào lách.
- 2 Cận cảnh.
- 3 Sau đó cánh tay đối phương bị khống chế.
- 4 Đòn tấn công tiếp theo vào lách bằng cùi chỏ. Hiệu quả: Nếu các xương sườn bên trái bị tổn thương, có khả năng lách bị vỡ (trong một số trường hợp biểu hiện là đau ở bụng trên), nghĩa là nó có thể chảy máu vào khoang bụng, điều mà tất nhiên không thể thấy từ bên ngoài. Bao lách có thể cầm máu trong một thời gian ngắn, đó là lý do các triệu chứng đầu tiên xuất hiện sau vài ngày.

Sốc giảm thể tích (hypovolemic shock) như thế này (còn gọi là sốc do thiếu khối lượng máu) phát sinh do lượng máu trong lòng mạch (trong các mạch máu) không đủ. Hậu quả thường là bất tỉnh, cũng như ngừng thở và ngừng tim. Mất khoảng 50% lượng máu gần như luôn gây tử vong nếu không được chăm sóc y tế.

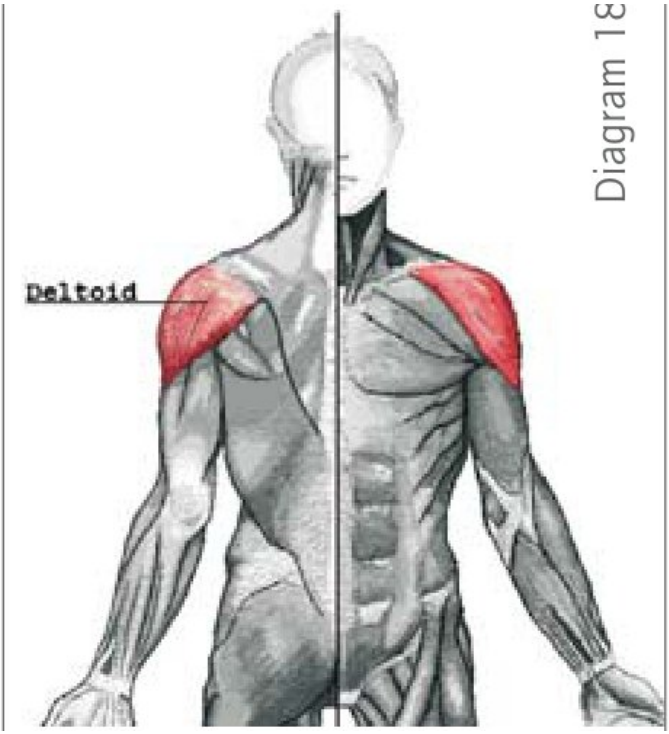
Nếu sốc không được điều trị trong một thời gian dài, có thể xuất hiện sốc không hồi phục và có nguy cơ suy thận và suy đa cơ quan gây tử vong.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

- 1 Một ví dụ khác: Cú đá đầu gối vào lách.
- 2 Cận cảnh.

## 3.10 Cơ delta

Xem thêm các minh họa trong phần Sơ đồ 18 “Nách” và “Xương đòn / Xương quai xanh”.




Musculus deltoideus (cơ delta) là một cơ xương hình tam giác nằm trên khớp vai như một tấm phủ và tạo sự vững chắc cho khớp bằng cách ép chỏm khớp của xương cánh tay trên vào ổ của nó. Chức năng của nó là nâng cánh tay trên.

Tấn công: Đấm (bằng nắm đấm, cùi chỏ).

Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Tổn thương các cơ quan hoặc các phần của cơ thể do lực tù, trực tiếp từ bên ngoài gây ra mà không có tổn thương da thấy được, được gọi là dập. Điều này tạo ra phù (sưng) các mô và thoát mạch máu từ các mao mạch bị tổn thương vào mô xung quanh và có thể biểu hiện thành một vết bầm. Nói chung, đau xuất hiện ngay và hạn chế vận động. Trong trường hợp sưng lớn hơn, có thể xảy ra cứng cơ.

Các hiện tượng tương tự xảy ra trong trường hợp dập khi mô cơ thể bị ép lại với nhau. Khi một sợi cơ bị rách, các sợi lưới bị tổn thương và xuất hiện các triệu chứng viêm tại chỗ. Đồng thời, tình trạng giảm trương lực cục bộ (trạng thái căng của cơ) thấy rõ ở vùng bị tổn thương. Với những vết rách ở các cơ lớn hơn, đôi khi có thể thấy những chỗ lõm rõ ràng hoặc cơ bị thắt lại thành nút ở vùng bị

ảnh hưởng.

Huyết khối ít có khả năng xảy ra.

Rách mạc (fascia) gần như khó xảy ra; tuy nhiên, có thể xảy ra hội chứng khoang (sưng trong cơ kèm giảm tuần hoàn máu, tăng áp lực và, nếu không điều trị, có thể hoại tử).

Cũng có thể làm tổn thương ổ khớp cánh tay và các gân của nhóm cơ chóp xoay, vốn tạo thành một vòng đai quanh toàn bộ vai.

Cũng có thể có ảnh hưởng lên nervus axillaris, dây xuất phát từ đám rối cánh tay và chi phối musculus deltoideus.

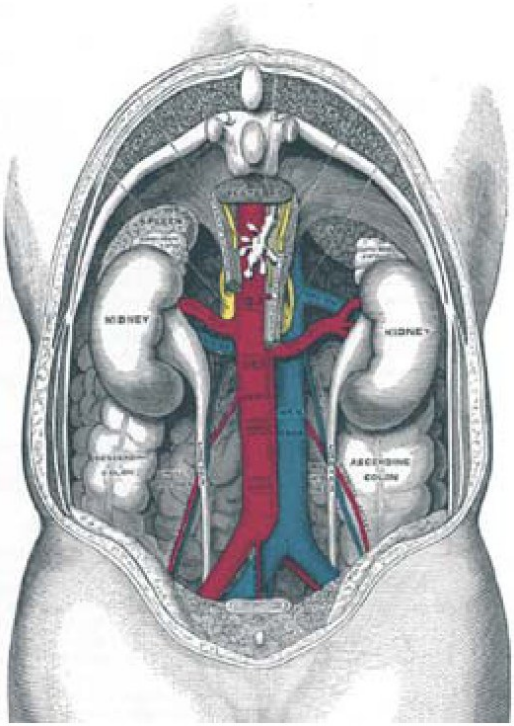
Bình luận về cách dùng: Những hạn chế về vận động có thể được suy ra từ các trình bày ở trên. Hiệu quả bị hạn chế ở nơi cơ phát triển tốt (thể lực sung mãn); bề mặt tác động nhỏ làm tăng hiệu quả.

- 1 Các ví dụ về những đòn đánh tấn công vào vai°. 2 °.bằng nắm đấm°.
- 3 °.và bằng cùi chỏ.

- 1 Cú đánh bằng cùi chỏ vào phía sau cơ delta có thể dùng để vặn xoay đối phương.
- 2 Tư thế bất lợi này được người phòng thủ dùng để thực hiện một đòn Hadaka-Jime (“khóa siết trần”).
- 3 Đối thủ bị quật xuống quỳ trên đầu gối.

Sau khi phòng thủ thành công, ở đây cú đánh vào musculus deltoideus tạo thêm hỗ trợ để xoay đối phương lại và quật kẻ đó ngã về phía sau.

## 3.11 Thận

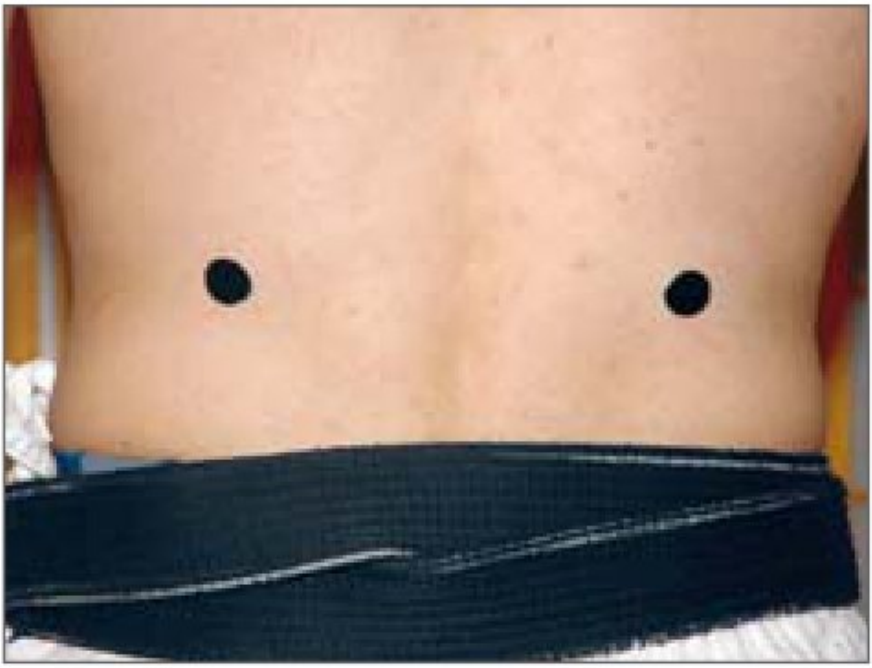



Sơ đồ 19 Vị trí của hai quả thận. Hình phẫu tích nhìn từ phía sau.

Chức năng của thận là bài tiết các sản phẩm thải bề mặt do quá trình chuyển hóa tạo ra cùng các độc tố và rửa chúng ra khỏi cơ thể qua đường tiểu. Mỗi người có hai quả thận nằm bên trái và bên phải cột sống, bên dưới cơ hoành và được bảo vệ bởi một bao mỡ. Mỗi quả có hình dạng như hạt đậu và dài khoảng 10–12 cm. Mỗi quả thận được bảo vệ bởi một bao mô liên kết mỏng, chắc quanh cơ quan và nằm, cùng với các tuyến thượng thận, được đặt và đệm

trong một bao mỡ. Chúng được bảo vệ một phần bởi các xương sườn phía trên chúng (cặp xương sườn thứ 11 và 12).

Tấn công: Đánh (nắm đấm, cùi chỏ), đá đầu gối. Điểm mục tiêu.



Hiệu quả: Mọi dạng tổn thương ở thận đều có thể được định nghĩa là chấn thương thận. Trẻ em có nguy cơ cao hơn do thiếu mô mỡ đệm để hấp thụ chấn động.

Chấn thương thận có thể được chia thành dập hay bầm, vỡ hay rách thận, và phá hủy hoàn toàn quả thận. Các triệu chứng chiếm ưu thế là khối ở mạng sườn, đau mạng sườn và thấy máu trong nước tiểu – tuy nhiên, triệu chứng sau không nhất thiết tương quan với lượng máu trong nước tiểu. Nếu niệu quản bị tắc hoàn toàn bởi các cục máu đông hoặc nếu các mạch máu cuống thận bị đứt lìa, có thể hoàn toàn không có máu trong nước tiểu.

Các triệu chứng bổ sung: Bầm máu cục bộ (tụ máu), đau dữ dội, có thể rò nước tiểu từ vết thương hở (do đâm hoặc bắn).

Mất máu do thận vỡ có thể gây tử vong vì sốc.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

1 Đòn bẩy cổ được hỗ trợ bằng cách tung một cú đánh bằng khớp đốt ngón trỏ ở phía ngón cái của bàn tay.

- 1 Bước tiến của đối phương bị đỡ gạt qua một bên thân° 2 °và sau đó kẻ đó bị xoay thêm bằng một cú đá thấp.
- 3 Hành động được tiếp nối bằng hai cú móc vào thận.
- 5 Chuyển sang khống chế đầu và bẻ kẻ đó ngả về phía sau.
- 6 Kết thúc: Đá bằng đầu gối trái vào thận.

## 3.12 Vùng thận / Các nếp da

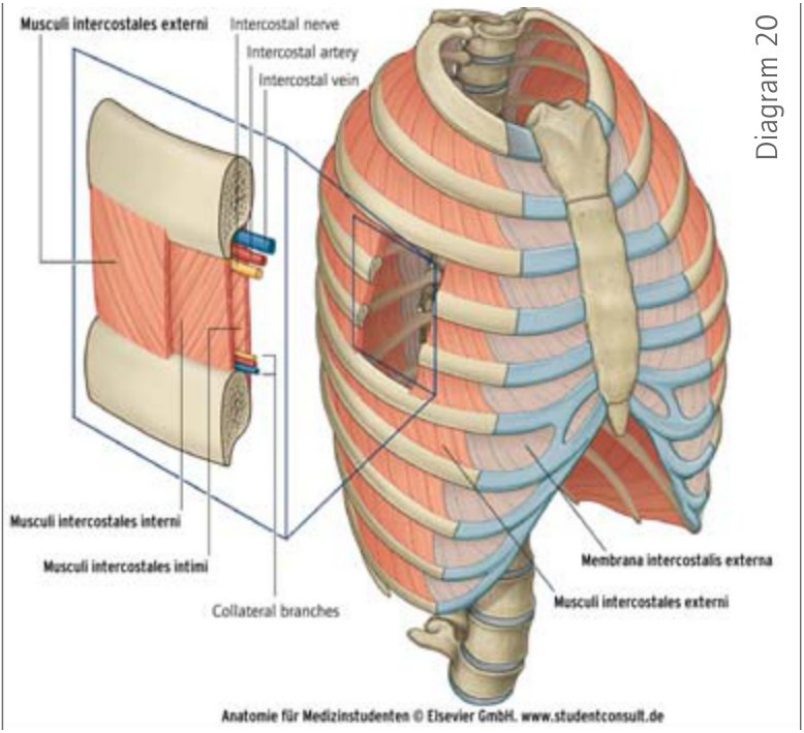
Tấn công: Túm các nếp da ở vùng thận bằng cả hai tay và siết.

Hiệu quả: Đau (khác nhau tùy từng người).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người – một kỹ thuật ít nguy hiểm.

## 3.13 Xương sườn

Xem thêm minh họa trong phần “Xương ức”.




Sơ đồ 20 Con người có 12 cặp xương sườn. Bảy xương sườn trên được gọi là xương sườn ức (còn gọi là “xương sườn thật”) và chúng nối trực tiếp với xương ức qua sụn sườn. Xương sườn 8–10 được gọi là xương sườn không ức, gắn vào lồng sụn sườn, và hai xương sườn dưới cùng kết thúc tự do trong các cơ ngực. Các cặp xương sườn 8–12 được định nghĩa là “xương sườn giả”. Xương sườn 11 và 12 được gọi là “xương sườn cụt” và kết thúc tự do trong thành bụng.

Tấn công: Đánh, đá (bàn chân, đầu gối), kẹp thân – đặc biệt nhắm vào các xương sườn cụt.

- 1 Cú đấm móc bị chặn.
- 2 Khống chế cổ.
- 3 Cú đá thấp vào các xương sườn ngắn bằng xương chày.

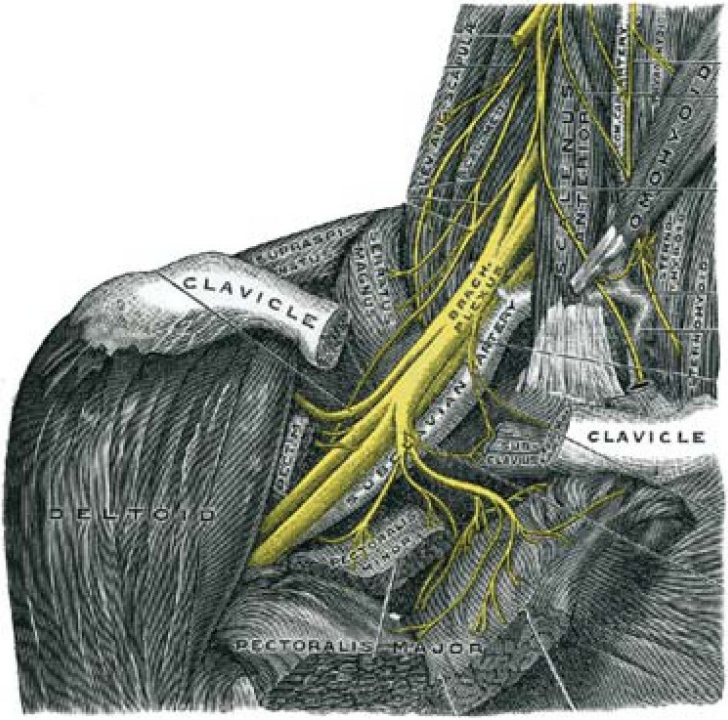
Hiệu quả: Đau dữ dội, vấn đề hô hấp, bầm tím, gãy xương, tổn thương nội tạng (gan, lách, phổi, thận).

Do tác động từ bên ngoài, chức năng của các cơ liên sườn có thể bị ảnh hưởng (chúng nâng và hạ các xương sườn), và điều này cản trở hô hấp. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của cơ hoành. Nói chung, xương sườn lành tốt. Về gãy xương sườn, đôi khi xảy ra tình trạng tràn khí màng phổi (không khí tích tụ trong khoang màng phổi). Điều này ảnh hưởng đến việc giãn nở của một hoặc cả hai lá phổi, có thể đe dọa tính mạng tùy mức độ nặng. Cũng có thể xảy ra dập phổi (có thể gây tử vong nếu không điều trị) hoặc chảy máu nội tạng của phổi (tràn máu màng phổi) vào lồng ngực. Nếu một lá phổi xẹp hoàn toàn, có thể dẫn đến các vấn đề về tim. Điều này là vì tim được giữ đúng vị trí nhờ các lá phổi, và trong trường hợp phổi xẹp, chức năng này không còn. Tổn thương lách có thể xảy ra khi một xương sườn bên trái đâm vào nó hoặc khi nó vỡ độc lập. Trong trường hợp gãy lồng ngực bên phải, có thể xảy ra tổn thương gan.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.

- 1 Đầu gối được nâng lên sang một bên°.
- 2 °.và đưa vào mục tiêu bằng một động tác hông như roi quất.

## 3.14 Xương đòn / Xương quai xanh




Sơ đồ 21 Xương đòn của người – nhìn từ trên xuống (ở đây thể hiện vai phải) Sơ đồ 22 Xương đòn là một xương hình chữ S, dài khoảng 12–15 cm. Xương đòn là một phần của đai vai. Nó nối xương ức với mỏm cùng vai – một phần của xương bả vai. Tấn công: Đánh (cạnh bàn tay, đáy nắm đấm, cùi chỏ) vào hõm xương đòn (gờ cong gần vai nhất).

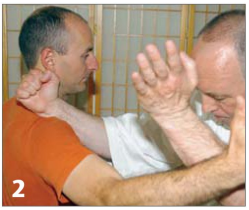
Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Ở người lớn, gãy xương đòn là loại gãy phổ biến thứ hai sau gãy xương quay. Nó có thể do một cú đánh trực tiếp và (đôi khi nhẹ) vào xương đòn. Các biến chứng gồm tổn thương mạch máu (arteria subclavia) hoặc tổn thương thần kinh (plexus brachialis), nơi thấy một vết bầm lớn. Brachialgia là thuật ngữ y học chỉ cơn đau ở cánh tay, gây ra bởi sự cọ xát cơ học hoặc chèn ép đám rối cánh tay. Khi xảy ra rách một phần (hoặc tổn thương khác) các sợi thần kinh riêng lẻ, điều này dẫn đến tình trạng bất động một phần của cánh tay và bàn tay. Dấu hiệu đầu tiên của vấn đề thường là cảm giác châm chích.

Khi xảy ra tổn thương đám rối cánh tay, có thể xuất hiện tình trạng suy giảm hoàn toàn (liệt) và mất cảm giác của các cơ ở chi trên.

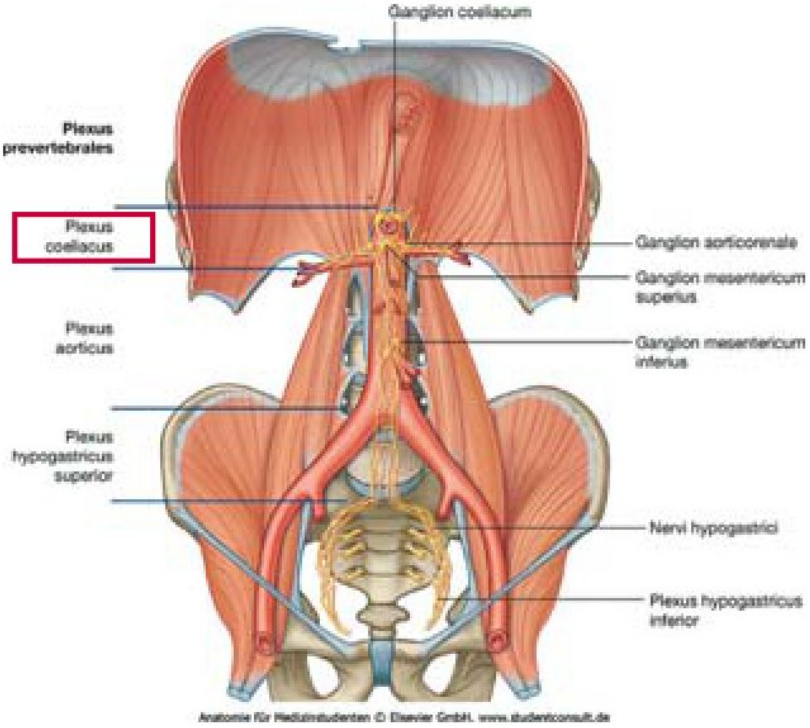
Triệu chứng của gãy xương đòn: Xuất hiện chỗ sưng thấy được và sờ thấy được hoặc những bậc trên đường chạy của xương, đau dữ dội khi ấn hoặc khi vận động. Người bị thương đưa cánh tay trên vào một tư thế giảm đau và vai nhô rõ ra phía trước. Chỗ gãy cũng có thể gây thủng phổi. Cánh tay trở nên bất động và không dùng được.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai mặc quần áo dày.



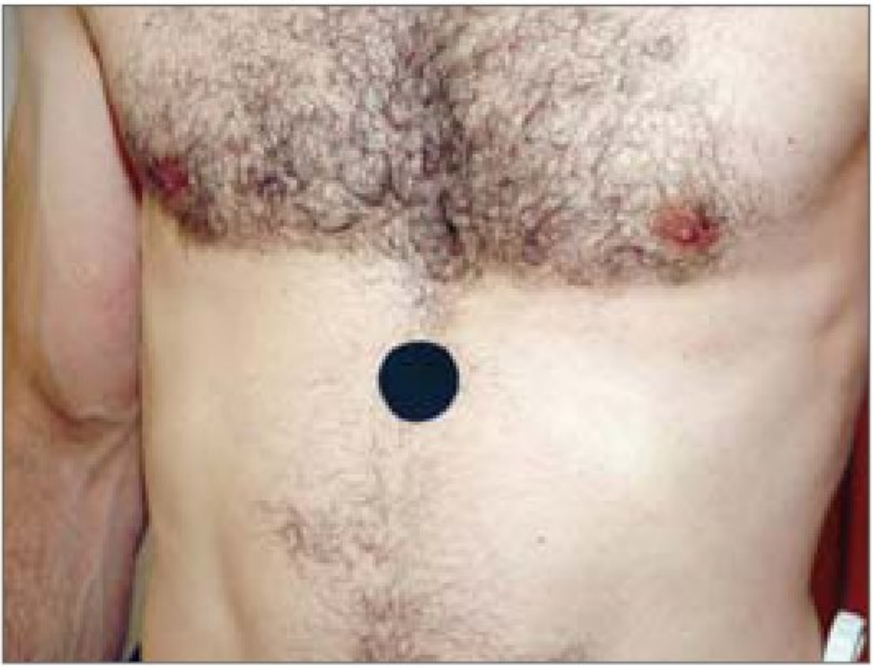
- 1 Đánh bằng cạnh bàn tay vào xương đòn (Shuto-Sakotsu-Uchi).
- 2 Đánh bằng cẳng tay.

## 3.15 Đám rối dương / Plexus coeliacus




Sơ đồ 23 Đám rối dương (plexus coeliacus) là một mạng lưới các dây thần kinh thực vật, có nguồn gốc ở phía trước động mạch chủ bụng trên (và do đó nằm tương đối xa khỏi bề mặt dạ dày). Nó chạy tới dạ dày và các cơ quan tiêu hóa trên. Nó nằm giữa đốt sống ngực thứ 12 và đốt sống thắt lưng thứ nhất.

Nó được cấp bởi các phần giao cảm (thoracic sympathikus) và đối giao cảm (nervus vagus) của hệ thần kinh thực vật.



Tấn công: Đấm/đá mạnh vào một vùng cỡ bằng bàn tay nằm hơi lệch về bên trái so với đường giữa, ở một phần ba trên của đường nối giữa rốn và xương ức. Sóng nén sau đó sẽ lan tới đám rối.

Điểm mục tiêu. 1) Chức năng của plexus coeliacus là kích thích các tuyến của niêm mạc dạ dày và các cơ quan tiêu hóa trên, cũng như kích thích các cơ dạ dày và các đoạn trên của ruột non. Tuy nhiên, nó cũng là một trung tâm điều khiển: Những hạt lạ có hại lọt vào dạ dày, như thức ăn thối hoặc có độc, bị tống ra ngay – kèm theo buồn nôn và nôn. Như vậy, hướng của "sóng nhu động" bị đảo ngược và như một biện pháp bảo vệ, các chất chứa trong dạ dày được đưa lên và tống ra. Trong một phản xạ, các cơ dạ dày bị căng lên để đạt đủ áp lực đẩy qua van ở thực quản.

Hiệu quả: Sức căng cơ học nặng dẫn đến cùng hiệu quả, đặc biệt khi nó xảy ra trong lúc hít vào, vì vào lúc đó các cơ bảo vệ của dạ

dày đang giãn ra và một cú đánh từ bên ngoài, như một đòn chân hoặc đòn đấm, có thể tác động đầy đủ vào chiều sâu.

2) Một cú đánh vào plexus coeliacus cũng có thể dẫn đến bất tỉnh:

Một cú đánh từ bên ngoài cũng có thể gây ngất phế vị–phế vị (vagovasal syncope) qua mối liên hệ của nervus vagus với trung tâm nhịp tim và với tim. Khi hệ thần kinh thực vật bị kích thích đột ngột, mạnh mẽ, trung tâm nhịp tim ở vùng dưới đồi phản ứng quá mức và điều này đột ngột mở rộng các mạch máu của ruột, vùng tĩnh mạch cửa, gan, thận và một số cơ quan khác. Có sự sụt huyết áp kèm theo tình trạng thiếu tuần hoàn máu lên não trong chốc lát (một cơn "tối sầm"), và người đó ngã xuống. Thông thường, tình trạng này qua đi sau vài giây và người ta tỉnh lại nhanh chóng vì khi nằm xuống, huyết áp nhanh chóng tự ổn định.

3) Đau, khó thở.

4) Cần nhớ rằng nhiều cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, lách và cả thận, có dòng tuần hoàn máu tốt. Nếu những cơ quan như vậy bị đánh mạnh, có nguy cơ vỡ gan, lách, dạ dày bên cạnh (xem phần thích hợp), hoặc hoại tử tụy (chết mô tụy), và sau đó là chảy máu nội tạng kín đáo. Kiểu chảy máu nội tạng như vậy hiểm độc chính vì nó vô hình. Quá trình này có thể phát triển trong khoảng vài ngày.

Cũng có thể tuy tĩnh mạch không vỡ nhưng sẽ bị tổn thương đến mức nếu lại bị căng (ví dụ khi chơi thể thao), nó sẽ vỡ tự phát kèm chảy máu nặng. Chảy máu có thể rất nghiêm trọng và thậm chí dẫn đến tử vong.

Bình luận về cách dùng: Có thể gặp khó khăn khi đối mặt với người cơ bắp dày hoặc người béo, cũng như bất kỳ ai đang mặc quần áo dày. Khi người đó đang hít vào, hiệu quả tăng lên vì các cơ bảo vệ của dạ dày đang giãn ra.

- 1 Cú đấm Gyaku-tsuki vào đám rối dương.

Một cú đấm nhanh vào đám rối dương có tác dụng phá vỡ sức kháng cự lại việc bị quật ngã ở đây.

## 3.16 Xương cụt

Xem minh họa trong mục 2.2 (“Gáy”).

Xương cụt của người là điểm thấp nhất của xương cùng, mà xương cùng lại nằm ở cuối cột sống. Đầu tận của tủy sống không nằm ở đáy cột sống (tức xương cụt) mà nằm ở đầu phần thắt lưng của cột sống. Chạy xuống dưới theo hướng xương cụt là các dây thần kinh (plexus coccygeus), chỉ có chức năng cảm giác (da).

Nếu bị đá hoặc bị ngã xuống xương cụt, nó có thể bị trật khớp, rất đau. Người bị thương gần như không thể ngồi được vì đau, và quá trình lành rất lâu. Việc điều trị của bác sĩ được thực hiện qua đường trực tràng. Cũng có thể cần phẫu thuật.

Tấn công: Đá bằng đầu gối (khi đứng hoặc khi nằm), đá.

- 1 Cú đấm bị đỡ.
- 2 Đầu đối thủ bị xoay và ghì chặt lên vai mình.
- 3 Cú đá đầu gối vào xương cụt.

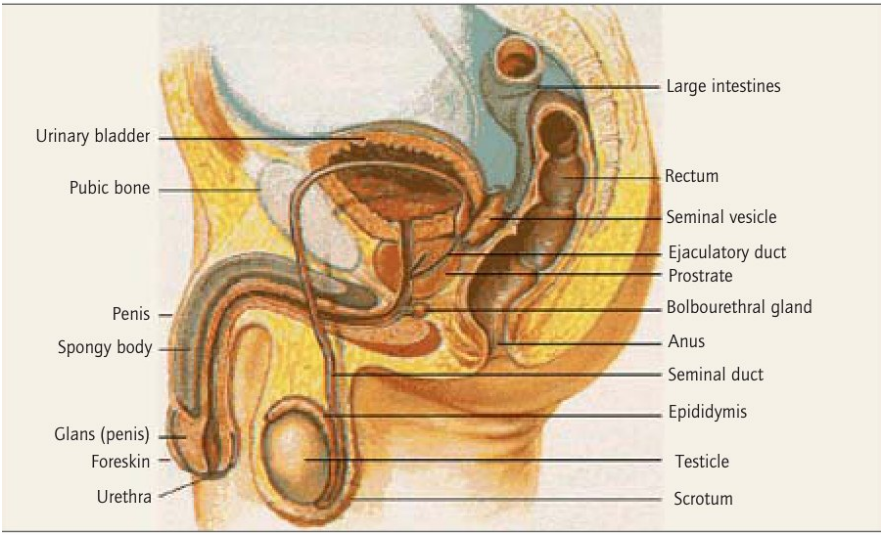
Hiệu quả: Đau, rối loạn cảm giác nhẹ. Ở tư thế đứng, phải ở phía sau người kia.

## Bình luận về cách dùng:

- 1 Thu chân đá về.
- 2 Cú đá đầu gối đang được tung tới.

- 3 Trúng mục tiêu!

## 3.17 Bụng dưới (Bàng quang, Ruột, Xương mu)




Đại tràng · Bàng quang · Trực tràng · Xương mu · Túi tinh · Ống phóng tinh · Tuyến tiền liệt · Tuyến hành niệu đạo · Dương vật · Hậu môn · Thể xốp · Ống dẫn tinh Sơ đồ 24 Mào tinh · Quy đầu (dương vật) · Bao quy đầu · Tinh hoàn · Niệu đạo · Bìu. Xem minh họa cho “Ruột” và phần “Gan”.

Tấn công: Đấm, đá, đá đầu gối.

- 1 Động tác phòng thủ ngay trước một đòn tấn công đang tới.
- 2 Chuẩn bị đá. 3 Cú đá tới trước vào bụng dưới bằng gót chân.

Hiệu quả: Đau do va đập vào bụng, tổn thương nội tạng, nhu động ruột dữ dội.

Bàng quang chỉ bị đẩy vào khoang bụng khi bàng quang không quá đầy. Khi bàng quang đầy mà bị một cú va đập chấn thương từ bên ngoài, nó có thể vỡ và tống các chất chứa vào khoang bụng (vỡ bàng quang trong phúc mạc). Triệu chứng là đau ở bụng dưới và cảm giác buồn tiểu mạnh mẽ trong khi đồng thời không thể tiểu được. Một nguy hiểm đặc biệt là viêm phúc mạc.

Vỡ thành ruột chỉ có thể xảy ra sau một cú đánh vào một diện tích bề mặt lớn (ví dụ tai nạn giao thông). Có thể xảy ra tổn thương ở vùng khớp mu (tổn thương sụn và dây chằng).

Bình luận về cách dùng: Người cơ bắp dày hoặc người béo dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công vào khớp mu.

# Chương 4 — Các điểm tấn công trên cánh tay

*Chapter 4 — Attack Points on the Arms*

## 4.1 Da của cánh tay

Da ở vùng phía sau cánh tay trên.

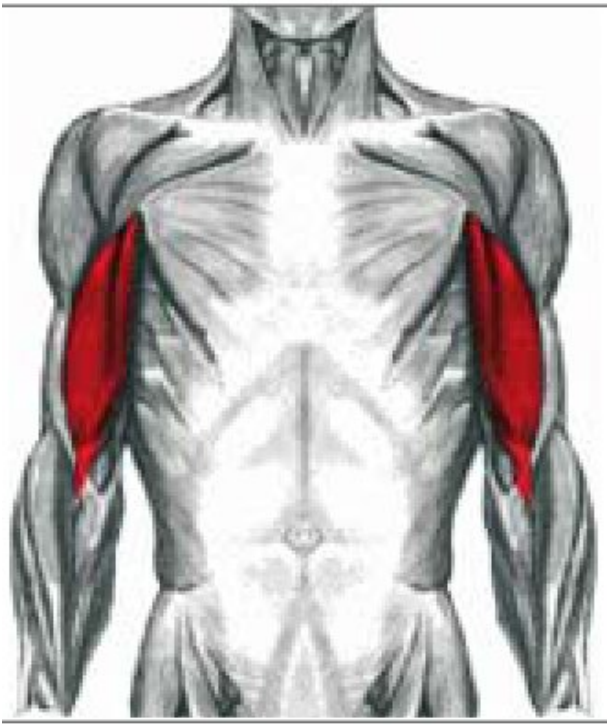
Tấn công: Véo.

1 Túm cổ áo. 2 Nhón lấy nếp da mỏng. 3 Cùi chỏ đối phương bị ghì chặt vào thân mình. Hiệu quả: Đau – Trong lớp bì (lớp sâu bên trong của da), có các đầu tận thần kinh tự do (thụ thể đau). Độ dày thay đổi theo vùng cơ thể (tới 200 thụ thể trên mỗi $cm^2$ da).

Bình luận về cách dùng: Một lần nữa, ở đây mức độ đau và hiệu quả khác nhau giữa mỗi người; có thể dùng như một đòn giải thoát.

- 1 Với một đòn tấn công bằng Hadaka-jime (khóa siết bằng cánh tay trần), thanh quản được bảo vệ trong hõm khuỷu tay đối phương. Da ở phía sau cánh tay trên bị véo mạnh, nhanh và liên tục. Điều này gây kích thích quá mức vùng đó, có thể tăng thêm bằng cách cắn vào cơ nhị đầu.

## 4.2 Cơ nhị đầu / Musculus biceps brachii



Sơ đồ 25 Tấn công: Đấm bằng nắm đấm, cạnh bàn tay, cùi chỏ.

- 1 Cú đấm vung bị chặn và, đồng thời, bị phản đòn bằng một cú đánh vào cơ nhị đầu.

- 2 Sau đòn gây choáng vào cơ nhị đầu, đòn phản công được tiếp nối trực tiếp bằng một cú đấm búa hoặc một cú đánh bằng xương trụ vào cổ.

Hiệu quả: Khi tung ra với đủ lực, một cú đánh vào cơ nhị đầu cực kỳ đau và dẫn đến mất tạm thời khả năng vận động của cánh tay.

Tổn thương các cơ quan hoặc các phần của cơ thể do lực tù, trực tiếp từ bên ngoài gây ra mà không có tổn thương da thấy được, được gọi là dập. Điều này tạo ra phù (sưng) các mô và thoát mạch máu từ các mao mạch bị tổn thương vào mô xung quanh, và có thể biểu hiện thành một vết bầm. Nói chung, đau xuất hiện ngay và hạn chế vận động. Trong trường hợp sưng lớn hơn, có thể xảy ra cứng cơ.

Các hiện tượng tương tự xảy ra trong trường hợp dập, tức là khi mô cơ thể bị ép lại với nhau.

Khi một sợi cơ bị rách, các sợi lưới bị tổn thương và xuất hiện các triệu chứng viêm tại chỗ. Đồng thời, tình trạng giảm trương lực cục bộ (trạng thái căng của cơ) thấy rõ ở vùng bị tổn thương. Với những vết rách ở các cơ lớn hơn, đôi khi có thể thấy những chỗ lõm rõ ràng hoặc cơ bị thắt lại thành nút ở vùng bị ảnh hưởng.

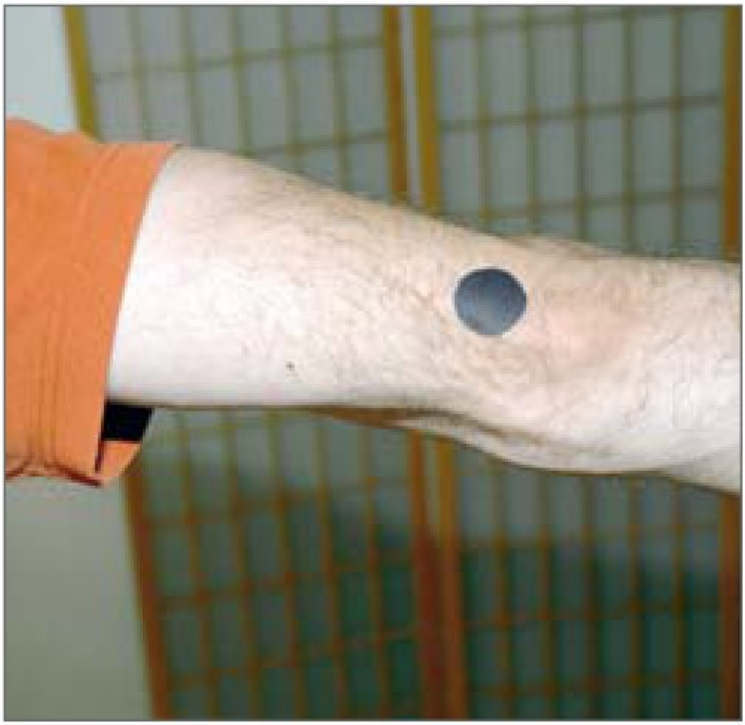
Cơ nhị đầu được chi phối bởi nervus musculocutaneus.

Huyết khối ít có khả năng xảy ra.

Bình luận về cách dùng: Cú đánh phải được nhắm tốt và hướng vào các xương của cánh tay trên.

Trong trình tự này, cú đấm không được đánh phẳng để các khớp đốt ngón tay có thể khoan vào cơ.

## 4.3 Cùi chỏ



Khớp cùi chỏ nối xương cánh tay trên (humerus) với hai xương của cẳng tay – xương quay và xương trụ.

Tấn công: Đánh vào khớp cùi chỏ đang duỗi thẳng.

GHI CHÚ: Khi tấn công mục tiêu, khớp cùi chỏ không phải là chóp cùi chỏ, mà là phần hõm phía trong, phía vào thân tính từ chóp cùi chỏ.

Hiệu quả: Trật khớp, hay sai khớp (tiếng Latinh: luxatio), xảy ra khi các xương trong một khớp bị xô lệch hoặc lệch trục. Sai khớp gây tổn thương nghiêm trọng cho khớp. Các xương cấu thành một khớp không thể thực hiện chức năng của mình mà không gây tổn thương cực lớn cho bao khớp. Nó thường đi kèm với một chỗ gãy. Khi bị kéo duỗi mạnh, mỏm khuỷu (chóp của khớp cùi chỏ gần thân

nhất) ở đầu cuối xương trụ có thể gãy.

Trong những trường hợp như vậy, có thể xảy ra tổn thương nervus ulnaris (“xương vui nhộn”) và nervus radialis, kèm theo liệt cánh tay và/hoặc bàn tay về sau. Ngoài ra, động mạch cánh tay trên (arteria brachialis) có thể bị tổn thương.

Bình luận về cách dùng: Ở đây, cần lưu ý rằng ranh giới giữa Kyusho và các kỹ thuật đòn bẩy không có đường phân chia rõ ràng. Cơ được luyện tập tốt tạo sự bảo vệ nhất định chống lại việc bị kéo duỗi quá mức cần thiết.

- 1 Đòn tấn công bằng nắm đấm bị đỡ°.
- 2 °.bằng một động tác kiểu Vịnh Xuân (Bong-Sao).
- 3 Cổ tay bị túm.
- 4 Kéo duỗi bằng một đòn bẩy tay. 5 Đưa cánh tay lên để chuẩn bị tung một cú đánh bằng xương trụ.

6 Đánh. CẨN THẬN! Tổn thương khớp cùi chỏ.

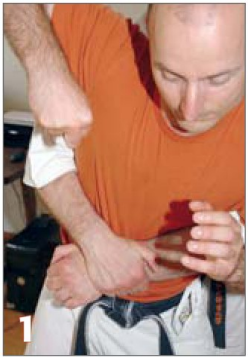
7 Quật đối thủ xuống đất.

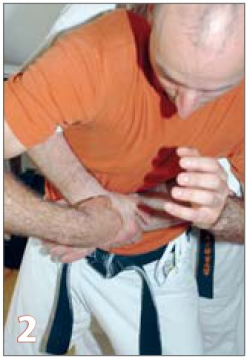
## 4.4 Bàn tay

Để xem minh họa, hãy xem phần “Cổ tay”.

Bàn tay được chi phối bởi ba dây thần kinh: nervus ulnaris, nervus medianus và nervus radialis. Khớp cổ tay nối với xương bàn tay (metacarpus), gồm năm xương bàn tay dài.

Tấn công: Ấn đầu ngón cái vào hõm giữa xương bàn tay thứ 2 và 3 hoặc 3 và 4, trong tam giác giữa ngón cái và ngón trỏ; đánh vào vùng xương bàn tay bằng các khớp đốt ngón tay.



- 1 Phản ứng với thế áp sát: Đánh bằng các khớp đốt ngón tay của nắm đấm (Nadaka-Ken) vào mu bàn tay. Điều này giải thoát khỏi đòn áp sát và mở ra khả năng cho các kỹ thuật tiếp theo.

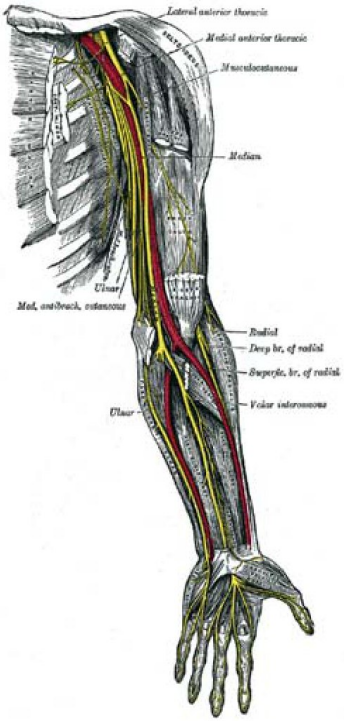
Hiệu quả: Đau thần kinh và da (da trên bề mặt xương) hoặc gãy xương.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Chủ yếu dùng như một đòn giải thoát.

- 1 Tình huống bị siết bàn tay.
- 2 Người phòng thủ lùi sang một bên, ra xa khỏi đối phương.
- 4 Cách giữ bàn tay.
- 5 Cũng có thể dùng một cú đánh bằng khớp ngón cái.

- 1 Với một chút luyện tập, cũng có thể kết hợp việc phòng thủ một cú đánh vào mu bàn tay với một động tác quét bằng bàn tay.

## 4.5 Cổ tay



Sơ đồ 26 Nervus medianus chạy từ nách qua mặt trong cánh tay trên rồi vào cẳng tay ở phía lòng bàn tay. Dây thần kinh này nằm tương đối nông phía trên bàn tay.

Tấn công: Ấn bằng đầu ngón cái vào giữa các gân ở mặt trong cổ tay. Đánh bằng đáy nắm đấm hoặc các khớp đốt ngón tay.

- 1 Tấn công: Túm cổ tay.
- 2 Phản đòn: Đánh theo hướng về phía mặt để cản trở đối phương và làm duỗi cánh tay kẻ đó. 3 Tự giải thoát khỏi thế túm bằng cách đánh ngay phía trên cổ tay.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (so sánh các trình bày trong phần Dẫn nhập). Ngoài ra, cú tác động còn ảnh hưởng đến các cấu trúc khác (gân, mạch máu).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Chủ yếu dùng như một đòn giải thoát.

- 1 Thế túm bị phản đòn bằng một đòn gây choáng.
- 2 Động tác giải thoát được bắt đầu bằng một cú đánh vào cổ tay.
- 3 Kéo duỗi cánh tay đối phương đồng thời thực hiện một động tác cản trở vào mặt kẻ đó.
- 4 Kéo cánh tay lên để đánh.
- 5 Bằng cách đánh vào cổ tay, đối phương bị xoay lại để lưng hướng về người phòng thủ.
- 6 Lựa chọn: Dùng cùi chỏ đánh xuống dưới vào cổ tay.

## 4.6 Móng tay

Tấn công: Cào bằng móng tay của chính mình.

Hiệu quả: Những vết cào rất đau.

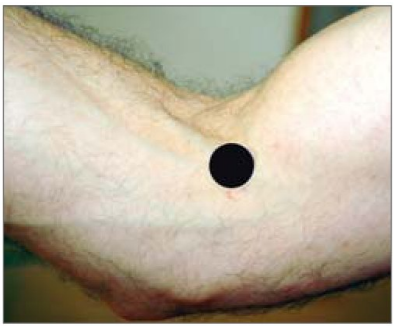
Bình luận về cách dùng: Dùng như một đòn giải thoát; rất hiệu quả.

Một ví dụ điển hình – điều quan trọng là hiệu quả, không phải sự chính xác hay vẻ thanh nhã.

## 4.7 Dây thần kinh giữa / Nervus medianus

Để xem mô tả, hãy xem phần “Cổ tay”.

Tấn công: Kẹp với ngón cái ấn vào điểm khởi đầu của gân cơ nhị đầu, đối diện nervus medianus.



Điểm mục tiêu. Hướng của sức ép. Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong

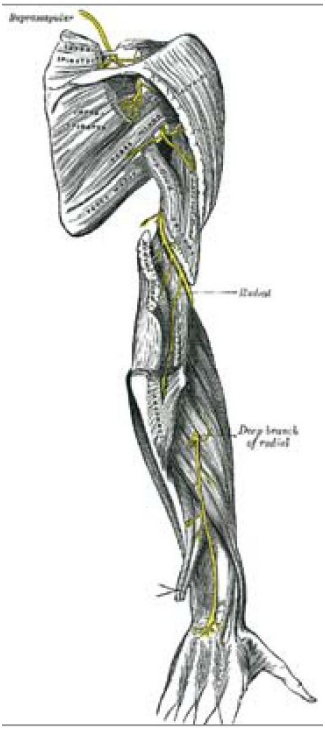
phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Cơ được luyện tập tốt và quần áo cũng tạo sự bảo vệ.

- 1 Thế túm cổ áo bị phản đòn trực tiếp bằng cách đánh về phía mặt bằng gò bàn tay.
- 2 Cánh tay tấn công bị khống chế và sức ép lên dây thần kinh giữa được tác động.
- 3 Cận cảnh.
- 4 Đối phương bị làm mất thăng bằng bằng một cú đá Kanetsu-Geri (đá ngang vào đầu gối đối phương).

## 4.8 Dây thần kinh quay / Nervus radialis

Nhìn từ phía sau.




Nervus radialis (dây thần kinh quay) là một dây thuộc nhóm đám rối cánh tay. Nó chi phối các cơ duỗi của khớp cùi chỏ, khớp cổ tay và các khớp ngón tay, cũng như vùng da ở mặt sau cánh tay trên, mặt dưới cẳng tay và mu bàn tay.

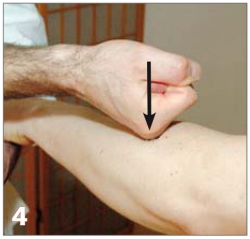
Nó chạy xuống giữa cánh tay trên giữa các đầu của cơ tam đầu (musculus triceps brachii), vặn xoắn quanh, nằm ngay trên xương cánh tay trên, rồi di chuyển ra ngoài qua cùi chỏ. Nó thoát ra qua cơ ngửa (supinator) – cơ chịu trách nhiệm cho động tác xoay bàn tay và cẳng tay ra ngoài. Sơ đồ 27

Tấn công: Cánh tay trên: Đấm hoặc ấn bằng xương chày. Cẳng tay: Đánh (xương trụ, cú đấm búa) hoặc ấn bằng ngón cái (thế kẹp) ở một phần ba trên, hoặc kẹp cơ cánh tay–quay (xem minh họa cho "Cổ tay") ngay dưới hõm khuỷu tay.

Điểm mục tiêu. Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (so sánh các trình bày trong phần Dẫn nhập). Khi nervus radialis bị ảnh hưởng, các cơ duỗi cổ tay và ngón tay có thể bị liệt, và các ngón tay cùng cổ tay bị gập ngược ra sau. Nếu tổn thương ở cao hơn, cũng có thể bị liệt cơ tam đầu, và khớp cùi chỏ không thể duỗi thẳng ra được. Đồng thời, sẽ có mất cảm giác ở vùng đó.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Việc

tìm đúng điểm (đặc biệt khi ấn) đòi hỏi rất nhiều luyện tập. 1 Đòn tấn công bị đỡ bằng mu bàn tay. 2 Sau khi túm cổ tay, cánh tay được kéo về để phản đòn. 3 Đánh bằng cạnh bàn tay vào dây thần kinh quay. 4 Một phương án khác là đánh bằng các khớp đốt ngón tay của nắm đấm. Điểm mục tiêu.



Dây thần kinh quay nằm ở vùng cánh tay trên. Để tìm nó, hãy đặt một bàn tay khum quanh chóp cùi chỏ của bạn tập. Duỗi ngón cái lên trên da, và bạn đã tìm thấy nó. Nói chung, ở đây phải dùng sức ép rất lớn, điều này hoàn toàn có thể khi ở dưới đất. Ở đây, xương chày được cưa ngang qua dây thần kinh – tới lui. Phản đòn khi bị túm cổ áo: Cú đấm móc bằng các khớp đốt ngón tay của nắm đấm vào dây thần kinh quay.

Xoay cùi chỏ đối phương vào trong. Bằng cách tiếp tục xoay, đối phương bị quật xuống đất. Một cú đánh tương tự có thể dùng để khởi đầu một đòn quật. Quật về phía sau như O-Soto-Gari.

## 4.9 Dây thần kinh trụ / Nervus ulnaris

Đây là dây thần kinh được gọi là “xương vui nhộn”. Nếu dây thần kinh này bị ảnh hưởng, người ta có thể cảm thấy tác động lan tới tận ngón út.

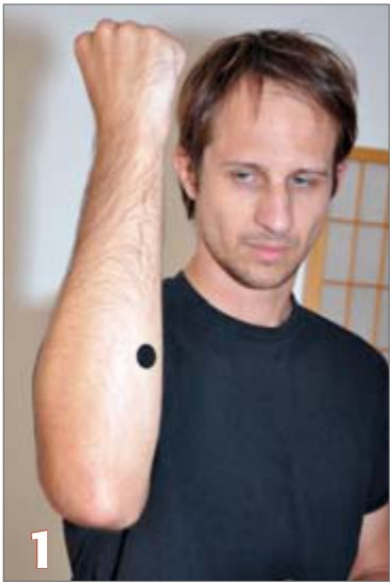
Để xem minh họa, hãy xem phần “Cổ tay” (trang 169).

Tấn công: Đánh bằng các khớp đốt ngón tay.

Điểm mục tiêu ở vùng cánh tay trên. Hiệu quả: Khi bị đánh, có một cơn đau dữ dội (đau dây thần kinh) lan tới tận đầu các ngón út và ngón áp út (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Ví dụ về cách dùng: Vùng mục tiêu trên cánh tay trên rất nhỏ nên góc đánh phải chính xác. Nếu không, đây vẫn là một ví dụ điển

hình về một điểm yếu Kyusho trên các dây thần kinh. Mục tiêu trên cẳng tay có thể bị đánh dễ dàng, đặc biệt là ngay khi kẻ đó vào tư thế phòng thủ.



- 1 Điểm mục tiêu ở vùng cẳng tay.
- 2 Cú móc ngược tay phải vào dây thần kinh trụ ở cẳng tay.

## 4.10 Mặt trong cánh tay trên

Tĩnh mạch nền (thể hiện màu xanh trong sơ đồ) và động mạch cánh tay trên (arteria brachialis – thể hiện màu đỏ trong sơ đồ) chạy xuống rãnh giữa cấu trúc cơ duỗi và cơ gấp ở mặt trong cánh tay trên (sulcus bicipitalis). Động mạch này là phần tiếp nối của động mạch nách, và nó cấp máu cho toàn bộ cánh tay. Đi kèm với nó là các dây thần kinh (thể hiện màu vàng trong sơ đồ) chạy dọc bên, thuộc đám rối cánh tay (nervus medianus và nervus ulnaris, nervus cutaneus antebrachii medialis và nervus cutaneus brachii medialis).

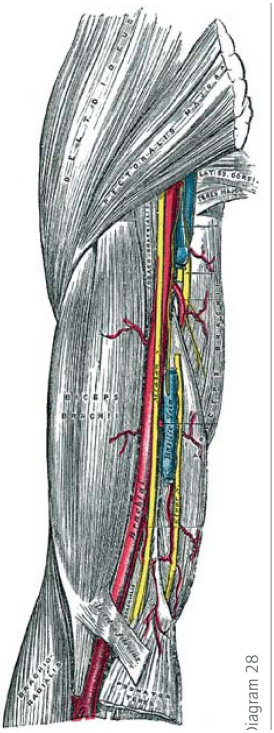


Diagram 28

Tấn công: Đấm.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Những tình huống ít có khả năng xảy ra:

Khả năng huyết khối tĩnh mạch do một cú đánh mạnh, hậu quả có thể là thuyên tắc phổi và, trong một số trường hợp, đau tim.

Trong trường hợp huyết khối động mạch, có nguy cơ tổn thương các mạch vành Sơ đồ 28 (nhồi máu cơ tim), các mạch cấp máu cho não (đột quỵ) và các động mạch chân. Nguyên nhân của huyết khối động mạch là tổn thương hoặc sẹo ở thành mạch. Chi bị ảnh hưởng thường lạnh và nhợt nhạt, không còn sờ thấy mạch, và bắt đầu đau dữ dội. Chức năng bị hạn chế cực độ.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Cơ được luyện tập tốt và quần áo dày tạo thêm sự bảo vệ.

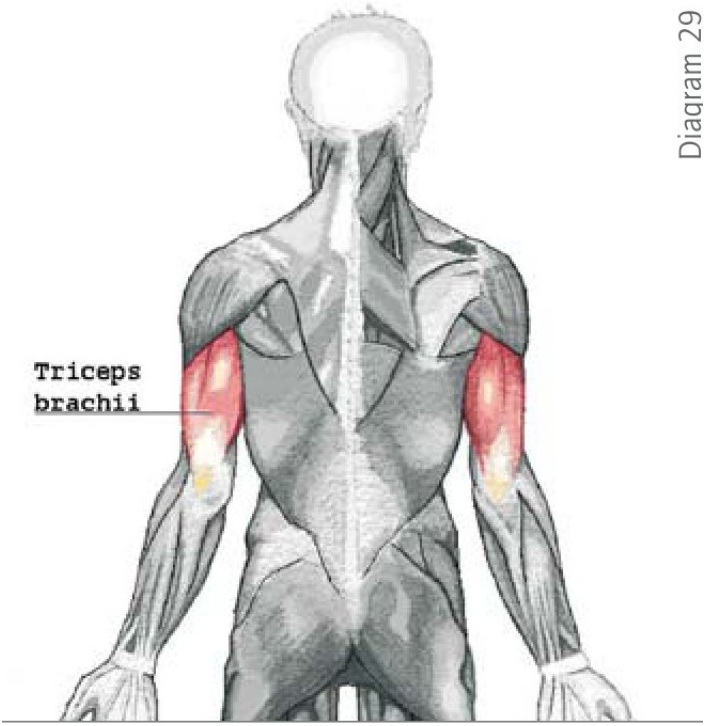
Để tăng độ chính xác của mục tiêu, sẽ có lợi nếu dùng bàn tay kia tiếp xúc với mặt ngoài cánh tay trên. Cú đánh nên nhắm vào xương cánh tay trên.

1 Sau khi vai bị túm, người phòng thủ nắm chặt cánh tay trên của đối phương ở mặt ngoài. 2 Cú đấm ngắn bằng mặt trong của nắm đấm vào mặt trong cánh tay trên của đối phương. Nguyên tắc: Tạo thành một kiểu bánh kẹp. 3 Cận cảnh. 4 Vùng mục tiêu.

- 1 Nếu đối phương giữ cánh tay theo hướng chéo, cánh tay phải được xoay trước khi tung cú đấm.

## 4.11 Cơ tam đầu – Hợp âm kết

Cơ tam đầu đôi khi được gọi là cơ ba đầu Sơ đồ 29 vì có ba bó cơ hợp lại với nhau ở cùi chỏ như một hợp âm kết chung ở một phần ba dưới của cánh tay trên.




Tấn công: Ấn bằng xương chày hoặc khớp đốt gốc của ngón trỏ.

- 1 Cánh tay đang duỗi bị ghì chặt xuống sàn.
- 2 Cận cảnh.
- 3 Bị ghì xuống bằng xương chày. Điều này rất đau vì toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống cánh tay. Có thể kết thúc trình tự bằng một cú đấm búa vào mặt.

Hiệu quả: Đau do ấn vào gân, cũng có thể liên quan đến dây thần kinh trụ (chạy ngay trên "xương vui nhộn" cạnh khớp bản lề cùi chỏ với xương cánh tay trên – xem phần "Cổ tay"). Tổn thương những vùng này được biểu hiện bằng cảm giác tê ở ngón út, phần ngoài của ngón áp út và phần gò của ngón út.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người.

# Chương 5 — Các điểm tấn công trên chân

*Chapter 5 — Attack Points on the Legs*

## 5.1 Gân Achilles

- 1 Chuẩn bị đá.
- 2 Thực hiện một cú Yoko-Geri (đá ngang) vào gân Achilles.
- 3 Cận cảnh.

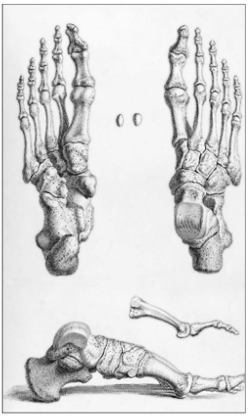
Tấn công: Đá giẫm, dùng xương chày để ấn.

Hiệu quả: Rách, đau; khi bàn chân đang thăng bằng trên các ngón chân, còn có tổn thương mắt cá và bàn chân.

Bình luận về cách dùng: Sơ đồ 30 Cũng như với các điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm và hiệu quả khác nhau tùy từng người.

- 1 Cú đá thấp phòng thủ bằng xương chày.
- 3 Túm lấy vai đối diện.
- 4 Quét phía trong. 5 Thăng bằng của đối phương bị phá vỡ. 6 Đòn kết thúc: Giẫm lên gót Achilles bằng bàn chân kiễng° 7 ...hoặc bằng bàn chân áp phẳng.

## 5.2 Mu bàn chân



- 1 Thế áp sát từ phía sau. Chân được nâng lên và xoay ra ngoài. Cạnh bàn chân được hạ xuống từ xương chày của đối phương, phía dưới đầu gối, xuống tới bàn chân.
- 2 Cú đánh dùng hình dạng của xương chày để chạy xuống dọc chân tới bàn chân.

Tấn công: Đá giẫm.

Hiệu quả: Gãy các xương mu bàn chân.

Bình luận về cách dùng: Lần này, giày cao gót lại là một lợi thế trong chiến đấu. Điểm mục tiêu.

- 1 Các dây thần kinh giữa các ngón chân ở mu bàn chân (các dây thần kinh gan bàn chân trong) cũng có thể là mục tiêu cho nhiều hành động khác nhau. Ở đây, bàn chân đối phương bị ghì chặt bằng sức ép từ ngón chân cái của người phòng thủ, đặt vào hõm giữa ngón chân cái và phần còn lại của mu bàn chân – đau đấy!

## 5.3 Da ở mặt trong đùi

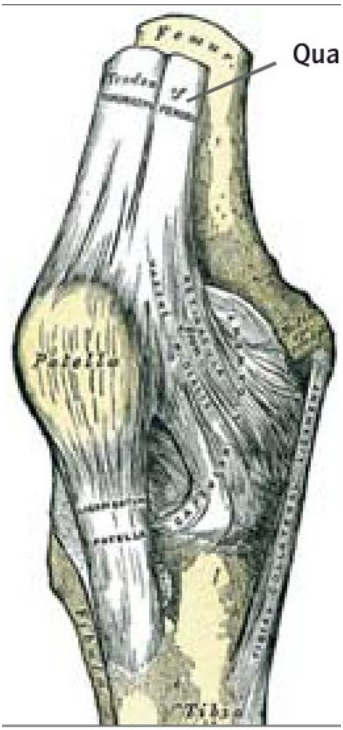
Tấn công: Véo.

- 1 Đòn khóa đầu được giải thoát bằng cách véo mạnh mặt trong đùi.
- 2 Cận cảnh.

Hiệu quả: Đau; các đầu tận thần kinh tự do (thụ thể đau) có thể được tìm thấy ở lớp bì. Sự phân bố của chúng thay đổi theo vùng cơ thể (tới 200 thụ thể trên mỗi $cm^2$ da). Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Quần áo dày tạo thêm sự bảo vệ. Có thể dùng như một đòn giải thoát.

## 5.4 Đầu gối

Đầu gối phải nhìn từ phía trước.




*Gân cơ tứ đầu đùi*

Tấn công: Đá (Yoko-Geri, Kakato-Geri, cú đá Mae-Geri đẩy tới vào xương bánh chè).

- Sơ đồ 32 2 Trong một đòn tấn công trực diện vào xương bánh chè, có nguy cơ cú đá bị trượt đi vì mục tiêu nhỏ.

- 4 Bằng cách xoay bàn chân ra ngoài (Teisoku-Geri, lòng bàn chân), vùng mục tiêu trên đối phương được làm lớn hơn, qua đó tăng độ chính xác của cú đá.

Hiệu quả: Bất động, đau, sốc.

Khớp đầu gối là phần nối giữa chân trên và chân dưới. Nó được tạo thành bởi đầu dưới của xương đùi, đầu trên của xương chày, xương bánh chè, các dây chằng bên và dây chằng chéo, cùng hai sụn chêm.

Khớp đầu gối được làm vững chắc bởi một cặp dây chằng chéo chạy xuống dưới ở bên khớp.

Các dây chằng chéo (trước và sau) làm vững chắc đầu gối và ngăn các mặt khớp trượt về phía trước hay phía sau, đồng thời ức chế động tác xoay. Chấn thương kinh điển của dây chằng chéo trước

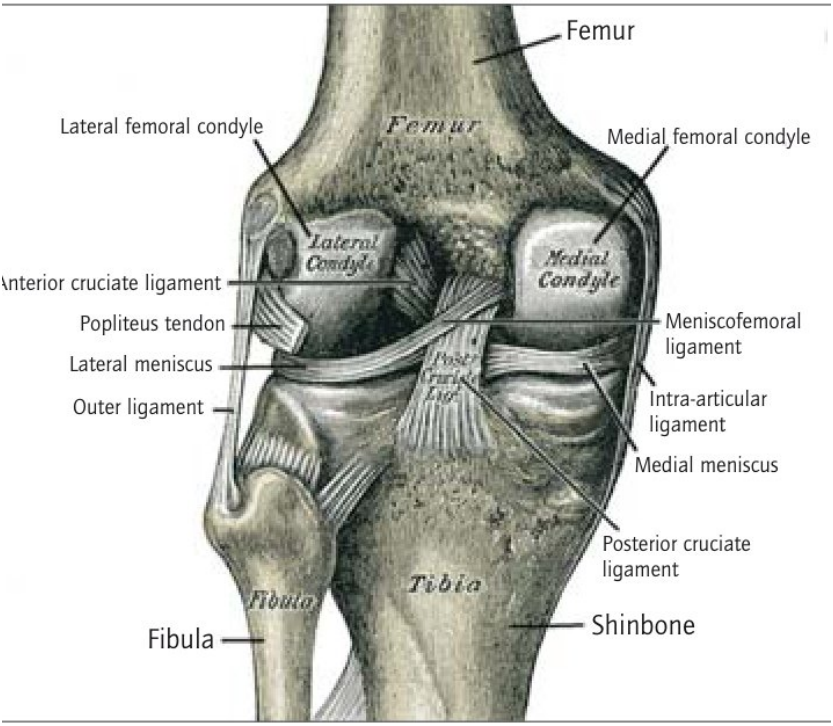
xảy ra khi đầu gối bị gập và có động tác xoay trong dữ dội.

Tổn thương sụn chêm xảy ra chủ yếu khi có động tác xoay mạnh và nhanh ở khớp đầu gối. Sau khi bị sai khớp (xảy ra khi các xương trong một khớp bị xô lệch hoặc lệch trục), đầu gối nhiều khả năng không thể dùng được bình thường. Sai khớp gây tổn thương nghiêm trọng cho khớp. Các xương cấu thành một khớp không thể thực hiện chức năng của mình mà không gây tổn thương cực lớn cho bao khớp. Tổn thương xương bánh chè nói chung không để lại vấn đề lâu dài và lành tốt khi được điều trị đúng cách.

Một cú đá vào hõm phía sau đầu gối có thể, ngoài tổn thương mạch máu và thần kinh ở vùng này (đặc biệt khi mang giày), còn gây gãy ngang xương bánh chè do cơ bị căng. Gãy ngang xương bánh chè luôn phải được phẫu thuật, nếu không sức mạnh lớn của cơ tứ đầu đùi sẽ dẫn đến các biến chứng y khoa thêm.

Khi xương bánh chè bị sai khớp, thường các mạch máu bị tổn thương và xuất hiện vết bầm. Việc tái tạo nhanh chóng là quan trọng để giảm tổn thương sụn.

Rách đơn độc dây chằng chéo trước rất hiếm gặp. Thường có các tổn thương đồng thời của dây chằng bên ở một bên và/hoặc các sụn chêm. Người ta nói đến một tổ hợp các tổn thương. (“Bộ ba bất hạnh”: dây chằng chéo, dây chằng bên và sụn chêm.)



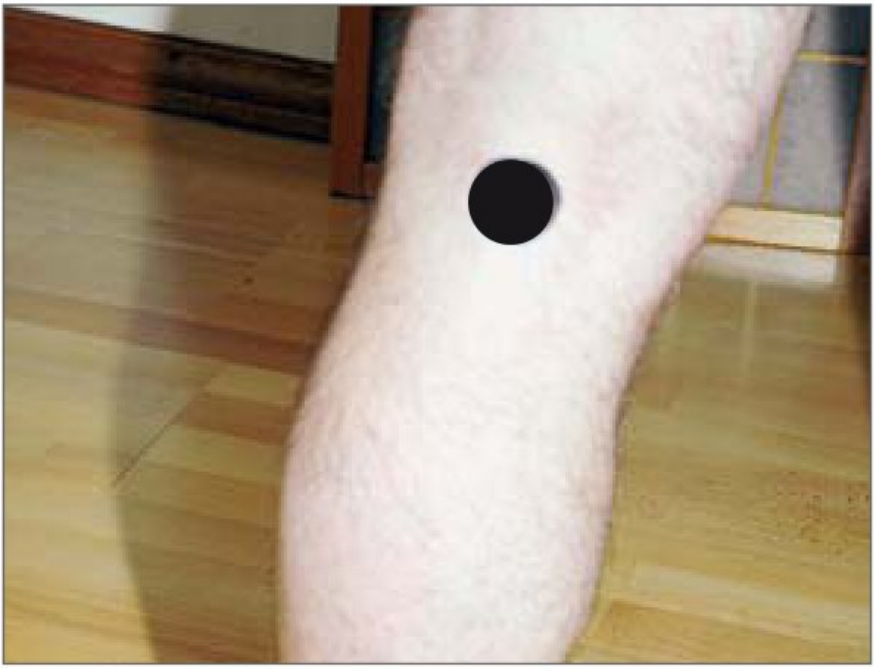

Xương đùi · Lồi cầu đùi ngoài · Lồi cầu đùi trong · Dây chằng chéo trước · Dây chằng sụn chêm–đùi · Gân cơ khoeo · Sụn chêm ngoài · Dây chằng trong khớp · Dây chằng ngoài · Sụn chêm trong Sơ đồ 33 Dây chằng chéo sau Khớp gối trái Xương chày Xương mác (nhìn từ phía sau) Một cú đá ngang có thể dẫn đến (trong trường hợp tốt nhất) một tình trạng giãn dây chằng gây đau, kèm hạn chế vận động (vì đau). Nếu đầu gối bị kéo duỗi quá mức, có thể xảy ra tổn thương sụn chêm khi có lực quá lớn. Ngoài ra, có thể có tổn thương các dây chằng bên.

Bình luận về cách dùng: Dễ nhắm mục tiêu; cơ được luyện tập tốt tạo ra một mức bảo vệ nhất định.

## 5.5 Hõm đầu gối

Dây thần kinh chày là phần tiếp nối của nervus ischiadicus (xem phần về nó), chạy qua “hõm khoeo;” để xem minh họa, hãy xem phần “Gân Achilles”.

Tấn công: Đá, ấn ngón cái vào hõm đầu gối hay hõm khoeo.



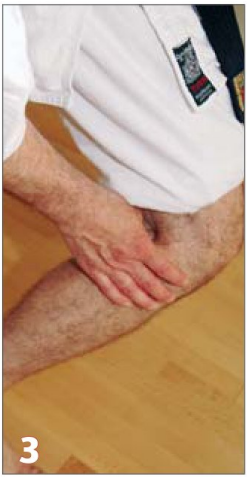
Điểm mục tiêu.

Hiệu quả: Có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) sau khi ấn (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Quần áo dày tạo thêm sự bảo vệ. Việc sử dụng bị hạn chế.

- 1 Thực hiện một cú Kanetsu-Geri vào hõm đầu gối.
- 2 Cận cảnh.

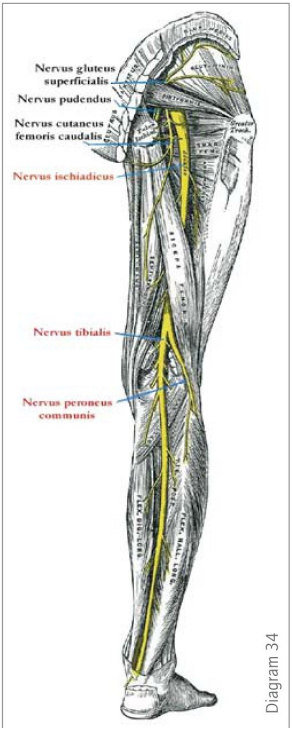
- 1 Cú đá thấp phía sau đầu gối.




■ 1 Phòng thủ trước một đòn khóa đầu: Ấn ngón cái vào hõm đầu gối.

1 Giày cũng có thể được dùng để tung một cú đá vào hõm khoeo.

## 5.6 Dây thần kinh hông to / Nervus ischiadicus




Dây thần kinh hông to chạy ở mặt duỗi của khớp hông, rồi xuống dưới ở phía sau đùi. Nó được che phủ bởi các cơ gấp đầu gối, rồi tiếp tục ra phía sau đầu gối, nơi nó đi qua "hõm khoeo". Nó được chia thành dây thần kinh chày và dây thần kinh mác chung. Trên đường đi, nó phân nhánh, cung cấp sự chi phối vận động cho một số cơ của đùi.

Tấn công: Đá (xương chày, đầu gối), tốt nhất là khi cơ đang thư giãn.

Hiệu quả: Liệt dây thần kinh hông to do sức ép, căng hoặc biến dạng (ví dụ do ngồi trên bề mặt không bằng phẳng hoặc ngồi lên ví trong túi sau), hoặc do thực hành sai khi tiêm trong mông, gây suy yếu gân và các cơ xoay ngoài ở đùi. Đau dây thần kinh (xem phần Dẫn nhập) ở dây thần kinh hông to xảy ra khi dây thần kinh bị kéo

căng (đầu gối bị căng, hông bị gập) với biểu hiện đặc trưng là đau ở vùng lưng dưới và mông. Ngoài ra, có thể gặp cảm giác tê, yếu cơ và những khó khăn khác khi vận động chân. Thông thường, những triệu chứng này chỉ xuất hiện ở Sơ đồ 34 một bên cơ thể.

- 1 Một cú đá Mae-Geri bị đỡ.
- 2 Cú đá thấp tiếp theo vào phía sau đùi.
- 3 Cú đá đầu gối vào dây thần kinh hông to (gây một vết bầm trên đùi).
- 4 Đối phương bị quật xuống sàn.

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Có thể dùng như một đòn giải thoát. Dễ nhắm mục tiêu.

## 5.7 Mặt ngoài đùi

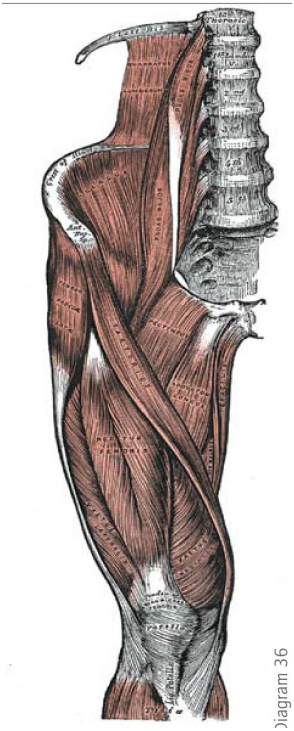


Diagram 36

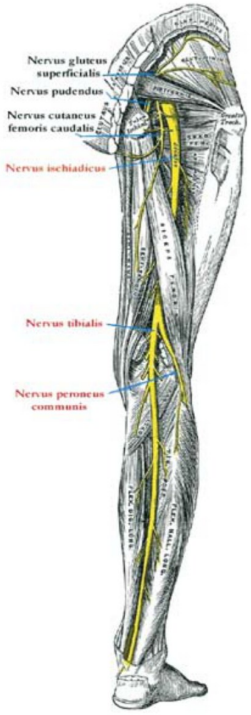



Diagram 35

Sơ đồ 35 Sơ đồ 36 Xem thêm minh họa trong phần “Mặt trong đùi”. Tấn công: Đá (xương chày, đầu gối).

- 1 Bắt đầu một cú đá thấp.
- 2 Thực hiện.
- 3 Chân được "đá xuyên qua", có thể nói như vậy. Cú đá được tiếp nối và thực hiện như thể người ta đá vào chân đối phương "xuyên qua không khí".

Hiệu quả: Cơ: Những cơ bị ảnh hưởng là musculus vastus lateralis (ở mặt ngoài đùi) – một trong các cơ phía trước của đùi – hoặc musculus tensor fasciae latae (tiếng Latinh: cơ căng mạc đùi); cơ sau có hình dạng một hình chữ nhật dẹt. Gân là một dải gia cố hình dải của mạc đùi và trải dài trên toàn bộ chiều dài của đùi. Dải gia cố này còn được gọi là dải chậu–chày.

Tổn thương các cơ quan hoặc các phần của cơ thể do lực tù, trực tiếp từ bên ngoài gây ra mà không có tổn thương da thấy được, được gọi là dập. Điều này tạo ra phù (sưng) các mô và thoát mạch máu từ các mao mạch bị tổn thương vào mô xung quanh, và có thể biểu hiện thành một vết bầm. Nói chung, đau xuất hiện ngay và hạn chế vận động. Trong trường hợp sưng lớn hơn, có thể xảy ra cứng cơ.

Các hiện tượng tương tự xảy ra trong trường hợp dập, tức là khi mô cơ thể bị ép lại với nhau. Khi một sợi cơ bị rách, các sợi lưới bị tổn thương và xuất hiện các triệu chứng viêm tại chỗ. Đồng thời, tình trạng giảm trương lực cục bộ (trạng thái căng của cơ) thấy rõ ở vùng bị tổn thương. Với những vết rách ở các cơ lớn hơn, đôi khi có thể thấy những chỗ lõm rõ ràng hoặc cơ bị thắt lại thành nút ở vùng bị ảnh hưởng.

Huyết khối ít có khả năng xảy ra.

Rách mạc (fascia) gần như khó xảy ra; tuy nhiên, có thể xảy ra hội chứng khoang (sưng trong cơ kèm giảm tuần hoàn máu, tăng áp lực và, nếu không điều trị, có thể hoại tử).

Thần kinh: Ít có khả năng bị tổn thương.

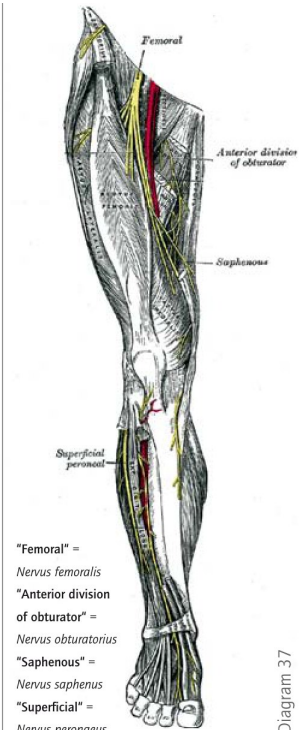
Các dây thần kinh có thể bị ảnh hưởng gồm dây thần kinh đùi (có tác động lên cơ vastus lateralis), nervus gluteus superior (“dây thần kinh mông trên” có tác động lên musculus tensor fasciae latae), cũng như các dây thần kinh fibularis communis / peronaeus communis (dễ cảm nhận ở vùng khớp đầu gối) từ hõm phía sau đầu gối xuống dưới ở phần dưới đùi. Trong cả hai trường hợp, hậu quả là đau, chân bị “liệt” và do đó không vững.

- 1 Chặn cú đánh trái tay.
- 2 Ghì chặt hai vai đối phương.

- 3 Cú đá đầu gối bằng đùi (bầm tím!).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Cơ được luyện tập tốt tạo sự bảo vệ tốt. Dễ nhắm mục tiêu.

## 5.8 Mặt trong đùi




Ở đùi, nervus saphenus (dây thần kinh hiển) tách ra từ nervus femoralis (dây thần kinh đùi). Nó nằm dọc phía trước (dọc theo mặt trong) động mạch đùi và nổi lên bề mặt tại đây.

Ngoài ra, ở một phần ba trên của đùi, người ta tìm thấy nervus obturatorius, dây chi phối các cơ khép của chân.

Tấn công: Đá bằng xương chày hoặc đầu gối, cạnh trong của bàn tay.

Hiệu quả: Tổn thương các cơ quan hoặc các phần của cơ thể do lực tù, trực tiếp từ bên ngoài gây ra mà không có tổn thương da thấy được, được gọi là dập. Điều này tạo ra phù (sưng) các mô và thoát mạch máu từ các mao mạch bị tổn thương vào mô xung quanh và có thể biểu hiện thành một vết bầm. Nói chung, đau xuất hiện

ngay và hạn chế vận động. Trong trường hợp sưng lớn hơn, có thể xảy ra cứng cơ.

*“Femoral“ = · Nervus femoralis · “Nhánh trước · của obturator“ =*

Các hiện tượng tương tự xảy ra trong trường hợp dập, tức là khi mô cơ thể bị ép lại với nhau. Sơ đồ 37 Khi một sợi cơ bị rách, các sợi lưới bị tổn thương và xuất hiện các triệu chứng viêm tại chỗ. Đồng thời, tình trạng giảm trương lực cục bộ (trạng thái căng của cơ) thấy rõ ở vùng bị tổn thương. Với những vết rách ở các cơ lớn hơn, đôi khi có thể thấy những chỗ lõm rõ ràng hoặc cơ bị thắt lại thành nút ở vùng bị ảnh hưởng.

Cũng có thể phát triển hội chứng khoang (sưng trong cơ kèm giảm tuần hoàn máu, tăng áp lực và, nếu không điều trị, có thể hoại tử).

Huyết khối có khả năng xảy ra vì tĩnh mạch hiển (vena saphena) có thể bị ảnh hưởng đến mức các cục máu đông có thể đi vào các động mạch phổi và gây thuyên tắc phổi. Hậu quả gồm sụt huyết áp, tổn thương phổi và suy sụp hệ tuần hoàn, gây tử vong.14 Do có nhiều cơ được chi phối bởi dây thần kinh đùi, có thể xảy ra rối loạn vận động nghiêm trọng hoặc mất vững; có thể bị viêm (viêm dây thần kinh).

■ 1 Khóa đầu – đầu áp vào đầu.

- 2 Tấn công vào mặt trong đùi bằng Haito-Uchi (cạnh trong của bàn tay). Nếu cú đánh lại trúng vào cơ quan sinh dục thay vì mặt trong đùi, có nguy cơ đòn giải thoát thất bại. Điều ngược lại sẽ xảy ra vì phản xạ của đối phương trước cú đánh là siết chặt thêm thế khóa cổ. Mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người. Không dễ nhắm mục tiêu như mặt ngoài đùi.

*Nervus obturatorius · “Saphenous“ = · Nervus saphenus · “Superficial“ = · Nervus peronaeus · Các dây thần kinh:*

## Bình luận về cách dùng:

- 1 Vai đối diện được khống chế sau đòn tấn công. (Bàn tay trái của người phòng thủ ghì chặt vai trái của đối phương sau đòn tấn công.)

- 1 Đối phương tung một cú đá thấp.
- 2 Cú đá được đệm lại, nghĩa là lực của cú đá bị tiêu tán bằng cách nhường chân bị chặn.
- 3 Chủ động đá trả lại bằng chân.

- 4 Đối phương bị buộc phải thu chân về.
- 5 Phản công: Kinteki-Geri.
- 6 Cách phản công khác: Uchimomo-Geri (cú đá thấp phía trong vào đùi)

1 2 Dùng ở thế nằm sàn – giải thoát khỏi thế kẹp. 1 Cách dùng bổ sung – ghì đối phương xuống đất°. 2 °..bằng mặt ngoài bàn chân (Sokuto) hoặc°. 3 °..bằng các ngón chân hoặc gò bàn chân.

■ 1 Mang giày có thể làm tăng hiệu quả khi sử dụng.

## 5.9 Xương chày / Tibia

Các xương của chân dưới bên phải – nhìn từ phía trước.

Tấn công: Đá, “cưa” bằng xương chày của chính mình. XƯƠNG CHÀY · XƯƠNG MÁC 1 Từ thế áp sát° 2 °..xương chày của đối phương bị giẫm xuống Sơ đồ 38 – ngắn và mạnh. Xương mác 3 Chân kẻ đó bị duỗi ra bởi động tác này, tạo khoảng trống để tung các cú đá đầu gối tiếp theo hoặc các đòn quật. Xương chày Viêm da chân, gãy (huyết khối/thuyên tắc; thuyên tắc phổi, đột quỵ).

Hiệu quả: Trên mặt thân xương, có một dải xương (crista anterior) chạy xuống dưới. Dải xương này nằm ngay dưới da, tạo thành mặt trong của thân xương.

Xương chày được bao quanh bởi màng xương hay “da xương” và gồm một lớp mô liên kết đặc áp sát xương. Lớp trong chứa các dây thần kinh và mạch máu, khiến màng xương, trái ngược với bản thân xương, rất nhạy cảm với đau. Khi xương chày bị đá, các mạch máu của màng xương bị rách và xuất hiện một vết bầm giữa xương và màng xương. Tuy nhiên, cơn đau nhói chỉ kéo dài vài phút. Do tác động cơ học, cũng có thể xảy ra viêm “da xương” (viêm màng xương) đau đớn và kéo dài.

Vì xương chày chạy ngay dưới da, gãy hở tương đối phổ biến. Có nguy cơ huyết khối. Trong mọi tổn thương ở chi dưới, đều có nguy cơ huyết khối (cục máu đông trong mạch). Với những trường hợp gãy xương lớn, có nguy cơ thuyên tắc do bị chặn bởi các giọt mỡ. Thuyên tắc là sự tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần trong một mạch máu do một cục máu đông hoặc vật lạ khác bị mắc kẹt khi di chuyển trong dòng máu.

Bình luận về cách dùng: Tốt như một kỹ thuật mở đầu hoặc như một khả năng làm đối phương mất thăng bằng ở khoảng cách ngắn. Việc “cưa” tự nó không dễ chịu lắm cho người phòng thủ. Tuy nhiên, trong khi sức ép kẻ đó tác động được trải đều trên toàn

bộ xương chày của mình, thì vị trí bị tấn công trên xương chày của đối phương lại luôn là một chỗ. Điểm mục tiêu.

Điểm nhạy cảm nhất trên xương chày là vùng ở bên cạnh và phía sau của nó, ngay phía trên mắt cá.

Trong trình tự sau đây, điều này được dùng để nhân đôi hiệu quả.

- 1 Ngay cả khi đối phương xoay sang một bên sau đòn bẩy chân, cạnh trong của xương chày vẫn có thể dễ dàng dùng để khống chế. Sau đó sức ép được tạo ra bằng xương quay.

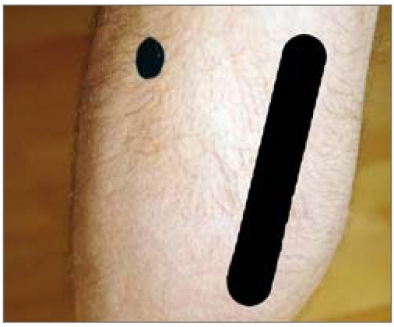
- 1 Nếu đối phương đang giữ bạn từ phía sau bằng một thế kẹp, thì cạnh sau của xương chày có thể bị “xử lý” mạnh bằng cách dùng liên tục các khớp đốt ngón tay của nắm đấm.

*–Fibula“ = · –Tibia“ = · Ví dụ về việc “cưa” bằng xương chày của chính mình:*

## 5.10 Bắp chân

So sánh với minh họa trong phần “Mặt ngoài đùi”.

Tấn công: Đá, ấn (cạnh bàn chân, xương chày, ngón cái).



Điểm mục tiêu ở chân trái, mặt sau và mặt trong của bắp chân. Điểm mục tiêu ở chân phải, mặt sau và mặt trong của bắp chân. Hiệu quả: Đau do đánh/ấn. Mặt sau của bắp chân: Nervus tibialis,

nervus suralis. Mặt trong của bắp chân: Các nhánh của nervus tibialis. Mặt ngoài của bắp chân: Nervus peronaeus communis (= Nervus fibularis communis). Khi ấn, có thể cảm thấy đau thần kinh (đau dây thần kinh) (xem các trình bày trong phần Dẫn nhập). Cũng có nguy cơ huyết khối khi một cú đá gây tổn thương do chấn thương.

Bình luận về cách dùng: Mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được khác nhau tùy từng người, nên cần tiếp cận chính xác hơn để ấn sâu khi tác động sức ép; cú đánh vào gót không đòi hỏi độ chính xác như vậy vì đạt được diện tác động lớn hơn. Về cơ bản, chỉ cần nhắm vào bắp chân ngay dưới đầu gối (mặt trong/mặt ngoài/mặt sau), để ngoài việc làm đối phương mất thăng bằng còn có cả đau đớn. Bằng cách này, hiệu quả của đòn quật chân được tăng lên.

- 1 Tình huống áp sát: Cú đá ngược bằng gót vào cạnh ngoài của bắp chân.
- 2 Đối phương cố nhấc người phòng thủ lên. Người này đáp lại bằng cách nâng gót chân lên để tung một cú đánh.

- 1 Thế kẹp thân từ phía sau được giải thoát bằng cách ấn ngón cái vào mặt trong bắp chân.
- 2 Cận cảnh.
- 3 Đau!

- 1 Đòn bẩy đầu gối gập tiếp theo có thể được làm cho đau hơn bằng cách tác động thêm sức ép lên mặt ngoài bắp chân bằng khớp ngón cái.

## 5.11 Xương mác

Xem minh họa trong phần “Xương chày”.

Tấn công: Đá bằng xương chày/cạnh bàn chân (đối phương đang đứng hoặc ở tư thế quỳ).

Điểm mục tiêu (chân dưới bên phải).

Hiệu quả: Gãy, không thể dồn trọng lượng lên bàn chân. Mục tiêu dễ tiếp cận và hiệu quả cũng tốt.

## Bình luận về cách dùng:

- 1 Cú đấm bị đỡ. 2 Túm quanh cùi chỏ để khống chế nó.
- 4 Trong một động tác quét nhanh theo hình bán nguyệt, mặt trong của xương chày ngay phía trên mắt cá được dùng để đá vào xương mác của đối phương. 1 Kỹ thuật dùng để ghì đối phương xuống sàn.

- 1 Chân đối phương bị ghì chặt ở mắt cá.
- 2 Túm hõm phía sau đầu gối đối phương và bẻ.
- 3 Nhờ động tác này, thân thể đối phương bị lật lại.

- 4 Bắt đầu động tác vặn xoắn.
- 6 Ghì chân xuống sàn bằng cách dồn trọng lượng lên xương mác bằng xương chày của bạn.

# Chương 6 — Các kỹ thuật đặc biệt

*Chapter 6 — Special Techniques*

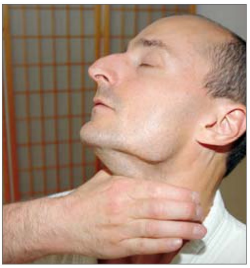
Trong phần này, chúng tôi trình bày hai kỹ thuật đặc biệt.

Nếu đối thủ không mặc gì hoặc mặc rất ít quần áo, vẫn có thể khống chế được hắn. Bất kể đối thủ cơ bắp đến đâu, hay lớp mỡ dưới da mỏng đến mức nào, phần thịt trên da hắn luôn có thể được vốc lên như vốc một tấm giẻ lau. CẨN THẬN! Rất đau.

Kỹ thuật vốc da: bàn tay mở đặt lên cơ tam đầu rồi các ngón tay khép lại thành động tác vốc. Đến một mức nhất định, có thể vốc được da như nhấc lên một nếp gấp của tấm vải. Nhờ cơn đau, có thể khống chế đối thủ một cách dễ dàng.

Nếp da được giữ giữa ngón cái và ngón trỏ có thể dùng cho một đòn tiếp theo vào cổ.

Cách giữ bàn tay. Nếu đối thủ mặc quần áo rất dày thì nhiều phương án chúng tôi đã trình bày sẽ không hiệu quả. Trong trường hợp này, phương châm là:



Nếu bạn không thể phớt lờ hắn hay đánh bại hắn, thì hãy biến hắn thành bạn!

# Phụ lục

*Appendix*

## Tài liệu tham khảo

Adams, Brian. Deadly Karate Blows – The Medical Implications. California, 1998.

Christensen, Loren W. Fighting the Pain Resistant Attacker. USA, 2010.

Clark, Rick. Pressure-point Fighting: A Guide to the Secret Heart of Asian Martial Arts. USA, 2001. Dillman, George A. Kyusho Jitsu. USA, 1993.

Dillman, George A. Advanced Pressure Point Fighting. USA, 1994.

Dr. Czerwenka-Wenkstetten, Heribert. Kanon des Nippon JuJitsu. Tyrolia-Verlag, 1993.

Drake Richard L; A. Wayne Vogl và Adam W. M. Mitchell. Gray's Anatomy for Students. Churchill Livingstone, 2004.

Goldacre, Ben. Bad Science: Quacks, Hacks, and Big Pharma Flacks. Fourth Estate, 2008. Höller, Jörgen & Maluschka, Axel & Reinisch, Stefan. Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Aachen 2007. Kawaishi, Mikinosuke. My Method of Self-defense. London, 1962.

Kelly, Michael. Death Touch: The Science Behind the Legend of Dim-Mak. USA, 2001.

Kim, Sang H. Vital Point Strikes. USA, 2008.

Morris, Vince. The Secret Art of Pressure Point Fighting: Techniques to Disable Anyone in Seconds Using Minimal Force. USA, 2009. Planellas, Pau-Ramon. Jintai Kyusho. Barcelona, 1996.

## Chú thích

- 1. http://www.iasp-pain.org//AM/Template.cfm?Section=Home
  2. Đây là một trong những vấn đề của việc dùng kyusho trong tình huống căng thẳng của một cuộc tấn công.

3. Một mô tả cân bằng về hiệu ứng placebo có thể tìm thấy trong sách của Ben Goldacre:

■ Bad Science, tháng 9 năm 2008.

4. So sánh, ví dụ, Profil số 48 ngày 26.11.2007.

■ 5. Trong trường hợp của chúng ta, phải nói tới hiệu ứng "nocebo", thường được mô tả như hiệu ứng placebo tiêu cực. Ở đây nỗi sợ được gieo vào tâm trí bệnh nhân, và người ấy bị làm cho ốm bởi những tác động từ bên ngoài. Những người như vậy thực sự sau đó ốm thật, hoặc các triệu chứng tương ứng của họ có thể được quan sát và đo lường. Một ví dụ cực đoan có thể là bản án tử hình do thầy pháp voodoo tuyên. Ở đó, người ta hình dung rằng nạn nhân, với lòng tin tuyệt đối, trở nên ốm yếu trong sự buông xuôi và sợ hãi, rồi thực sự chết.

6. Sách của Michael Kelly, 2001, trang 13.

7. Trong suốt sách của Michael Kelly, 2001.

8. Sách của Michael Kelly, 2001, trang 108.

■ 9. Theo một công tố viên Áo, sự đồng ý chịu tổn hại sức khỏe nghiêm trọng như vậy là không thể hợp pháp và do đó không được phép. Nghi phạm sẽ phải tính tới việc bị truy tố hình sự. 10. Sách của Michael Kelly, 2001, trang 4.

■ 11. Mark Link thuộc Trung tâm Y khoa Tufts New England ở Boston; xem thêm New Scientist, ngày 30 tháng 8 năm 2003, tr. 38-39, với tựa đề "Lethal Impact."

12. Xem thêm các bài viết của Michael Kelly, 2001, tr. 102.

13. Xem Michael Kelly, 2001, tr. 21 và tiếp theo.

14. Xem Michael Kelly, 2001, tr. 91.

## Liên kết web

*Có những liên kết cung cấp hình minh họa giải phẫu và mô tả tốt về kyusho:*

http://www.youtube.com/watch?v=SHtLlzw5zAE
http://www.youtube.com/watch?v=k0gjvTsftf0&feature=channel h
ttp://www.youtube.com/watch?v=MinHtFAOOKA&feature=channe
l
http://www.youtube.com/watch?v=-_0PY2PtOJs&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=BiiSAZkkxyA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=83p0MiOtnB0&feature=channe
l http://www.youtube.com/watch?v=ZxpacPHE1-c&feature=chann
el http://www.youtube.com/watch?v=tMQuU5pFbog&feature=cha
nnel http://www.youtube.com/watch?v=9BUAXFZYXxI&feature=c
hannel http://www.youtube.com/watch?v=GBxsQqfIYFY&feature=
channel
http://www.youtube.com/watch?v=Cvozl45O63I&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=bsR3A3VFXBk&feature=chann
el http://www.youtube.com/watch?v=5UAvIHnz_bM&feature=cha
nnel
http://www.youtube.com/watch?v=G3Efb0jvbjA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=tsWAG8igCc4&feature=channe
l http://www.youtube.com/watch?v=Gekkq0Ofh3A&feature=chann
el http://www.youtube.com/watch?v=HMd2Q7tfStw&p=065F44B8
B598A9A1&playnext=1&index=4 http://www.youtube.com/watch?
v=Trg0yZ65Qp8&feature=channel http://www.youtube.com/watc
h?v=XN9PCc4166k&feature=channel http://www.youtube.com/wa
tch?v=Po0Skl0GK3s&feature=channel http://www.youtube.com/w
atch?v=SBzxL8oEdWQ&feature=channel

# Lời cảm ơn về hình ảnh & Thông báo pháp lý

*Picture Acknowledgements & Legal Notice*

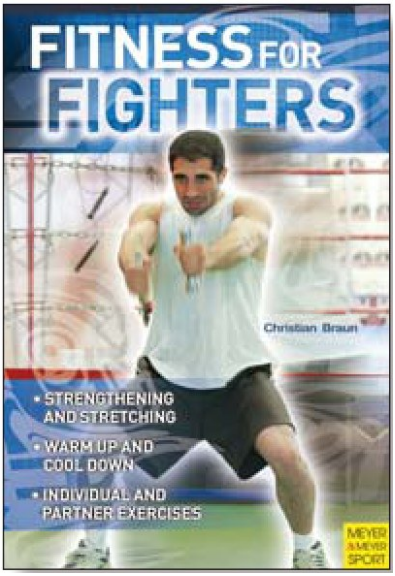
## Nguồn ảnh

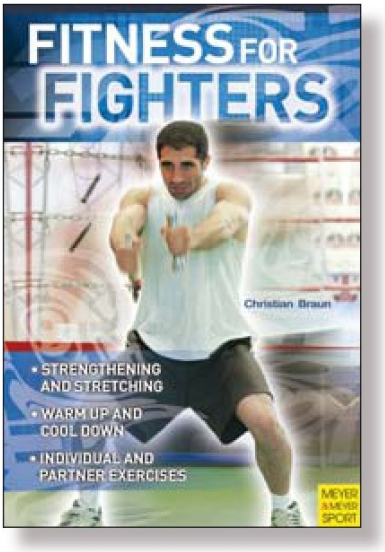
Các hình 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 đã được phỏng theo cho cuốn sách này từ http:www.wikipedia.de; do đó tuyên bố sau đây là đúng: việc sao chép trung thực một bản in thạch bản từ Gray’s Anatomy – một tác phẩm nghệ thuật hai chiều – không thể được bảo hộ bản quyền ở Hoa Kỳ theo phán quyết Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; điều này cũng đúng ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Đức. Trừ khi có ghi chú khác, hình được lấy từ ấn bản thứ 20 (Hoa Kỳ) của Gray’s Anatomy of the Human Body, xuất bản lần đầu năm 1918 và do đó đã thuộc phạm vi công cộng. Các bản sao khác của Gray’s Anatomy có thể tìm thấy trên Bartleby và Yahoo! Những hình ảnh này thuộc phạm vi công cộng vì bản quyền của chúng đã hết hạn. Điều này áp dụng trên toàn thế giới. Các hình 3, 6, 10, 13, 16, 20, 23: được sự cho phép của Elsevier Limited, đã được phỏng theo từ bản tiếng Đức của: Drake, Vogl, Mitchel, Gray’s Anatomie für Studenten (Gray’s Anatomy for Students) (do Friedrich Paulsen dịch và xuất bản), tái bản lần thứ nhất, 2007, © Elsevier GmbH, München, Urban & Fischer Verlag. Hình 3 tương ứng với minh họa 8.58, tr. 849, Đầu và cổ. Hình 6: minh họa 8.19, tr. 797, Đầu và cổ. Hình 10: minh họa 8.163, tr. 948, Đầu và cổ. Hình 13: minh họa 7.34, tr. 656, Chi trên. Hình 16: minh họa 4.2, tr. 228, Bụng. Hình 20: minh họa 3.27, tr. 131, Lồng ngực. Hình 23: minh họa 4.110, tr. 319, Bụng. Hình 11: www.logopaediewiki.de/wiki/Larynx. Ảnh bìa: Alexandra Runge; © Hemera/Thinkstock. Mọi ảnh khác: Harald Marek. Dải lề đầu trang: © iStockphoto/Thinkstock. Thiết kế bìa: Sabine Groten

## Thông báo pháp lý

Xin lưu ý rằng việc sử dụng các bài tập trình bày trong cuốn sách này là do bạn tự chịu rủi ro. Meyer & Meyer Sports GmbH và các tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả do sơ suất) về bất kỳ thương tích, mất mát, thiệt hại, chi phí hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các bài tập trong sách này.

Để biết thêm thông tin pháp lý về việc sử dụng các bài tập nêu trong sách này, xin tham khảo luật tương ứng của quốc gia bạn.



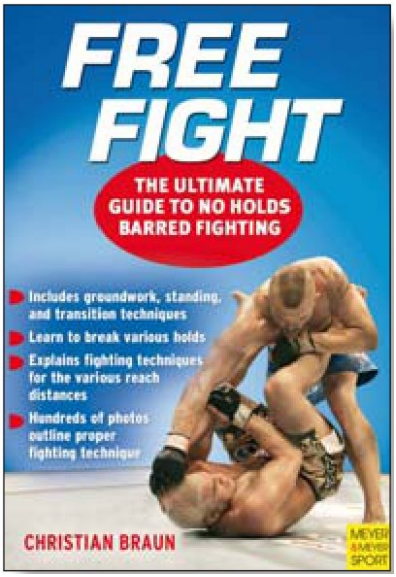
# Bìa sau & Giới thiệu sách

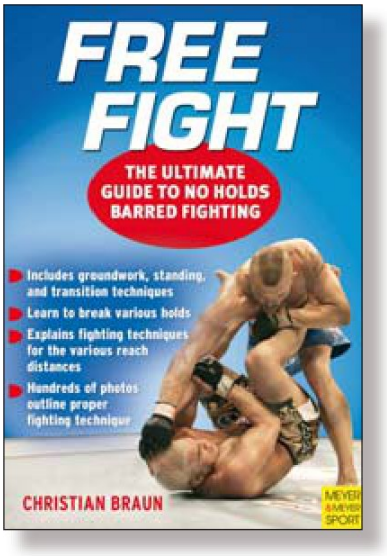
*Back Cover & Book Promotion*

Christian Braun — Fitness for Fighters (Thể lực cho võ sĩ)

Thể lực là điều thiết yếu để thành công trong võ thuật. Người tập võ phải có cơ thể dẻo dai và khả năng phản ứng nhanh, phải có thể trạng và sức mạnh đủ để thực hiện các động tác nâng và quật, đồng thời cần có sức bền và khả năng phối hợp tốt.

360 trang, in toàn màu, 1.484 ảnh. Bìa mềm, 6 ½” x 9 ¼”. ISBN: 9781841262796. 19,95 USD.




Christian Braun — Free Fight: The Ultimate Guide to No-Holds-Barred Fighting (Hướng dẫn tối hậu về đấu tự do không hạn chế)

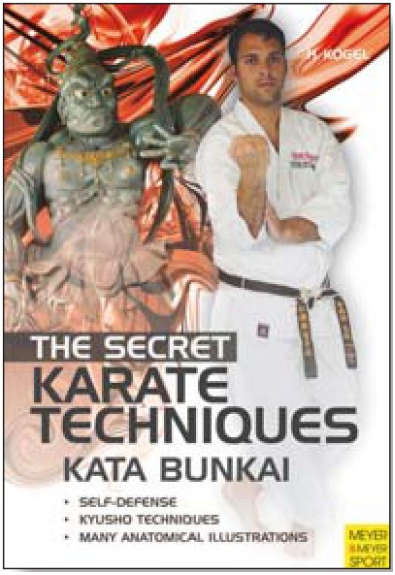
Trong giới võ thuật, Free Fight hay Mixed Martial Arts (đấu tự do không hạn chế) ngày càng trở nên phổ biến. Christian Braun chỉ cho bạn một con đường thực tế để duy trì và nâng cao cơ hội của mình trong đấu tự do. Sách bao gồm các kỹ thuật thuộc mọi môn

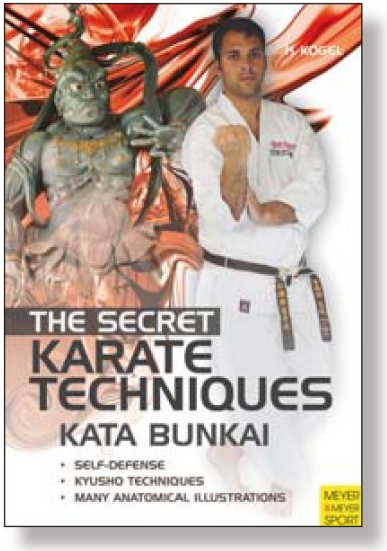
phái và mọi trình độ.

352 trang, in toàn màu, 1.258 ảnh. Bìa mềm, 6 ½” x 9 ¼”. ISBN: 9781841262178. 19,95 USD.

Xem thêm sách tại

www.m-m-sports.com

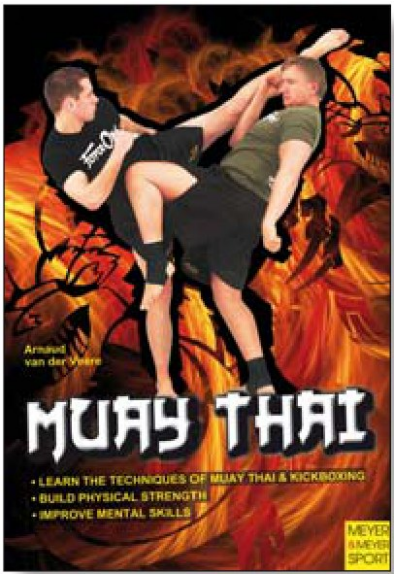


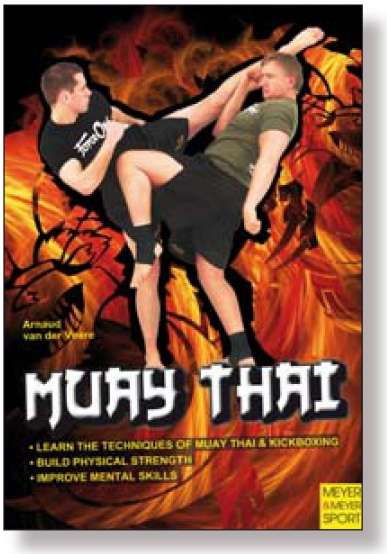




Helmut Kogel — The Secret Karate Techniques: Kata Bunkai (Những kỹ thuật karate bí truyền: Kata bunkai)

Những khía cạnh đa dạng của karate chỉ trở nên rõ ràng với người học karate sau nhiều năm tập luyện chuyên sâu và nghiên cứu cội nguồn võ thuật Okinawa. Cuốn sách này dẫn bạn qua nền tảng lý thuyết, bối cảnh lịch sử và phần thực hành của những kỹ thuật được gọi là bí truyền.

248 trang, in toàn màu, 486 ảnh, 3 hình minh họa. Bìa mềm, 6 ½” x 9 ¼”. ISBN: 9781841262895. E-Book: 9781841267562. 19,95 USD.




Arnaud van der Veere — Muay Thai

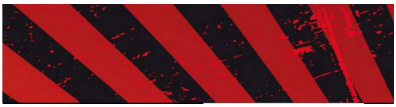
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản của môn thể thao đầy thử thách Muay Thai. Hãy học các kỹ thuật và hiểu cách áp dụng chúng. Nhiều bài tập bảo đảm một chương trình luyện tập đa dạng và thú vị. Ngoài việc rèn luyện toàn thân, môn thể thao này còn nâng cao nhận thức cá nhân, sức bền và khả năng kiểm soát thân thể.

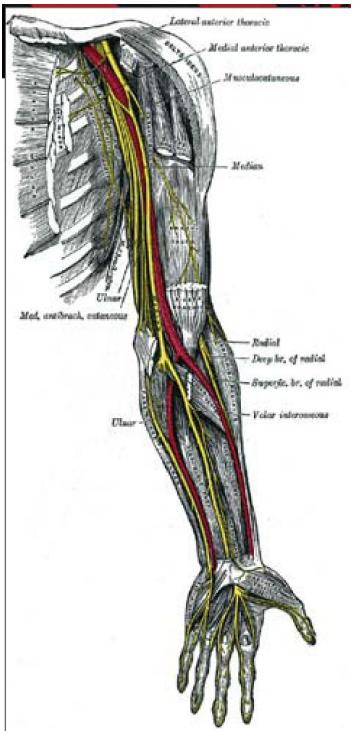
192 trang, in toàn màu, 700 ảnh. Bìa mềm, 6 ½” x 9 ¼”. ISBN: 9781841263281. E-Book: 9781841264165. 18,95 USD.

Tất cả sách đều có bản E-book.

– an toàn & thân thiện với người dùng

trực tuyến · E-Mail · www.m-m-sports.com · sales@m-m-sports.com






## NÁCH

Nách là vùng trên cơ thể người nằm ngay dưới khớp nối cánh tay với vai, được giới hạn phía trước bởi cơ ngực, phía sau bởi cơ lưng và phía trong bởi lồng ngực. Nó nằm dưới da. Các nhánh của đám rối cánh tay, cụ thể là dây thần kinh giữa, dây thần kinh trụ và dây thần kinh quay, đều có thể tìm thấy ở nách. Những dây thần kinh này chạy suốt toàn bộ chi trên.

Hiệu ứng: Đau thần kinh (xem phần trình bày trong Dẫn nhập).

Bình luận về cách dùng: Như mọi điểm thần kinh, mức độ nhạy cảm cũng như hiệu quả đạt được tùy từng người; nách lại tương đối ít khi lộ ra, hơn nữa, như mọi mục tiêu trên thân, thường được quần áo che chở tốt.

www.m-m-sports.com

## VỀ CUỐN SÁCH

Mọi động tác trong võ thuật và tự vệ đều nhằm tìm ra điểm yếu của đối thủ và dùng chúng để cuối cùng khống chế và khuất phục hắn.

Dù hiểu biết về thể trạng con người gần đây đã tăng lên, phần mô tả các kỹ thuật đấm và ấn trong hầu hết sách võ thuật vẫn chỉ tập trung vào việc gây ra “đau, liệt, chết”. Những giải thích chính xác về tác động của chúng thì thiếu, hoặc chỉ được đưa ra ở mức tinh thần. Thế nhưng, hiểu được tác động từ hành động của mình phải là tâm điểm của bất kỳ người tập võ nào có ý thức trách nhiệm. “Kyusho” cung cấp thông tin chi tiết về các điểm tấn công trên cơ thể người và tầm quan trọng của hệ thống điểm ấn trong võ thuật. Với cách tiếp cận đó, cuốn sách mang đến cho mọi người tập võ cơ hội mở rộng hiểu biết về cơ thể người và về tác động của hệ thống điểm ấn lên nó.

ISBN 978-1-84126-361-8

19,95 USD / 14,95 £ · www.m-m-sports.com